



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai
**PROMOSI KESEHATAN
DI KOMUNITAS**

Supriadi • Orisinal • Dwi Elka Fitri
Berta Afriani • Syahrul • Arriani Indrastuti
Syaiful • Sunarto

Editor: Moch. Maftuchul Huda



BUNGA RAMPAI: PROMOSI KESEHATAN DI KOMUNITAS

Penulis:

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Orisinal, SKM., M.Kes.

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

Berta Afriani, SKM., M.Kes.

Syahrul SKM., M.Kes.

Arriani Indrastuti, S.KM., M.Kes.

Syaiful, Skep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Sunarto, S.ST., Ners., M.Kes.

Editor:

Dr. Ns. Moch. Maftuchul Huda, M.Kep., Sp.Kom.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Promosi Kesehatan Di Komunitas

Penulis: Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Orisinal, SKM., M.Kes.

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

Berta Afriani, SKM., M.Kes.

Syahrul, SKM., M.Kes.

Arriani Indrastuti, S.KM., M.Kes.

Syaiful, Skep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Sunarto, S.ST., Ners., M.Kes.

Editor: Dr. Ns. Moch. Maftuchul Huda, M.Kep., Sp.Kom.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-01-5

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Dalam dunia yang semakin kompleks, promosi kesehatan di komunitas menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Buku ini hadir untuk memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kesehatan di tingkat komunitas, dengan memfokuskan perhatian pada peran aktif perawat komunitas, pengembangan materi edukasi, serta strategi kreatif yang dapat diterapkan untuk memperbaiki perilaku hidup sehat.

Dimulai dengan pendekatan pendidikan kesehatan untuk masyarakat berisiko, buku ini memberikan panduan tentang bagaimana menyusun dan menyampaikan materi yang relevan untuk kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Pendekatan yang tepat akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Peran perawat komunitas dalam meningkatkan perilaku hidup sehat juga merupakan topik penting yang dibahas dalam buku ini. Perawat komunitas memiliki peran sentral dalam membimbing masyarakat untuk menjalani pola hidup yang sehat melalui konseling, edukasi, serta intervensi yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat setempat.

Lebih jauh lagi, buku ini mengeksplorasi pengembangan materi edukasi visual dalam promosi kesehatan, yang menjadi alat efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan menggunakan media visual yang menarik, informasi kesehatan bisa disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat. Buku ini juga menyoroti strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat di komunitas, yang mencakup penggunaan berbagai platform dan metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kampanye yang disusun dengan pendekatan kreatif dapat menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gaya hidup sehat.

Tak kalah pentingnya adalah promosi kesehatan mental di komunitas, di mana buku ini membahas bagaimana perawat dapat berperan dalam mengurangi stigma seputar gangguan mental. Kesehatan mental yang sehat berperan besar dalam kualitas hidup masyarakat, dan penting bagi tenaga medis untuk memberikan dukungan serta pemahaman yang tepat mengenai isu ini.

Dengan hadirnya layanan kesehatan mobile, buku ini juga mengupas bagaimana layanan kesehatan yang dapat dijangkau langsung ke masyarakat menjadi salah satu

solusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kesehatan di berbagai komunitas.

Selain itu, buku ini menggali kampanye kesehatan melalui kegiatan sosial di masyarakat, yang merupakan salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat secara langsung dengan mengintegrasikan kegiatan sosial yang relevan dengan isu kesehatan. Terakhir, peran relawan dalam mendukung promosi kesehatan di komunitas juga menjadi topik yang dibahas dengan mendalam. Relawan memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi masyarakat, membantu melaksanakan program kesehatan, dan memberikan edukasi yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam perilaku masyarakat.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi tenaga medis, khususnya perawat, serta masyarakat umum yang ingin meningkatkan kualitas kesehatan di komunitas mereka. Kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan panduan dalam mewujudkan komunitas yang lebih sehat, kuat, dan tangguh. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENDEKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT BERISIKO 1

Dr. Drs. Supriadi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kom.	1
A. Pendahuluan	1
B. Masyarakat Berisiko Tinggi.....	3
C. Pendekatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Risiko Tinggi.....	8
D. Indikator Keberhasilan Pendekatan Pendidikan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Tinggi	30
E. Tantangan dan Solusi Pendidikan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Tinggi	31
F. Kesimpulan.....	33
G. Referensi	34
H. Glosarium	36

CHAPTER 2 PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP SEHAT 39

Orisinal. SKM., M.Kes.	39
A. Pendahuluan	39
B. Perawat Komunitas.....	40
C. Perilaku Hidup Sehat	43
D. Peran Perawat Komunitas Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat.....	49
E. Kesimpulan.....	51
F. Referensi	52

CHAPTER 3 PENGEMBANGAN MATERI EDUKASI VISUAL DALAM PROMOSI KESEHATAN 53

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.	53
A. Pendahuluan/Prolog	53
B. Konsep Media Visual.....	54
C. Pengembangan Materi Edukasi Visual	57
D. Simpulan	71
E. Referensi	71

CHAPTER 4 STRATEGI KREATIF DALAM KAMPANYE HIDUP SEHAT DI KOMUNITAS	77
Berta Afriani, SKM., M.Kes.....	77
A. Pendahuluan/Prolog	77
B. Pentingnya Hidup Sehat dalam Masyarakat Modern.....	78
C. Tantangan dalam Mempromosikan Gaya Hidup Sehat	79
D. Komunitas dalam Kesehatan	81
E. Pentingnya Kampanye Hidup Sehat di Komunitas.....	82
F. Tujuan Kampanye Hidup Sehat di Komunitas.....	84
G. Manfaat Kampanye Hidup Sehat di Komunitas.....	84
H. Strategi Kreatif dalam Kampanye	85
I. Simpulan	87
J. Referensi	88
K. Glosarium	92

CHAPTER 5 PROMOSI KESEHATAN MENTAL DI KOMUNITAS: PERAN PERAWAT DALAM MENGURANGI STIGMA.....	95
Syahrul, SKM., M.Kes.....	95
A. Pendahuluan	95
B. Bentuk-Bentuk Stigma Kesehatan Mental	98
C. Konsep Stigma dalam Kesehatan Mental.....	101
D. Peran Perawat dalam Mengurangi Stigma	103
E. Strategi Promosi Kesehatan Mental di Komunitas	108
F. Tantangan dan Solusi	110
G. Kesimpulan.....	112
H. Referensi	115

CHAPTER 6 MENINGKATKAN AKSES KESEHATAN MELALUI LAYANAN KESEHATAN MOBILE DI KOMUNITAS	117
Arriani Indrastuti, S.KM., M.Kes.....	117
A. Pendahuluan	117
B. Metode untuk mengukur keterjangkauan pelayanan kesehatan :.....	118
C. Penerapan Layanan Kesehatan Mobile	119
D. Kesimpulan.....	128
E. Referensi	129
F. Glosarium	130

CHAPTER 7 KAMPANYE KESEHATAN MELALUI KEGIATAN SOSIAL DI MASYARAKAT	131
Syaiful, S.Kep., Ns., MPd., M.Kes.....	131
A. Pendahuluan	131
B. Konsep Kampanye Kesehatan.....	132
C. Referensi	138
D. Glosarium	138

CHAPTER 8 PERAN RELAWAN DALAM Mendukung Promosi KESEHATAN DI KOMUNITAS.....	139
Sunarto, S.ST., Ners., M.Kes.....	139
A. Pendahuluan/Prolog	139
B. Perubahan sosial yang mendukung promosi kesehatan	139
C. Promosi Kesehatan.....	141
D. Pengembangan Promosi Kesehatan	147
E. Hambatan dalam Promosi Kesehatan Komunitas.....	147
F. Kesimpulan.....	148
G. Referensi	148
H. Glosarium	150
PROFIL PENULIS	151

/

CHAPTER 1

PENDEKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT BERISIKO

Dr. Drs. Supriadi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kom.

A. Pendahuluan

Masyarakat berisiko tinggi, seperti lansia, individu dengan penyakit kronis, atau kelompok dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, sangat memerlukan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Di beberapa wilayah, masyarakat menganggap keliru terkait pendidikan kesehatan. melalui Pendidikan Kesehatan klien dapat meningkat kepatuhannya terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Pendidikan kesehatan membantu individu memahami pentingnya pengobatan, terutama pada penyakit kronis, sehingga mencegah komplikasi.

Program pendidikan kesehatan untuk pasien hipertensi di Brasil menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan hingga 56%, serta penurunan tekanan darah yang signifikan (Barbosa et al., 2019). Pendidikan kesehatan memainkan peran penting dalam mencegah kondisi yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat berisiko tinggi seperti munculnya penyakit kronis. Sebuah penelitian di Inggris menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan diabetes mengurangi risiko komplikasi serius (seperti amputasi atau kebutaan) hingga 32% dalam waktu 5 tahun. (NICE, 2021).

Pendidikan kesehatan tidak hanya bermanfaat secara medis, tetapi juga mengurangi tekanan ekonomi pada individu dan sistem kesehatan. Penelitian oleh CDC menemukan bahwa setiap \$1 yang diinvestasikan dalam pendidikan kesehatan komunitas menghasilkan penghematan hingga \$4 pada biaya pengobatan jangka panjang. (CDC, 2020). Edukasi kesehatan membantu mengubah perilaku berisiko menjadi langkah pencegahan yang lebih aman, program pendidikan HIV/AIDS di Afrika Selatan mengurangi infeksi baru hingga 28% di antara populasi muda berisiko tinggi dalam waktu 3 tahun. (UNAIDS, 2021). Edukasi masyarakat berisiko tinggi mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Studi di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang mengikuti program edukasi kesehatan komunitas memiliki risiko lebih rendah terkena depresi dan peningkatan aktivitas fisik (2020).

Dalam kondisi penyakit menular, pendidikan kesehatan sangat penting dalam mengelola penyebaran penyakit menular, terutama di populasi berisiko tinggi

seperti lansia atau individu dengan komorbiditas. Selama pandemi COVID-19, kampanye edukasi kesehatan yang masif di Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan, yang menyebabkan penurunan kasus hingga 25% dalam beberapa wilayah. (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pendidikan Kesehatan untuk masyarakat berisiko tinggi membantu memahami faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi mereka, seperti pola makan, kurang aktivitas fisik, atau penggunaan zat berbahaya. Kelompok berisiko tinggi sering menghadapi tantangan dalam mengikuti rencana pengobatan, dan pendidikan kesehatan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengobatan rutin. Pendidikan kesehatan yang efektif mencegah komplikasi dan rawat inap, yang pada akhirnya mengurangi biaya kesehatan baik untuk individu maupun sistem Kesehatan, sebagai contoh bahwa program pendidikan Kesehatan diabetes mengurangi pengeluaran medis sebesar 10-20%. (CDC, 2020).

Pendidikan kesehatan juga meningkatkan kepercayaan diri individu dalam mengelola kondisi mereka, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis. (APA, 2021), melaporkan bahwa dukungan informasi dan edukasi meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Kelompok berisiko tinggi sering berperan dalam keluarga dan komunitas. Dengan edukasi yang memadai, mereka dapat menjadi agen perubahan untuk lingkungan sekitarnya. Pendidikan kesehatan bagi masyarakat berisiko tinggi menjadi hal yang penting, karena melalui pendidikan kesehatan masyarakat terbantu untuk memahami faktor risiko dan tindakan pencegahan terhadap penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. (WHO, 2022). Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih sadar terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit, sehingga mempercepat intervensi medis dan meningkatkan kualitas hidup (CDC, 2021). Dengan mencegah penyakit melalui edukasi, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dapat ditekan, misalnya kampanye anti merokok telah terbukti mengurangi beban ekonomi akibat penyakit paru-paru (WHO, 2022). Pendidikan kesehatan mendorong perubahan perilaku seperti berhenti merokok, meningkatkan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan lingkungan yang mendukung hidup sehat (UNICEF, 2020), serta masyarakat yang mendapatkan edukasi kesehatan cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik, lebih produktif, dan hidup lebih lama (HPHR, 2021).

Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan angka penyakit dan kematian terkait penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. (WHO, 2022), selain itu Berkman et al., 2019 mengemukakan bahwa orang dengan pemahaman kesehatan rendah cenderung mengabaikan gejala awal, sehingga membutuhkan perawatan darurat yang lebih mahal atau

menjadikan biaya kesehatan yang Lebih tinggi, serta pemahaman kesehatan yang rendah memengaruhi kualitas hidup, termasuk mobilitas, kemampuan bekerja, dan keterlibatan sosial.

B. Masyarakat Berisiko Tinggi

Masyarakat berisiko tinggi dalam konteks kesehatan merujuk pada individu atau kelompok orang yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan tertentu dibandingkan dengan populasi umum.

1. Risiko dalam Kesehatan

Risiko dalam kesehatan manusia merujuk pada kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit akibat paparan dari faktor-faktor tertentu. Risiko ini ditentukan oleh interaksi antara individu dan lingkungan, termasuk faktor genetik, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

a. Komponen Risiko dalam Kesehatan

Risiko dalam kesehatan manusia dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama, yaitu paparan, kerentanan, dan konsekuensi.

1) Paparan (*Exposure*)

Paparan adalah kontak dengan faktor yang dapat memicu masalah kesehatan. Paparan mengacu pada sejauh mana individu terlibat atau kontak dengan faktor risiko yang dapat memicu masalah kesehatan. Faktor ini mencakup: 1) Faktor fisik, seperti polusi udara, radiasi, dan kebisingan, 2) Faktor biologis, meliputi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, dan parasit, 3) Faktor kimia, seperti zat beracun dalam makanan, air, atau lingkungan kerja, serta 4) Faktor sosial dan perilaku, yakni gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olah raga, dan diet tidak seimbang. Contoh paparan asap rokok meningkatkan risiko penyakit paru-paru dan penyakit jantung. (WHO, 2023).

2) Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan merupakan respons atau sejauh mana individu rentan terhadap efek paparan. Kerentanan merujuk pada kemampuan individu atau populasi untuk menghadapi atau melawan efek negatif dari paparan terhadap faktor risiko. Kerentanan dipengaruhi oleh: 1) Faktor genetik, seperti penyakit diabetes dan kanker yang juga terkait dengan riwayat keluarga. 2) Usia, seperti lanjut usia dan anak-anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit menular dan kronis, berkaitan dengan kondisi tubuhnya, 3) Status sosial ekonomi, seperti orang dengan pendidikan rendah atau miskin, lebih rentan terkena penyakit, karena pemahaman dan akses terbatas ke layanan

Kesehatan, dan 4) Status kesehatan sebelumnya, seperti orang dengan kondisi medis sebelumnya (misalnya hipertensi) lebih rentan terhadap komplikasi. Contoh pada lansia dengan gangguan imun lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. (CDC, 2022).

3) Konsekuensi (*Consequence*)

Konsekuensi adalah dampak negatif yang mungkin timbul, seperti penyakit atau kecacatan. Konsekuensi ini terjadi ketika individu mengalami paparan terhadap faktor risiko dan tidak dapat mengatasinya. Konsekuensi dapat berupa: 1) Dampak Fisik, seperti penyakit, cedera, atau kematian, 2) Dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, dan gangguan mental akibat kondisi kronis atau situasi sosial yang buruk, 3) Dampak ekonomi, seperti biaya perawatan kesehatan yang tinggi, kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan, serta 4) Dampak sosial, seperti stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit tertentu, misalnya terhadap pasien HIV/AIDS. Contohnya, seseorang yang terkena diabetes yang tidak diobati dapat mengalami komplikasi serius, konsekuensinya mengalami komplikasi, seperti seperti gagal ginjal dan penyakit jantung. (UNDP, 2023).

b. Jenis Risiko dalam Kesehatan

Risiko dalam kesehatan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan sumber dan sifat penyebabnya.

1) Risiko Biologis

Risiko biologis melibatkan paparan terhadap organisme hidup yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Sumber risiko, diantaranya: 1) Patogen, seperti virus, misalnya penyakit COVID-19, bakteri, misalnya penyakit *E. coli*, dan parasit, misalnya penyakit malaria. 2) Vektor Penyakit, seperti nyamuk yang menyebarkan penyakit demam berdarah dan malaria, 3) Produk Biologis, seperti makanan dan air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme, seperti infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza, Tifus abdominalis akibat bakteri salmonella typhi dalam air minum yang terkontaminasi. (WHO, 2023).

2) Risiko Lingkungan

Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor dalam lingkungan fisik yang dapat memengaruhi kesehatan. Sumber risiko lingkungan fisik tersebut, adalah: 1) Polusi Udara, seperti emisi kendaraan bermotor dan asap industri, 2) Polusi air, seperti limbah industri yang mencemari air, 3) Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, dan 4) Radiasi, seperti radiasi ultraviolet dari sinar matahari dan radiasi nuklir. Contohnya penyakit

pernapasan seperti asma akibat polusi udara, keracunan logam berat seperti merkuri dalam ikan yang terkontaminasi. (UNEP, 2023).

3) Risiko Perilaku

Risiko ini terkait dengan pilihan gaya hidup dan perilaku individu yang memengaruhi kesehatan. Sumber risiko perilaku, adalah: 1) Merokok, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit jantung, 2) Pola makan tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam, kurangnya aktivitas fisik, yang dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular, Penggunaan alkohol dan narkoba, yang menyebabkan gangguan hati, kecanduan, dan masalah mental. Contoh kasus, terjadinya Diabetes tipe 2 akibat pola makan tinggi gula dan kurang olahraga, serta kerusakan hati akibat kecanduan alkohol. (CDC, 2022).

4) Risiko Sosial-Ekonomi

Risiko ini muncul dari kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya penting. Sumber risiko Kesehatan terkait sosial ekonomi, adalah: 1) Kemiskinan, yang menjadikan akses terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan, 2) Pendidikan Rendah, yang berkaitan langsung dengan kurangnya pengetahuan tentang praktik kesehatan yang baik, 3) Kesenjangan akses, seperti distribusi layanan kesehatan yang tidak merata, dan 4) Diskriminasi dan marginalisasi, yakni perlakuan tidak adil yang menyebabkan pengucilan sosial. Contohnya seperti adanya malnutrisi pada anak-anak di daerah miskin, dan penyakit menular yang menyebar lebih cepat di daerah dengan kondisi sanitasi buruk. (World Bank, 2023).

2. Kelompok Masyarakat Berisiko

Masyarakat berisiko tinggi terhadap kesehatan merupakan kelompok individu atau komunitas yang memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah kesehatan dibandingkan dengan populasi lainnya. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, kondisi kesehatan dan perilaku. Masalah kesehatan tidak muncul secara terpisah, melainkan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi.

a. Faktor sosial-ekonomi

Status sosial ekonomi memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat, mereka memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, baik karena kendala finansial, jarak tempuh, maupun kurangnya pemahaman. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung tinggal di lingkungan yang kurang sehat, dengan tingkat polusi lebih tinggi, perumahan yang padat, dan sanitasi yang

buruk, dan kondisi ini meningkatkan risiko penyakit menular dan kronis (Marmot, M, 2005),

Pendidikan memengaruhi pemahaman tentang kesehatan, seperti pentingnya pola makan seimbang, olahraga, dan pengelolaan stres. Individu atau masyarakat dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap penyakit karena kurangnya kesadaran kesehatan (Cutler, D.M., & Lleras-Muney, A, 2006).

Kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi menciptakan stres kronis yang meningkatkan risiko gangguan mental dan penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung. Adler, N.E., & Ostrove, J.M. (1999). Kondisi sosial ekonomi memengaruhi pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan seperti merokok dan konsumsi alkohol, yang semuanya berkaitan dengan kondisi kesehatan jangka panjang (Wilkinson, R.G., & Marmot, M, 2003),

Kondisi masyarakat dengan pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, dan tidak memiliki asuransi kesehatan, akan sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya, komunitas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) atau desa tertinggal sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan karena jarak dan kondisi geografis yang jauh dan infrastruktur yang kurang atau tidak memadai. (Kemkes RI, 2021). Ketimpangan sosial ekonomi menjadi determinan sosial yang signifikan terhadap kesehatan, sehingga upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat merupakan langkah penting untuk mengurangi kesenjangan kesehatan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam mempengaruhi munculnya masalah kesehatan pada individu dan masyarakat. Lingkungan mencakup elemen fisik, biologis, sosial, dan budaya yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan. Paparan terhadap polutan seperti partikel debu, gas beracun, dan asap kendaraan dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis (WHO, 2021). Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus (UNICEF, 2020).

Pemanasan global memicu peningkatan suhu dan bencana alam yang memperburuk kondisi kesehatan masyarakat (IPCC, 2022, Intergovernmental Panel on Climate Change). Lingkungan yang mendukung produksi pangan sehat berkontribusi pada gizi yang baik dan mencegah malnutrisi (FAO, 2021, Food and Agriculture Organization). Lingkungan dengan banyak genangan air mendukung perkembangbiakan nyamuk, meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah (CDC, 2022).

Kemiskinan sering dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang buruk, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan risiko penyakit yang lebih tinggi (UNDP, 2021). Budaya yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat (WHO, 2022). Faktor-faktor lingkungan ini saling terkait dan dapat diperbaiki melalui intervensi pemerintah, kesadaran masyarakat, dan upaya global untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Masyarakat yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi, rawan bencana alam atau gempa, dan lingkungan tidak sehat berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, seperti kondisi rumah yang tidak layak huni, karena sanitasi buruk, air bersih terbatas. Contohnya masyarakat pesisir dan urban, miskin yang tinggal di kawasan kumuh dan sering terpapar polusi industri, sangat berisiko munculnya masalah penyakit berbasis lingkungan. (UNEP, 2023).

c. Faktor Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan (WHO, 1948). Kesehatan mencakup aspek holistik, termasuk kesejahteraan emosional dan kemampuan sosial seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif, sedangkan sehat adalah kondisi di mana tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam keadaan optimal, bebas dari penyakit atau gangguan. Secara medis, sehat diukur dengan berbagai indikator seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kebugaran fisik. Adanya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan kesehatan mental, HIV/AIDS, anak-anak yang mengalami malnutrisi atau stunting, serta lansia dengan berbagai penyakit degeneratif menjadikan kualitas hidup mereka rendah (WHO, 2023).

d. Faktor Perilaku

Faktor perilaku memiliki peran penting dalam memengaruhi munculnya masalah kesehatan pada individu dan masyarakat. Beberapa aspek perilaku yang berkontribusi terhadap kesehatan meliputi pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan manajemen stres. Pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Menurut WHO (2022), pola makan yang kaya akan buah, sayur, dan serat dapat mengurangi risiko penyakit kronis.

Kurangnya aktivitas fisik dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan hipertensi. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2021) melaporkan bahwa aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko kematian dini. Merokok merupakan faktor risiko utama berbagai penyakit seperti kanker

paru-paru dan penyakit pernapasan kronis. Menurut laporan *Global Burden of Disease* (GBD, 2020), merokok menjadi salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat memicu penyakit hati, gangguan mental, dan kecelakaan lalu lintas. WHO, (2021) mencatat bahwa konsumsi alkohol yang tidak terkendali menyumbang jutaan kematian setiap tahun.

Stres kronis dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Teknik manajemen stres seperti meditasi dan terapi kognitif dapat membantu mengurangi dampak negatif stres terhadap kesehatan (APA, 2022). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perilaku individu memiliki dampak besar terhadap status kesehatan masyarakat, sehingga perubahan gaya hidup sehat menjadi kunci dalam pencegahan berbagai masalah kesehatan.

Masyarakat dengan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, atau pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta perilaku seksual berisiko tanpa pelindung merupakan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi munculnya penyakit berbasis perilaku. Contoh, remaja yang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba dan seks bebas berisiko tinggi terkena penyakit HIV/AIDS, Infeksi menular seksual (IMS), dan lain sebagainya (CDC, 2023).

C. Pendekatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Risiko Tinggi

Upaya menanggulangi masalah kesehatan pada individu atau masyarakat risiko memerlukan pendekatan holistik yang mencakup intervensi di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan termasuk pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan sangat penting bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah kesehatan, seperti lansia, penderita penyakit kronis, dan mereka yang hidup dalam lingkungan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan kondisi kesehatan yang mereka hadapi, termasuk informasi tentang gejala, faktor risiko, dan tindakan pencegahan, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mengurangi beban ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup.

1. Konsep Pendidikan Kesehatan

Pendekatan pendidikan kesehatan yang efektif, khususnya terhadap masyarakat berisiko tinggi, berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.

a. Pengertian Pendidikan Kesehatan

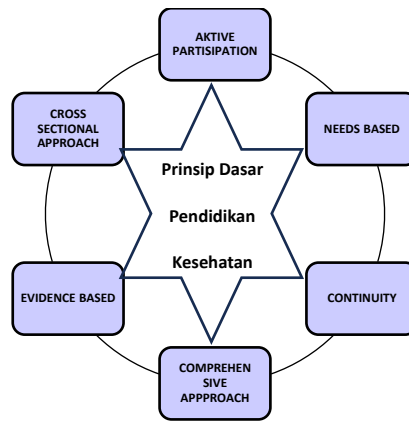
Pendidikan kesehatan merupakan proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu, keluarga, dan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui perubahan perilaku positif. Beberapa ahli mengemukakan pengertian pendidikan kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku individu, keluarga, atau masyarakat dalam meningkatkan kesehatan melalui kegiatan belajar mengajar, sedangkan menurut Green & Kreuter (2005) pendidikan kesehatan merupakan proses terencana untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan kesehatan agar individu atau masyarakat dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

WHO (1998) menyatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses yang dirancang untuk memampukan orang belajar bagaimana menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri melalui pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan Azwar (2013) mengemukakan pendidikan kesehatan merupakan usaha untuk memberikan pengalaman belajar yang mengarah pada perubahan perilaku masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka disepakati bahwa pendidikan kesehatan merupakan proses pembelajaran terencana (Notoatmodjo, Green & Kreuter), adanya perubahan perilaku menuju hidup sehat (Notoatmodjo & Azwar), upaya pengembangan keterampilan untuk menjaga kesehatan (WHO, Green & Kreuter), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Azwar, WHO). Dengan demikian, pendidikan kesehatan bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga proses membentuk sikap dan keterampilan untuk menciptakan perilaku hidup sehat yang berkelanjutan.

b. Prinsip Dasar Pendidikan Kesehatan

Proses pendidikan kesehatan akan berjalan dengan efektif, bila dilaksanakan melalui prinsip dasar dari pendidikan kesehatan, yaitu:



Gambar. 1.1 Prinsip Dasar Pendidikan Kesehatan

1) *Active Participation* (Partisipasi aktif)

Individu dan komunitas harus dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan kesehatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelibatan penting, untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program Kesehatan, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai contoh program imunisasi yang sukses melibatkan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan kader kesehatan, dan kampanye kesadaran. (Green & Kreuter, 2005).

2) *Needs-Based* (Kesesuaian dengan kebutuhan)

Program pendidikan kesehatan harus dirancang sesuai dengan masalah kesehatan dan kebutuhan khusus dari kelompok sasaran. Setiap komunitas memiliki karakteristik unik, sehingga materi dan metode pendidikan harus relevan agar lebih efektif. Contohnya, penyuluhan gizi untuk ibu hamil di daerah pedesaan harus disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat. (Nutbeam, 2000).

3) *Continuity* (Berkelanjutan)

Pendidikan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan perubahan perilaku yang langgeng. Pendidikan kesehatan bukanlah intervensi sekali jadi, tetapi proses berkelanjutan untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Perubahan perilaku membutuhkan waktu dan pengulangan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Contohnya kampanye anti-merokok yang dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai media dan kegiatan komunitas. (WHO, 1986).

4) *Comprehensive Approach* (Pendekatan Komprehensif)

Mencakup upaya promotif (promosi kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan). Hal ini penting, mengingat penyakit dan masalah kesehatan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk memastikan kesehatan optimal. Contohnya program HIV/AIDS meliputi pendidikan tentang pencegahan, akses ke pengobatan, dan dukungan bagi penderita untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi. (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008).

5) *Evidence-Based* (Berbasis Ilmiah)

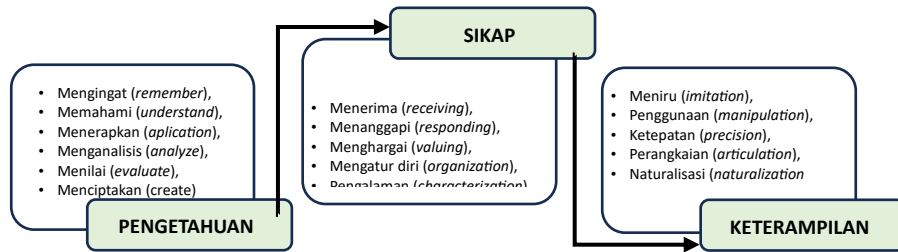
Materi dan metode yang digunakan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan memastikan efektivitas intervensi kesehatan. Contohnya pada kegiatan kampanye cuci tangan, menggunakan informasi dari penelitian yang membuktikan bahwa cuci tangan dapat mengurangi risiko infeksi penyakit menular. (WHO, 2009).

6) *Cross Sectional Approach* (Pendekatan Lintas Sektor)

Pendidikan kesehatan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, sehingga kerja sama antar sektor diperlukan untuk intervensi yang komprehensif. Sebagai contoh dalam program pencegahan stunting melibatkan sektor kesehatan terkait penyuluhan gizi, sektor pendidikan terkait pendidikan gizi di sekolah, dan sektor sosial terkait bantuan pangan bagi keluarga miskin. (WHO, 2010).

c. Komponen Utama Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu atau kelompok dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. WHO (1986) mengemukakan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses yang mengajak individu untuk mempelajari tentang kesehatan dan cara menjaga serta meningkatkan kesehatannya. Green dan Kreuter (2005) menyebutkan tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku individu dan komunitas agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Pendidikan kesehatan menekankan pentingnya perubahan perilaku untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga perubahan perilaku menjadi fokus utama dalam pendidikan kesehatan. Perilaku yang dimaksud adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan.

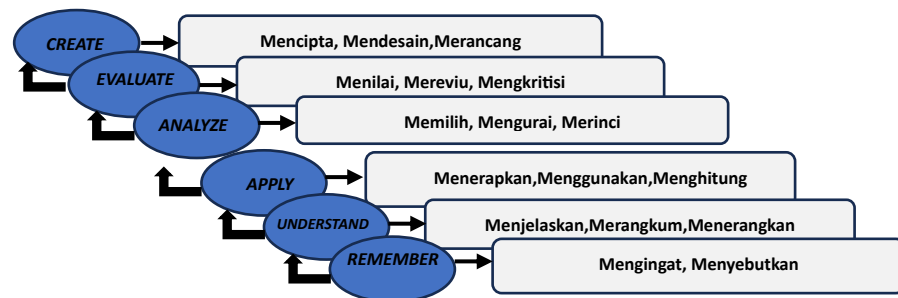


Gambar 1.2 Komponen Utama Pendidikan Kesehatan

1) Pengetahuan

Pendidikan Kesehatan bertujuan meningkatkan pemahaman individu tentang kesehatan, penyakit, dan praktik kesehatan yang baik. Hal ini mencakup informasi tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*) untuk dapat menjalankan hidup sehat.

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan (H. L Bloom, revisi Anderson, dkk, 2001), yaitu: mengingat (*remember*), memahami (*understand*), menerapkan (*aplication*), menganalisis (*analyze*), dan menilai (*evaluate*), berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi terhadap suatu materi atau obyek berdasarkan kriteria atau standar yang ada, dan menciptakan (*create*).



Gambar 1.3 Ranah Kognitif (Bloom & Anderson, dkk, 2001)

a) Mengingat (*Remember*)

Tingkat dasar ini mencakup kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contoh aktivitasnya meliputi menghafal fakta, definisi, dan konsep tentang suatu penyakit yang ada di masyarakat.

b) Memahami (*Understand*)

Pada tingkat ini, individu dapat menjelaskan makna informasi dan memahami konsep dengan baik. Contoh aktivitasnya adalah merangkum, menginterpretasi, atau menjelaskan ide-ide.

c) Menerapkan (*Apply*)

Di tingkat ini, individu menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau dalam konteks yang berbeda. Contoh aktivitasnya adalah memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuannya dalam praktik.

d) Menganalisis (*Analyze*)

Pada tingkat ini melibatkan kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami bagaimana bagian tersebut saling berhubungan. Contoh aktivitasnya termasuk mengidentifikasi pola, membandingkan, dan mengklasifikasikan.

e) Menilai (*Evaluate*)

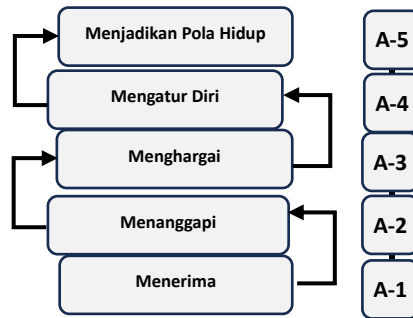
Di tingkat ini, individu dapat membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Aktivitas ini meliputi menilai argumen, mendebat, dan memberikan rekomendasi.

f) Menciptakan (*Create*)

Pada tingkat tertinggi ini melibatkan kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen berbeda untuk membentuk sesuatu yang baru. Ini mencakup merancang, menghasilkan, atau mengembangkan ide dan produk baru.

2) Sikap

Pendidikan kesehatan juga bertujuan mengubah sikap individu terhadap kesehatan. Sikap dalam pendidikan kesehatan merujuk pada pandangan, perasaan, dan reaksi individu terhadap informasi, praktik, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan. Sikap ini sangat penting karena dapat memengaruhi perilaku dan keputusan individu atau masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka dan mengakses layanan kesehatan, termasuk pengembangan motivasi untuk menjalani hidup sehat. Pendidikan kesehatan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai positif terkait Kesehatan. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek.



Gambar1.4 Ranah Affectif (Krathwahl, Bloom, Mazia, 1964)

a) Menerima (*Receiving*)

Pada tingkat ini, individu menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan memperhatikan. Mereka dapat mengenali perasaan dan pengalaman orang lain serta menunjukkan perhatian terhadap hal-hal baru. Misalnya, seorang klien yang mendengarkan dengan seksama saat petugas kesehatan menjelaskan penyakitnya.

b) Menanggapi (*Responding*)

Di tingkatan ini, individu tidak hanya menerima informasi tetapi juga memberikan respons. Mereka mulai menunjukkan partisipasi aktif, seperti bertanya, berdiskusi, atau berkontribusi dalam aktivitas kelompok. Contohnya adalah klien yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok.

c) Menghargai (*Valuing*)

Pada tingkat ini, individu mulai mengembangkan sikap positif terhadap nilai atau keyakinan tertentu. Mereka mampu menunjukkan apresiasi terhadap hal-hal yang dianggap penting, misalnya dengan memilih untuk mengikuti kegiatan yang mendukung nilai-nilai tersebut.

d) Mengatur Diri (*Organizing*)

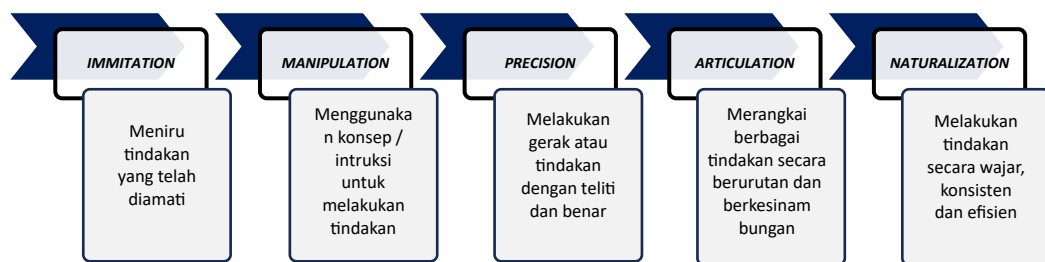
Pada tingkat ini, individu mulai mengintegrasikan berbagai nilai dan sikap dalam diri mereka. Mereka dapat mengatur prioritas dan mengelola nilai-nilai yang berbeda, menciptakan sistem nilai pribadi yang koheren. Misalnya, seorang klien yang mampu memprioritaskan waktu antara memeriksakan kesehatan diri untuk skrining dan beraktivitas sosial.

e) Pengalaman (*Characterizing*)

Tingkatan ini melibatkan pengembangan sikap yang sudah menjadi bagian integral dari kepribadian individu. Seseorang di tingkat ini menunjukkan konsistensi dalam sikap dan perilaku, serta dapat menjadi teladan bagi orang lain. Contohnya adalah individu yang selalu menunjukkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kesehatan yang diyakininya.

3) Keterampilan

Pendidikan Kesehatan bertujuan mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan praktis yang berkaitan dengan kesehatan, aspek ini menekankan pentingnya praktik langsung dalam penerapan pengetahuan dan sikap yang telah dipelajari. Dave (1967) menjelaskan tingkatan kemampuan psikomotik dalam tingkatan yaitu: meniru (*imitation*), penggunaan (*manipulation*), ketepatan (*precision*), perangkaian (*articulation*), dan naturalisasi (*naturalization*).



Gambar 1.5 Ranah Psikomotor (Dave, 1967)

a) Meniru (*Imitation*)

Pada tingkatan ini, individu belajar dengan menyalin atau mengikuti gerakan yang dilakukan oleh orang lain. Tindakan ini merupakan tahap awal, dimana seseorang mulai mengenal keterampilan melalui observasi.

b) Memanipulasi (*Manipulation*)

Setelah mampu meniru, individu mulai mengembangkan kemampuan untuk melakukan gerakan secara mandiri, meskipun mungkin belum sepenuhnya tepat. Pada tahap ini, individu berlatih melakukan keterampilan dengan bimbingan dan seringkali masih memerlukan dukungan.

c) Ketepatan (*Precision*)

Di tingkat ini, individu dapat melakukan gerakan dengan lebih akurat dan tepat. Keterampilan yang sebelumnya dipelajari mulai dilakukan dengan kontrol yang lebih baik dan konsistensi yang lebih tinggi.

d) Perangkaian (*Articulation*)

Pada tahap ini, individu sudah mampu mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan melakukan keterampilan dengan koordinasi yang lebih kompleks. Keterampilan mulai terlihat lebih lancar dan terorganisir.

e) Naturalisasi (*Naturalization*)

Tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi, dimana keterampilan menjadi otomatis dan alami bagi individu. Mereka dapat melakukan gerakan

dengan sangat efisien dan tanpa memikirkan prosesnya, sehingga dapat fokus pada aspek lain dari kegiatan atau tindakan yang dihadapi.

Dengan mengintegrasikan ketiga ranah perilaku dalam pendidikan kesehatan, maka tujuan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan akan mampu diwujudkan secara efektif.

2. Pendekatan Pendidikan Kesehatan

Ada berbagai pendekatan dalam pendidikan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan perubahan perilaku kesehatan. yaitu:

a. Model *Theory Cognitive Social*

Pendekatan *theory cognitive social* (SCT) berfokus pada perubahan dalam cara seseorang berpikir untuk mempengaruhi tindakan mereka terkait kesehatannya. Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mengubah perilaku (Bandura, A, 1986).

Model SCT menekankan pentingnya interaksi antara faktor kognitif, lingkungan dan perilaku dalam proses belajar manusia. SCT menjelaskan bagaimana faktor lingkungan, tindakan orang lain, dan pengalaman individu memengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Teori kognitif sosial menunjukkan bahwa belajar tidak hanya terjadi karena pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan, interaksi sosial, dan proses mental, serta SCT dapat digunakan untuk merancang intervensi dan menjelaskan perilaku kesehatan dengan konsep berbasis empiris.

1) Komponen utama teori kognitif sosial

a) Pembelajaran Observasional (Modeling)

Proses belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, termasuk konsekuensi dari perilaku tersebut. Ini memungkinkan seseorang belajar tanpa harus mengalami situasi tersebut secara langsung. Dalam proses pembelajaran observasional, terjadi:

(1) Perhatian (*Attention*)

Individu harus memperhatikan model atau orang yang diamati. Hal ini dipengaruhi oleh daya tarik, status, atau relevansi model.

(2) Retensi (*Retention*)

Informasi yang diperoleh disimpan dalam memori untuk digunakan di masa mendatang.

(3) Reproduksi (*Reproduction*)

Individu mencoba meniru atau mempraktikkan perilaku yang telah dipelajari.

(4) Motivasi (*Motivation*)

Motivasi untuk meniru bergantung pada penghargaan, hukuman, atau manfaat yang diantisipasi. Sebagai contoh seorang remaja yang melihat temannya tubuhnya sehat setelah rajin berolah raga, maka remaja tersebut, kemungkinan akan meniru perilaku tersebut.

b) Determinisme Resiprokal

Interaksi timbal balik antara tiga komponen, yakni: 1) individu, meliputi aspek kognitif dan biologisnya, seperti keyakinan, sikap dan emosi. 2) lingkungan, meliputi situasi sosial dan fisik yang memengaruhi individu, seperti keluarga, teman, dan budaya, serta 3) aspek perilaku, meliputi tindakan yang dilakukan oleh individu. Contohnya seorang ibu percaya bahwa ia pandai berbicara di depan masyarakat, sehingga ia berminat menjadi kader, yang kemudian membuatnya mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat dan lingkungannya.

2) Keyakinan Diri (*Self-Efficacy*)

Keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan. *Self-efficacy* mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan menghadapi tantangan. Faktor Penentu *Self-Efficacy*: 1) Pengalaman langsung, keberhasilan sebelumnya meningkatkan *self-efficacy*, sementara kegagalan dapat menurunkannya, 2) Pengalaman vikarius, melihat orang lain yang berhasil melakukan sesuatu dapat meningkatkan keyakinan diri, 3) Persuasi sosial, didorong atau diyakinkan bahwa oleh orang lain dapat memperkuat keyakinan individu, dan 4) Keadaan emosional yang positif meningkatkan *self-efficacy*, sementara kecemasan dapat menurunkannya. Contohnya: seseorang yang telah mampu disiplin dalam pengobatan tuberkulosis paru, memiliki keyakinan tinggi bahwa ia dapat menanggulangi masalah Kesehatan lainnya.

3) Proses Kognitif

Proses mental yang terlibat dalam memahami, menginterpretasi, dan membuat keputusan sebelum bertindak. Hal ini meliputi perhatian, persepsi, pemrosesan informasi, dan pemecahan masalah.

Proses Utama Kognitif, meliputi:

- a) Perhatian, yaitu memfokuskan pikiran pada informasi tertentu.
- b) Pemrosesan informasi, yaitu mengorganisasikan dan memahami informasi yang diterima.
- c) Penyimpanan memori, yaitu menyimpan informasi untuk digunakan di masa mendatang.
- d) Pengambilan Keputusan, yaitu memilih tindakan berdasarkan evaluasi informasi yang dimiliki.

Contohnya seorang lansia yang mempelajari cara merawat kondisi hipertensi, akan memikirkan langkah-langkah penyelesaiannya sebelum melakukannya.

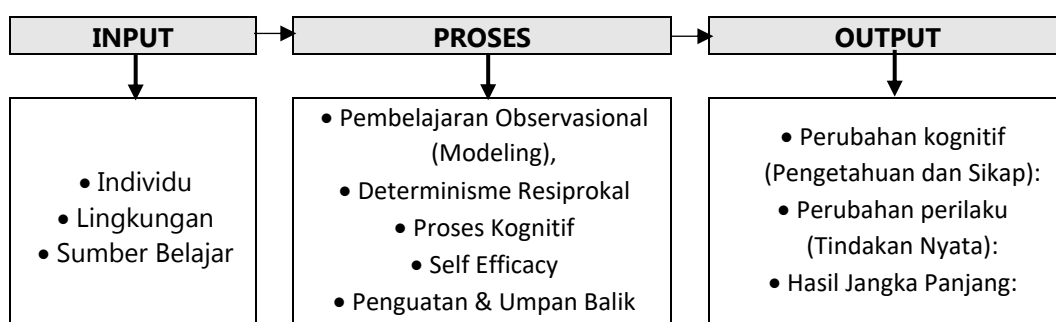
4) Penguatan dan Motivasi

Motivasi untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh penghargaan dan hukuman, baik yang dialami langsung maupun yang diamati pada orang lain. Jenis penguatan, meliputi:

- Penguatan positif, yaitu mendapatkan hadiah atau penghargaan setelah melakukan tindakan yang diinginkan.
- Penguatan negatif, yaitu menghindari situasi yang tidak menyenangkan dengan melakukan tindakan tertentu.
- Hukuman, yaitu konsekuensi negatif yang mengurangi kemungkinan perilaku tertentu diulang.

Contohnya seorang karyawan bekerja menggunakan alat pelindung diri (APD), karena tahu bahwa APD akan mencegah penyakit tertentu akibat pekerjaannya.

Berikut gambaran input, proses, dan output pendidikan kesehatan berdasarkan model kognitif sosial, sebagai berikut:



Tabel 1.1 Input dan Output pendidikan

a) (Masukan)

Faktor yang memengaruhi proses pendidikan kesehatan:

1) Individu (Faktor Personal)

Pengetahuan awal, Keyakinan, sikap, dan nilai-nilai, Motivasi dan *self-efficacy* serta status kesehatan fisik dan mental.

2) Lingkungan

Dukungan sosial (keluarga, teman, komunitas), Sumber daya kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas medis) serta Media dan informasi kesehatan (TV, internet, brosur)

3) Sumber Belajar

Tenaga kesehatan sebagai pengajar/model, dan orang yang telah berhasil mengadopsi perilaku sehat.

b) Proses (Pembelajaran)

Proses belajar dalam model kognitif sosial melibatkan:

1) Pembelajaran Observasional (Modeling)

Masyarakat mengamati perilaku sehat yang dicontohkan oleh model, misalnya cara mencuci tangan yang benar.

2) Determinisme Resiprokal

Interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku. Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan, lingkungan yang mendukung penerapan perilaku sehat, dan masyarakat mulai mencoba perilaku tersebut.

3) Proses Kognitif

Proses kognitif, meliputi: 1) Perhatian, masyarakat memperhatikan materi yang diajarkan, 2) Retensi, masyarakat menyimpan informasi dalam memori, 3) Reproduksi, masyarakat mempraktikkan perilaku sehat, dan 4) Motivasi, masyarakat didorong oleh penghargaan, dukungan sosial, atau manfaat yang diantisipasi.

4) *Self-Efficacy* (Keyakinan diri)

Masyarakat yakin mampu melakukan perilaku sehat setelah pelatihan dan dorongan yang diberikan oleh pengajar atau tenaga kesehatan.

5) Penguatan dan Umpan Balik

Masyarakat mendapat penghargaan, misalnya pujian atau pengakuan, jika peserta berhasil mempraktikkan perilaku sehat, serta mendapat hukuman atau teguran, jika tidak mematuhi aturan kesehatan.

c) Output (Hasil)

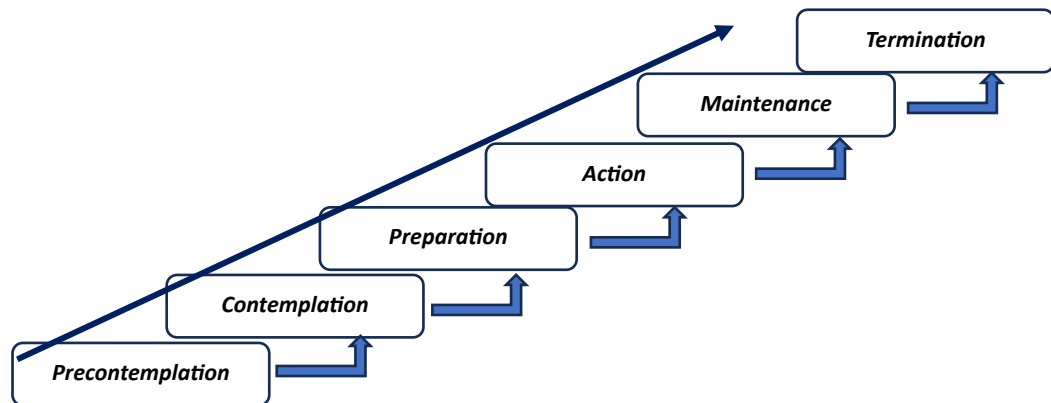
1) Perubahan Kognitif (Pengetahuan dan Sikap), berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan, dan sikap positif terhadap pentingnya perilaku sehat.

2) Perubahan Perilaku (Tindakan nyata), berupa penerapan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rajin mencuci tangan, olahraga teratur, makan makanan sehat.

3) Hasil Jangka Panjang, seperti penurunan risiko penyakit, peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kemampuan untuk menjadi model atau panutan bagi orang lain di lingkungan masyarakat.

b. Model *Transtheoretical (Stadium of Change)*

Model *Transtheoretical (Stadium of Change)* adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam pendidikan kesehatan untuk memahami proses perubahan perilaku. Model ini diperkenalkan oleh James O. Prochaska dan Carlo C. DiClemente (1980). Perubahan perilaku terjadi melalui tahap berikut:



Gambar 1.6 Tahapan Model Transtheoretical

1) *Precontemplation* (Pra-kontemplasi)

Pada tahap ini, individu atau masyarakat belum memiliki niat untuk berubah dalam waktu dekat, maka pada tahap ini intervensi pendidikan Kesehatan di tujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan dan konsekuensinya.

2) *Contemplation* (Kontemplasi)

Pada tahap ini, individu atau masyarakat mulai mempertimbangkan perubahan tetapi belum membuat keputusan, maka intervensi pendidikan kesehatan dilakukan untuk memberikan informasi yang mendukung keputusan untuk berubah.

3) *Preparation* (Persiapan)

Pada tahap ini, individu atau masyarakat membuat rencana konkret untuk berubah dalam waktu dekat, maka intervensi pendidikan kesehatan ditujukan untuk membantu menyusun rencana dan memotivasi tindakan.

4) *Action* (Tindakan)

Pada tahap ini, individu atau masyarakat melakukan perubahan perilaku yang signifikan, maka intervensi pendidikan kesehatan, ditujukan untuk memberikan dukungan dan penghargaan dalam keberhasilan awal.

5) *Maintenance* (Pemeliharaan)

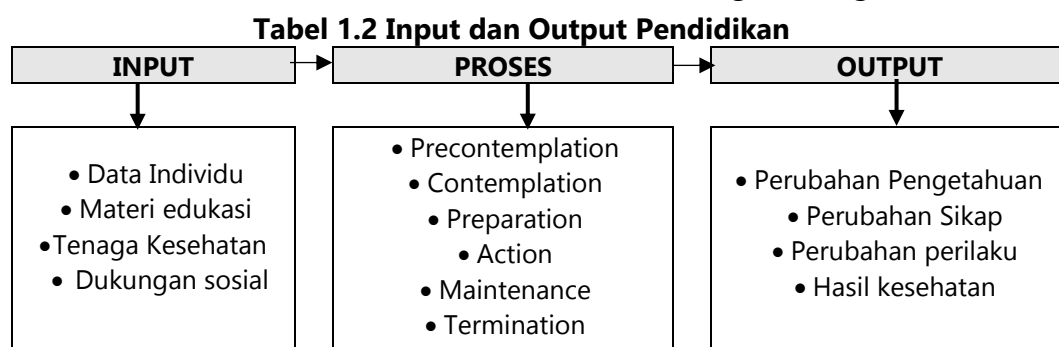
Pada tahap ini, individu atau masyarakat mempertahankan perubahan yang telah dilakukan untuk jangka panjang. Pada tahap ini, intervensi pendidikan kesehatan dilakukan untuk mencegah kekambuhan dan memperkuat strategi koping yang ada.

6) *Termination* (Pengakhiran) (opsional)

Pada tahap ini, perubahan menjadi bagian permanen dari kehidupan individu atau masyarakat tanpa risiko kambuh, maka intervensi pendidikan kesehatan dilakukan untuk memberi penguatan dalam peningkatan kemampuan hidup sehat dan produktif.

Model ini digunakan dalam berbagai program pendidikan kesehatan seperti pencegahan merokok, pengendalian diabetes, dan promosi aktivitas fisik. Intervensi yang dilakukan disesuaikan dengan tahap perubahan yang dialami individu agar lebih efektif. Dengan kerangka ini, pendidikan kesehatan menjadi lebih terstruktur dan dapat dievaluasi secara sistematis sesuai dengan tahapan dalam Model Transtheoretical.

Berikut gambaran input, proses, dan output pendidikan kesehatan berdasarkan model Transtheoretical (*Stadium of Change*) sebagai berikut:



a) Input

Input mencakup semua sumber daya, informasi, dan elemen yang digunakan untuk mendukung perubahan perilaku kesehatan. Komponen Input, meliputi: 1) Data Individu: profil kesehatan, tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku, 2) Materi Edukasi: modul, leaflet, video, dan kampanye promosi kesehatan, 3) Tenaga Kesehatan: Peran dokter, perawat, dan edukator kesehatan, dan 4) Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas lainnya.

b) Proses

Proses mencakup penerapan strategi pendidikan kesehatan berdasarkan tahapan perubahan perilaku sesuai model Transtheoretical, yaitu: 1) *Precontemplation* (Pra-kontemplasi), 2) *Contemplation* (Kontemplasi), 3) *Preparation* (Persiapan), 4) *Action* (Tindakan), 5) *Maintenance* (Pemeliharaan), dan 6) *Termination* (Pengakhiran).

c) Output

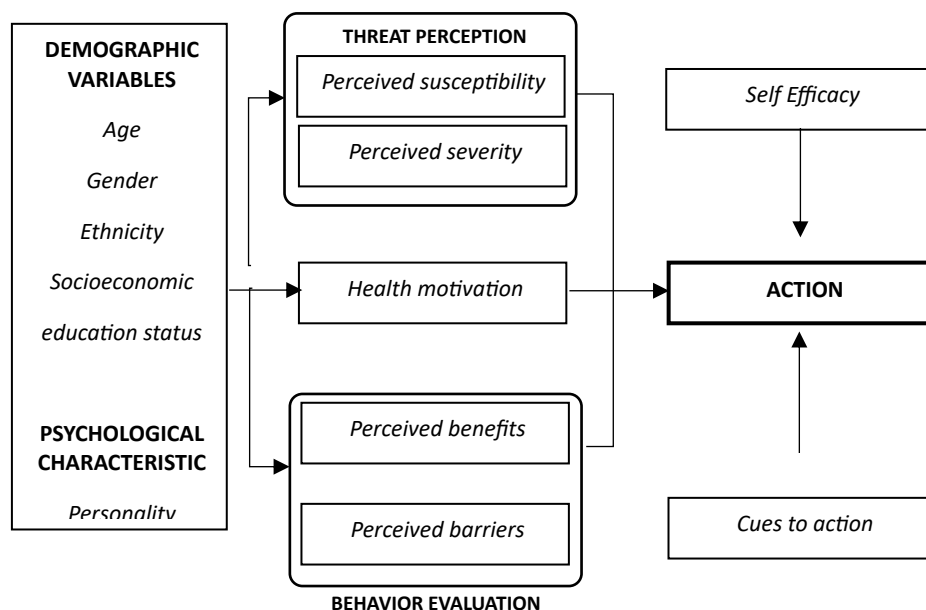
Output mencerminkan hasil dari intervensi pendidikan kesehatan yang diberikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Komponen Output: 1) Perubahan Pengetahuan: Peningkatan pemahaman tentang kesehatan, 2) Perubahan Sikap: Sikap yang lebih positif terhadap gaya hidup sehat, 3) Perubahan Perilaku: Adopsi kebiasaan baru seperti berhenti merokok, olahraga teratur, atau pola makan sehat, dan 4) Hasil Kesehatan: Penurunan prevalensi penyakit terkait, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan biaya kesehatan.

c. *Health Belief Model*

Health Belief Model (HBM) menjelaskan perilaku individu terkait kesehatan dengan mempertimbangkan persepsi terhadap ancaman kesehatan dan penilaian terhadap keuntungan atau kerugian dari suatu tindakan kesehatan. HBM digunakan untuk merancang program intervensi yang memotivasi perubahan perilaku kesehatan, seperti kampanye vaksinasi, pencegahan penyakit menular, dan promosi gaya hidup sehat (Rosenstock, I. M, 1988).

1) Komponen Utama *Health Belief Model*

Komponen HBM bukanlah sesuatu yang harus terjadi secara berurutan, melainkan merupakan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk memengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Model ini efektif jika semua komponen dijalankan secara sinergis dan disesuaikan dengan konteks budaya serta karakteristik masyarakat sasaran. Komponen-komponen ini saling terkait dan memengaruhi keputusan seseorang untuk mengambil tindakan kesehatan.



Gambar 1.7 Health Belief Model

a) *Perceived Susceptibility* (Kerentanan yang dirasakan)

Sejauh mana individu atau masyarakat percaya bahwa mereka rentan terhadap suatu masalah kesehatan, kemungkinan terkena suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Contohnya, saya mungkin terkena diabetes karena riwayat keluarga saya.

b) *Perceived Severity* (Keseriusan yang dirasakan)

Persepsi individu tentang tingkat keparahan dari masalah kesehatan tersebut, yakni keyakinan tentang seberapa serius dampak dari penyakit,

sebagai contoh, jika saya terkena diabetes, saya bisa mengalami komplikasi serius seperti kebutaan atau amputasi.

c) *Perceived Benefits* (Manfaat yang dirasakan)

Keyakinan bahwa tindakan tertentu akan mengurangi risiko atau dampak dari masalah kesehatan. Contohnya, jika saya menjaga pola makan, saya bisa menurunkan risiko terkena diabetes.

d) *Perceived Barriers* (Hambatan yang dirasakan)

Persepsi tentang hal-hal yang menghalangi atau menghambat saat mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan, contoh, hambatan asupan gizi, karena makanan sehat mahal dan sulit diakses.

e) *Cues to Action* (Isyarat untuk bertindak)

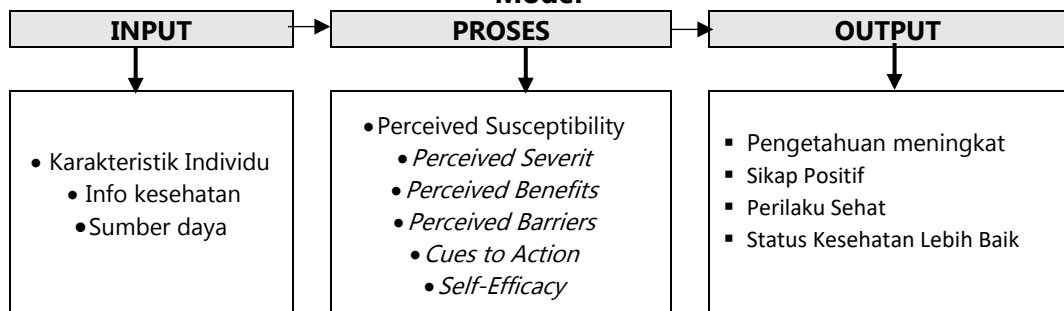
Pemicu internal atau eksternal yang merangsang pengambilan tindakan kesehatan (misalnya, kampanye media, gejala fisik). Contohnya, setelah melihat kampanye tentang bahaya diabetes, saya mulai melakukan olah raga secara teratur dan rutin.

f) *Self-Efficacy* (Efikasi Diri)

Tingkat keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengubah perilaku kesehatannya. Contohnya, saya yakin bisa menjaga pola makan sehat meskipun sibuk bekerja.

2) Gambaran input, proses, dan output pendidikan kesehatan berdasarkan Health *Belief Model* sebagai berikut:

Tabel 1.3 Input dan Ouput Pendidikan Kesehatan Berdasarkan health Belief Model



a) Input

Input mencakup semua elemen yang memengaruhi desain program pendidikan kesehatan berdasarkan HBM, meliputi: 1) Karakteristik Individu: demografi (usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi), dan faktor psikologis (keyakinan, nilai, pengalaman), 2) Informasi Kesehatan, meliputi data tentang penyakit, risiko, dan pencegahan, serta sumber informasi seperti media, tenaga kesehatan, dan komunitas, 3) Sumber

daya, meliputi sumber daya fisik (fasilitas kesehatan, materi edukasi), dan sumber daya manusia (pendidik, tenaga kesehatan)

b) Proses:

Proses ini melibatkan penerapan komponen utama HBM dalam intervensi pendidikan kesehatan.

(1) Penyuluhan dan Edukasi:

- (a) *Perceived Susceptibility*. Jelaskan risiko penyakit dan siapa yang rentan.
- (b) *Perceived Severity*. Tekankan dampak serius dari penyakit jika tidak ditangani.
- (c) *Perceived Benefits*. Tunjukkan manfaat dari tindakan pencegahan atau pengobatan.
- (d) *Perceived Barriers*. Identifikasi hambatan dan solusi untuk mengatasinya.
- (e) *Cues to Action*. Berikan pengingat seperti kampanye atau tanda peringatan.
- (f) *Self-Efficacy*. Latih keterampilan yang diperlukan untuk memotivasi perubahan perilaku.

(2) Metode dan Media, yakni presentasi, diskusi kelompok, kampanye media massa, brosur, aplikasi digital.

(3) Pelaksanaan dan Monitoring, yakni Pelatihan langsung, simulasi, dan pengawasan oleh petugas kesehatan.

c) Output:

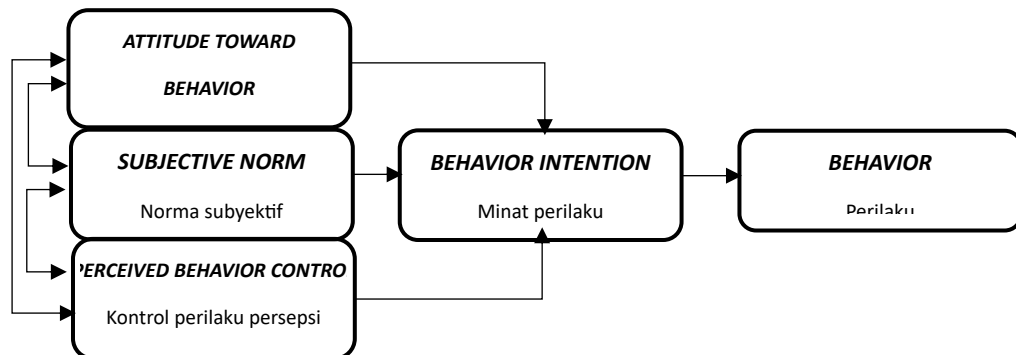
Output adalah hasil yang diharapkan dari proses pendidikan kesehatan berbasis HBM.

- (1) Pengetahuan yang meningkat: Peningkatan pemahaman tentang risiko dan pencegahan penyakit.
- (2) Sikap Positif: Perubahan sikap menjadi lebih peduli terhadap kesehatan diri.
- (3) Perilaku Sehat: Tindakan nyata seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, pola makan sehat, dan berhenti merokok.
- (4) Status Kesehatan yang Lebih Baik: Penurunan angka kejadian penyakit akibat perubahan perilaku.

d. Model *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) ini berfokus pada niat individu sebagai prediktor utama dari perilaku mereka. Ini mempertimbangkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. TPB adalah model psikologi sosial yang digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku manusia

dalam berbagai konteks, termasuk pelaksanaan pendidikan kesehatan. TPB dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model ini berfokus pada niat perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama:



Gambar 1.8 Theory of Planned Behavior (TPB)

1) Komponen Utama TPB

a) *Attitude Toward the Behavior* (Sikap terhadap Perilaku)

Sikap seseorang terhadap perilaku tertentu didasarkan pada evaluasi positif atau negatif terhadap hasil yang mungkin terjadi dari perilaku tersebut. Dalam pendidikan kesehatan, sikap ini dapat mencakup keyakinan bahwa mengikuti program kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup.

b) *Subjective Norm* (Norma Subyektif)

Norma ini mencerminkan tekanan sosial yang dirasakan individu dari orang-orang penting di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan kesehatan, dukungan dari keluarga, teman, dan tenaga medis dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti program kesehatan.

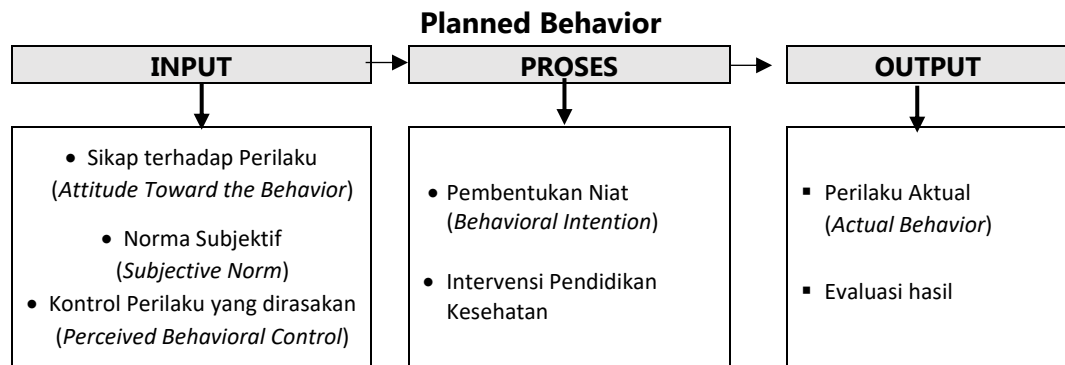
c) *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dirasakan)

Keyakinan tentang sejauh mana seseorang merasa mampu mengontrol atau melaksanakan perilaku tertentu. Jika seseorang merasa mampu mengakses program kesehatan, ia lebih mungkin terlibat dalam perilaku sehat tersebut.

Aplikasi dalam Pendidikan Kesehatan model TPB digunakan untuk 1) merancang intervensi, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk mengadopsi perilaku sehat, 2) memprediksi perilaku kesehatan, misalnya perilaku mencuci tangan, vaksinasi, atau menjalani pemeriksaan kesehatan, dan 3) mengukur efektivitas program dengan melihat apakah intervensi meningkatkan niat dan tindakan terkait perilaku sehat. (Ajzen, I, 1991).

2) Gambaran input, proses, dan output pendidikan kesehatan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sebagai berikut:

Table 1.4 Input dan Output Pendidikan Kesehatan Berdasarkan Theory Of



Dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), prosesnya dapat dipahami melalui tiga tahap utama: input, proses, dan output. Model ini membantu merancang intervensi pendidikan kesehatan untuk memotivasi perubahan perilaku yang diinginkan.

a) Input (Masukan)

Input melibatkan komponen-komponen yang memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku sehat:

(1) Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Keyakinan dan evaluasi individu terhadap konsekuensi dari perilaku kesehatan, misalnya makan makanan sehat akan meningkatkan kesehatan.

(2) Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan yang memengaruhi keputusan seseorang.

(3) Kontrol Perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu (misalnya, akses terhadap layanan kesehatan).

Contoh Input: Penyuluhan tentang manfaat vaksinasi, didukung oleh bukti ilmiah dan testimoni pasien.

b) Proses (Pemrosesan)

Pada tahap ini, individu atau masyarakat memproses informasi yang diterima dan mempertimbangkan niat untuk bertindak berdasarkan input. Proses ini melibatkan:

(1) Pembentukan Niat (*Behavioral Intention*):

Keinginan untuk melakukan perilaku sehat yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

(2) Intervensi Pendidikan Kesehatan:

Pelatihan, kampanye, dan program edukasi digunakan untuk memperkuat keyakinan positif, mengurangi hambatan, dan meningkatkan kontrol diri.

Contoh Proses: Individu atau masyarakat yang menerima pendidikan kesehatan tentang pentingnya olahraga memutuskan untuk mulai berolahraga secara teratur.

c) Output (Keluaran)

Output merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau masyarakat, yaitu perilaku kesehatan yang diadopsi. Jika niat kuat dan kontrol perilaku mendukung, maka perilaku tersebut akan terjadi.

(1) Perilaku Aktual (*Actual Behavior*), misalnya partisipasi dalam pemeriksaan kesehatan rutin atau adopsi pola makan sehat.

(2) Evaluasi hasil yang dilakukan untuk mengukur efektivitas pendidikan kesehatan dan menentukan apakah ada perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan intervensi.

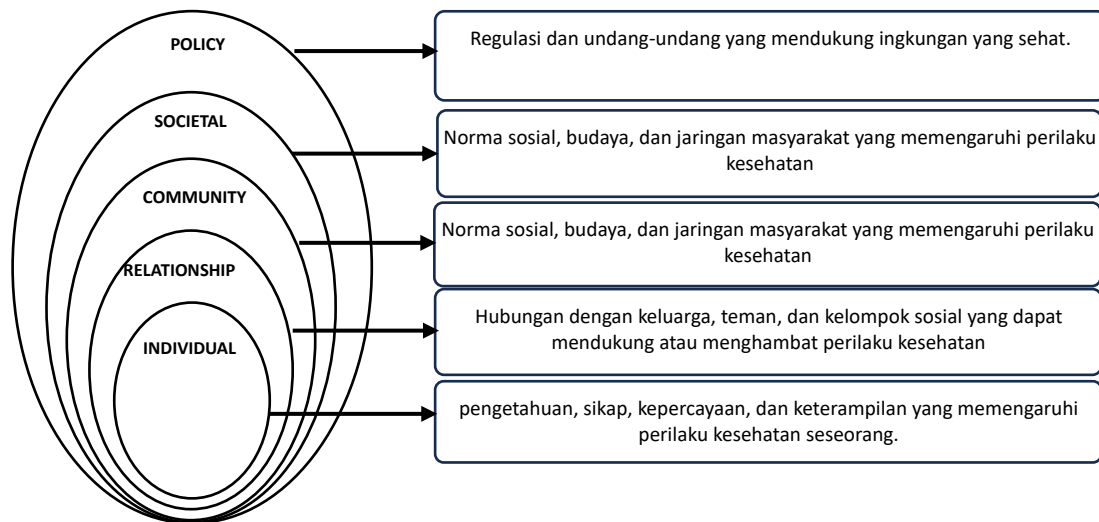
Contoh Output: Peningkatan jumlah peserta yang mempraktikkan pola hidup sehat setelah kampanye pendidikan kesehatan.

e. Model Ekologi Sosial

Model ini memandang perilaku kesehatan sebagai hasil dari interaksi individu dengan berbagai tingkat faktor sosial dan lingkungan, seperti keluarga, komunitas, dan kebijakan sosial. Model ekologi sosial digunakan dalam pendidikan kesehatan untuk memahami dan mengubah perilaku kesehatan, yang berfokus pada interaksi antara individu, kelompok, komunitas, dan lingkungan fisik, sosial, dan politik. Model ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1) Mengakui bahwa individu merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar, 2) Berfokus pada perubahan perilaku pribadi sambil memperhitungkan pengaruh lingkungan, 3) Menyatakan bahwa individu dan lingkungan bersifat timbal balik, dan 4) Menggunakan pendekatan tingkat sistem untuk menangani perilaku (Bronfenbrenner, U, 1979).

Model ekologi sosial dalam pendidikan kesehatan merupakan pendekatan teoretis yang melihat interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya dalam memengaruhi perilaku kesehatan. Model ini digunakan untuk merancang intervensi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan serta menangani perilaku di berbagai tingkatan. Model ini menyatakan bahwa individu dan lingkungan bersifat timbal balik, sehingga individu memengaruhi lingkungannya dan sebaliknya. Model ini juga menyatakan bahwa lingkungan terdiri dari berbagai tingkatan,

yang meliputi individu, hubungan interpersonal, komunitas, dan kebijakan. McLeroy et al. (1988)



Gambar 1.9 Model Ekologi Sosial

1) Komponen Model Ekologi Sosial

a) Tingkat Individual

Meliputi karakteristik individu seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, keyakinan, dan motivasi yang memengaruhi perilaku kesehatan. Contoh dalam pendidikan kesehatan, memberikan informasi tentang risiko penyakit atau cara menjaga kesehatan.

b) Tingkat Interpersonal

Melibatkan hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja yang dapat memengaruhi perilaku individu. Contoh dukungan sosial dari keluarga untuk berhenti merokok atau menerapkan gaya hidup sehat.

c) Tingkat Organisasi

Melibatkan institusi atau organisasi, seperti tempat kerja, sekolah, atau fasilitas kesehatan, yang dapat memengaruhi perilaku melalui kebijakan, program, dan lingkungan fisik. Contohnya program kebugaran di tempat kerja atau kebijakan makan sehat di sekolah.

d) Tingkat Komunitas

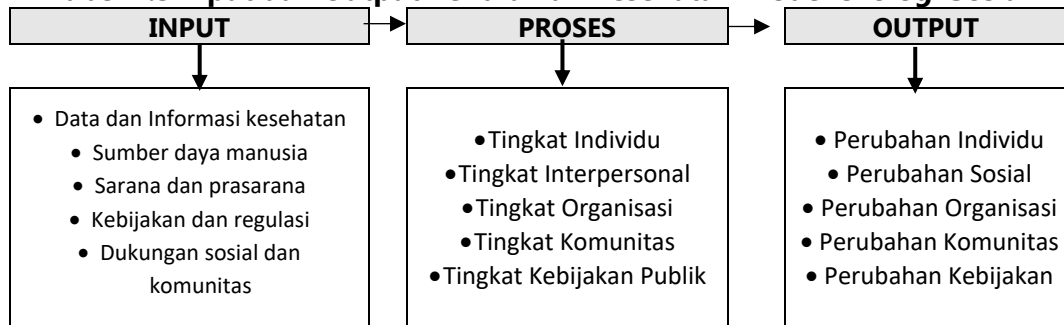
Berfokus pada hubungan di antara organisasi dan komunitas, termasuk norma sosial, jaringan komunitas, dan lingkungan fisik. Contohnya kampanye kesehatan masyarakat yang mendorong gaya hidup aktif dan sehat.

e) Tingkat Kebijakan Publik

Mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendukung atau menghambat perilaku sehat. Contohnya kebijakan larangan merokok di tempat umum atau regulasi pemasaran makanan sehat.

- 2) Gambaran input, proses, dan output pendidikan kesehatan model ekologi sosial, sebagai berikut:

Tabel 1.5 input dan Output Pendidikan Kesehatan Model ekologi Sosial



Model ekologi sosial dalam pendidikan kesehatan melibatkan pendekatan berlapis untuk mengubah perilaku kesehatan melalui intervensi multi-level. Berikut adalah gambaran mengenai input, proses, dan output dalam penerapannya:

a) Input

Input mencakup semua sumber daya, data, dan komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan kesehatan:

- (1) Data & Informasi: Statistik kesehatan masyarakat, data epidemiologi, dan hasil survei.
- (2) Sumber Daya Manusia: Tenaga kesehatan, pendidik, fasilitator masyarakat.
- (3) Sarana & Prasarana: Fasilitas kesehatan, media komunikasi, teknologi informasi.
- (4) Kebijakan & Regulasi: Dukungan hukum dari pemerintah dan organisasi terkait.
- (5) Dukungan Sosial & Komunitas: Keterlibatan pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan keluarga.

b) Proses

Proses melibatkan langkah-langkah implementasi yang mencakup semua tingkat dalam model ekologi sosial:

- (1) Tingkat Individu: Edukasi langsung seperti konseling kesehatan, kampanye media sosial, atau pelatihan keterampilan hidup.
- (2) Tingkat Interpersonal: Program berbasis keluarga dan dukungan dari teman sebaya.

- (3) Tingkat Organisasi: Pelatihan guru di sekolah, program tempat kerja sehat, dan layanan klinis terintegrasi.
- (4) Tingkat Komunitas: Kampanye kesadaran masyarakat, penguatan jaringan sosial, dan kemitraan antar-lembaga.
- (5) Tingkat Kebijakan Publik: Implementasi undang-undang seperti larangan iklan rokok, pajak minuman manis, dan pengendalian polusi udara.

c) Output

Output mencakup hasil langsung yang diharapkan dari intervensi:

- (1) Perubahan Individu: Peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan adopsi perilaku sehat.
- (2) Perubahan Sosial: Penguatan dukungan sosial dan hubungan interpersonal yang lebih baik.
- (3) Perubahan Organisasi: Kebijakan internal yang mendukung lingkungan sehat di sekolah, tempat kerja, dan fasilitas publik.
- (4) Perubahan Komunitas: Lingkungan yang lebih kondusif terhadap perilaku sehat.
- (5) Perubahan Kebijakan: Regulasi kesehatan yang lebih kuat dan diterapkan secara efektif.

D. Indikator Keberhasilan Pendekatan Pendidikan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Tinggi

Indikator keberhasilan pendekatan pendidikan kesehatan pada masyarakat berisiko tinggi mengacu pada ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas intervensi pendidikan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat. Beberapa indikator utama yang sering digunakan adalah:

1. Indikator Input

Mengukur sumber daya yang digunakan dalam program pendidikan kesehatan.

- a. Jumlah tenaga kesehatan: Ketersediaan petugas yang kompeten.
- b. Materi edukasi: Kelengkapan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Sumber dana: Ketersediaan anggaran yang memadai.

2. Indikator Proses:

Mengukur pelaksanaan intervensi pendidikan kesehatan.

- a. Frekuensi penyuluhan: Berapa kali kegiatan dilakukan.
- b. Partisipasi masyarakat: Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan edukasi.
- c. Metode edukasi: Kesuaian metode yang digunakan (ceramah, diskusi, simulasi).

3. Indikator Output

Mengukur hasil langsung setelah intervensi.

- a. Peningkatan pengetahuan: Penilaian pre-test dan post-test.
- b. Perubahan sikap: Indikator perilaku positif yang muncul.

4. Indikator Outcome

Mengukur dampak jangka panjang.

- a. Perubahan perilaku sehat: Misalnya, peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan.
- b. Penurunan risiko penyakit: Berkurangnya insiden penyakit terkait risiko yang ditargetkan.

5. Indikator Dampak (*Impact*)

Mengukur hasil akhir yang diharapkan.

- a. Penurunan angka kesakitan dan kematian, dimana indikator epidemiologis yang membaik.
- b. Kualitas hidup masyarakat membaik, yakni terjadinya peningkatan kesehatan secara keseluruhan.

E. Tantangan dan Solusi Pendidikan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Tinggi

Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan mencakup berbagai aspek yang dapat memengaruhi efektivitas program, diantaranya:

1. Sumber Daya

a. Tantangan

Masyarakat berisiko tinggi sering menghadapi keterbatasan sumber daya seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan anggaran untuk program pendidikan kesehatan. Wilayah pedesaan mungkin memiliki akses terbatas ke pusat kesehatan, sementara kelompok ekonomi rendah tidak mampu membiayai layanan kesehatan.

b. Solusi

- 1) Mobilisasi Dana: Pemerintah dapat memperluas subsidi layanan kesehatan.
- 2) Kemitraan Strategis: Menggandeng sektor swasta, LSM, dan organisasi internasional untuk pendanaan dan penyediaan fasilitas kesehatan.
- 3) Teknologi Digital: Telemedisin dan aplikasi kesehatan dapat menjangkau daerah terpencil.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Tantangan

Masyarakat berisiko tinggi sering kali tidak memahami pentingnya pendidikan kesehatan karena rendahnya tingkat literasi, kepercayaan yang rendah terhadap layanan kesehatan, atau sikap pasrah terhadap penyakit tertentu, sehingga berujung pada rendahnya partisipasi.

b. Solusi

- 1) Kampanye edukasi: Menggunakan media lokal seperti radio komunitas dan program TV edukasi.
- 2) Pendekatan partisipatif: Melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga dalam program kesehatan untuk membangun kepercayaan.
- 3) Program insentif: Memberikan insentif seperti bahan pokok atau layanan kesehatan gratis sebagai motivasi.

3. Budaya dan Sosial

a. Tantangan

Perbedaan nilai budaya dan sosial di beberapa daerah, yang dapat memengaruhi penerimaan program kesehatan. Norma budaya tertentu dapat menghambat penerimaan pesan kesehatan, seperti tabu membahas penyakit tertentu atau kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan praktik kesehatan modern.

b. Solusi

- 1) Pendidikan Multikultural: Melatih tenaga kesehatan agar lebih peka terhadap budaya lokal.
- 2) Penyuluh dari Komunitas: Melibatkan tokoh agama atau pemimpin adat dalam menyampaikan pesan kesehatan.
- 3) Kampanye Terfokus: Menciptakan kampanye kesehatan yang sesuai dengan norma sosial dan menggunakan bahasa lokal.

4. Akses Informasi

a. Tantangan

Pada beberapa wilayah tertentu, seperti wilayah terpencil sering kali memiliki akses terbatas ke informasi kesehatan. Wilayah terpencil dan komunitas dengan infrastruktur komunikasi yang buruk sering mengalami kesenjangan informasi. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet juga kesulitan mendapatkan informasi kesehatan yang akurat.

b. Solusi:

- 1) Media tradisional: Radio, poster, dan program penyuluhan langsung.
- 2) Klinik keliling: Memberikan layanan kesehatan langsung di daerah terpencil.
- 3) Pelatihan Relawan Lokal: Melatih relawan kesehatan yang tinggal di komunitas tersebut agar dapat memberikan edukasi langsung.

5. Pelatihan Tenaga Kesehatan

a. Tantangan

Banyak tenaga kesehatan di wilayah berisiko tinggi tidak memiliki pelatihan yang memadai. Kurangnya pelatihan menyebabkan pelayanan yang kurang profesional dan komunikasi yang tidak efektif dengan masyarakat.

b. Solusi:

- 1) Pelatihan berkelanjutan: Mengadakan pelatihan reguler dengan kurikulum yang sesuai kebutuhan lokal.
- 2) Pendekatan interdisipliner: Melibatkan pakar komunikasi, sosiolog, dan tenaga medis dalam pelatihan tenaga kesehatan.
- 3) Insentif bagi Petugas Kesehatan: Memberikan tunjangan khusus untuk petugas yang bekerja di daerah terpencil.
- 4) Membangun pusat pelatihan regional.

F. Kesimpulan

Masyarakat berisiko tinggi, seperti lansia, individu dengan penyakit kronis, atau kelompok dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, sangat memerlukan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Di beberapa wilayah, masyarakat menganggap keliru terkait pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan membantu individu memahami pentingnya pengobatan, terutama pada penyakit kronis, sehingga ancaman komplikasi tidak terjadi.

Pendidikan kesehatan tidak hanya bermanfaat secara medis, tetapi juga mengurangi tekanan ekonomi pada individu dan sistem kesehatan. Edukasi kesehatan membantu mengubah perilaku berisiko menjadi langkah pencegahan yang lebih aman, mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Pendidikan kesehatan juga meningkatkan kepercayaan diri individu dalam mengelola kondisi mereka, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis. Pendidikan kesehatan bagi masyarakat berisiko tinggi menjadi hal yang penting, karena melalui pendidikan kesehatan masyarakat terbantu untuk memahami faktor risiko dan tindakan pencegahan terhadap penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih sadar terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit, sehingga mempercepat intervensi medis dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu atau kelompok dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. WHO (1986) mengemukakan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses yang mengajak individu untuk mempelajari tentang kesehatan dan cara menjaga serta meningkatkan kesehatannya. Green dan Kreuter (2005) menyebutkan tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku individu dan komunitas agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Pendidikan kesehatan menekankan pentingnya perubahan perilaku untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga perubahan perilaku menjadi fokus

utama dalam pendidikan kesehatan. Perilaku yang dimaksud adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan Pendekatan Pendidikan Kesehatan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan perubahan perilaku kesehatan. Yaitu melalui Model *Theory Cognitive Social*, Model *Transtheoretical (Stadium of Change)*, *Health Belief Model* (HBM). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan Model Ekologi Sosial. Dampak (*Impact*) dari penerapan pendekatan atau model pendidikan kesehatan tersebut adalah terjadinya penurunan angka kesakitan dan kematian, dimana indikator epidemiologis yang membaik, serta kualitas hidup masyarakat membaik, yakni terjadinya peningkatan kesehatan secara keseluruhan.

G. Referensi

- Adler, N.E., & Ostrove, J.M., 1999, *Socioeconomic Status and Health: What We Know and What We Don't*, Annals of the New York Academy of Sciences.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Albert Bandura, 1986, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Prentice-Hall, New Jersey United States.
- American Psychological Association (APA)*, 2021 (WHO, 2022).
- Anderson, 2001, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, Longman.
- Barbosa et al. 2019, *Journal of Hypertension*,
- Berkman et al., 2019, " *Health Literacy: What Is It?*" *Journal of Health Communication*,
- Bandura, A. 1986, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall.
- Bronfenbrenner, U, 1979, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Centers for Disease Control and Prevention/CDC*, 2020, 2021 *Aging & Mental Health Journal*, CDC Publications.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. *Social Determinants of Health and Vulnerability*. CDC Publications.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. *Behavioral Risk Factors and Chronic Diseases*. CDC Publications.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2022. *Risk Factors for Health and Disease Prevention*. CDC Publications.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2023. *Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)*. CDC Publications.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2023, *Health Equity and Social Determinants of Health*. CDC Publications.
- Cutler, D.M., & Lleras-Muney, A. 2006, *Education and Health: Evaluating Theories and Evidence*, NBER Working Paper.
- Dave, R, 1967, *Psychomotor domain*. International Conference of Educational Testing.
- Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008, *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*.
- Green & Kreuter, 2005, *Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill, di New York.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W., 2005, *Health Program Planning and Evaluation: A Practical, Systematic Approach for Community Health*, Edisi kelima, McGraw-Hill, New York
- Icek Ajzen, 1991, *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Academic Press, San Diego
- James O. Prochaska dan Carlo C. DiClemente, 1994, *Changing for Good*, Avon Books, New York, Amerika Serikat
- Kementerian Kesehatan RI. 2021, *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Pedoman Promosi Kesehatan Masyarakat*, Jakarta
- Marmot, M. 2005, *Social Determinants of Health Inequalities*, The Lancet.
- McLeroy et al. 1988. *An Ecological Perspective on Health Promotion Programs*. Health Education Quarterly.
- Nutbeam, D. 2018, *Health Literacy as a Public Health Goal*," Health Promotion International
- Notoatmodjo, 2012, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasinya*, Edisi 4, Rineka Cipta, Jakarta
- Notoatmodjo, 2014, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Cetakan ke dua, Rineka Cipta, Jakarta
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. 1983, *Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395.
- Prochaska, J.O., Norcross, J.C., & DiClemente, C.C. 1994. *Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward*.

- Richard, L., Gauvin, L., & Raine, K. 2011. *Ecological Models Revisited: Their Uses and Evolution in Health Promotion Over Two Decades*. Annual Review of Public Health, 32, 307-326
- Rosenstock I. M, Strecher VJ, Becker MH. 1988, *Social learning theory and the Health Belief Model*. Health Educ Q.
- Rosenstock, I. M. 1974. *The health belief model and preventive health behavior*. Health Education Monographs.
- United Nations Development Programme (UNDP), 2023. *Health Risks and Socioeconomic Impact*.
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), 2020
- United Nations Environment Programme (UNEP), 2023. *Environmental Health Risks*.
- United Nations Environment Programme (UNEP). 2022. *Environmental Health Risks in Urban Areas*.
- Wilkinson, R.G., & Marmot, M. 2023, *Social Determinants of Health: The Solid Facts*, WHO Europe.
- World Bank, 2023,. *Social Determinants of Health and Economic Development*.
- World Health Organization (WHO). 2023. *Health Risk Definition and Management*.
- World Health Organization (WHO). 2023. *Global Health Observatory (GHO) Data: Non-Communicable Diseases*.
- World Health Organization (WHO). 2022. *Social Determinants of Health*. WHO Press.
- WHO, 1986, *Ottawa Charter for Health Promotion*.
- WHO, 2019, *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks*.
- World Health Organization (WHO), 2023. *Environmental Health Risk Factors*.
- World Health Organization (WHO), 2023. *Infectious Diseases and Public Health Risks*.

H. Glosarium

NICE	: National Institute for Health and Care Excellence
APA	: American Psychological Association
CDC	: Centers for Disease Control and Prevention
COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
DTPK	: Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan
GHO	: Global Health Observatory
HBM	: Health Belief Model
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome

PHBS	: Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
UNAIDS	: United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP	: United Nations Development Programme
UNEP	: United Nations Environment Programme
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
WHO	: World Health Organization
TPB	: Theory of Planned Behavior
TRA	: Theory of Reasoned Action
YRBSS	: Youth Risk Behavior Surveillance System

CHAPTER 2

PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Orisinal. SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan bagian terpenting yang harus selalu diperhatikan, manusia dengan tubuh yang sehat dapat melakukan rutinitas sehari-hari dengan maksimal. Sehat juga diperoleh secara langsung tanpa ada pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Ketika sedang sakit maka seseorang tersebut akan memahami bahwa menjaga kesehatan itu perlu. Untuk menjaga kesehatan dapat dimulai dari diri sendiri.

Kesehatan diri sendiri merupakan pendidikan sejak dini yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya peran orang tua. Kesehatan dan kebersihan merupakan sesuatu yang penting serta berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan banyak faktor yang meningkatkan kesehatan seseorang, salah satunya adalah tetap menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga kebersihan diri (Dermawan, 2012).

Untuk menjaga kesehatan bisa dilakukannya olahraga yang teratur dan tetap mengonsumsi makanan yang sehat, sedangkan untuk menjaga kebersihan diri sebaiknya membersihkan diri dengan mandi sekurang-kurangnya dua kali dalam sehari, mengganti pakaian yang dipakai dan selalu mencuci tangan setelah melakukan sesuatu pekerjaan dan sebelum makan juga memakai masker jika keluar rumah agar tetap terjaganya kebersihan dalam diri sendiri.

Kesehatan yaitu suatu hal yang sangat penting di dalam hidup. Kesehatan bisa berupa pola asupan makanan. Banyak sekali saat ini seseorang lebih menggemari makanan yang cepat saji ketimbang makanan yang diolah sendiri dan jelas bahan serta cara pengolahannya secara baik. Bagi seseorang yang cerdas ia akan memperhatikan dalam hal pemilihan makanan yang akan dikonsumsi agar tubuh tetap sehat (Mubarak, 2021).

Selain dari asupan pola makanan yang harus dijaga selanjutnya yaitu tidak dilakukannya merokok di sekitar sekolah ataupun dimana kita berada. Dikarenakan asap rokok tidak sehat untuk pernafasan dan juga perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Setelah menjaga pola asupan makanan dan juga tidak merokok untuk lebih memberi hasil maksimal pada kesehatan harus menjaga imunitas tubuh

dengan memberi vitamin pada tubuh. Vitamin sangat mudah didapatkan yaitu dari buah-buahan yang dikonsumsi (Amin, 2019).

Menurut Larry Green dalam blog Polahidup (2014) Pendidikan kesehatan atau pola hidup sehat adalah kombinasi dalam pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah antara adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan seseorang. Dalam blog Bclinic Indonesia disebutkan bahwa Menurut Kotler (2002) pola hidup sehat adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita dan bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita.

Perawat komunitas adalah profesional perawatan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di luar lingkungan rumah sakit. Mereka bekerja di komunitas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melakukan asesmen kesehatan di tingkat komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Terlibat dalam program-program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik kesehatan yang baik. Bekerja sama dengan pemimpin komunitas, organisasi non-profit, lembaga pemerintah, dan agen kesehatan lokal untuk merancang dan melaksanakan program kesehatan. Perawat Komunitas melakukan manajemen kasus kesehatan untuk memastikan bahwa individu dengan kondisi kronis atau kompleks mendapatkan perawatan yang diperlukan. Memberikan pelatihan kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam komunitas. Perawat komunitas memegang peran penting dalam membantu masyarakat mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik, dengan fokus pada pencegahan, edukasi, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang holistik.

B. Perawat Komunitas

1. Pengertian Perawat Komunitas

Keperawatan komunitas adalah suatu sintesis dari praktek kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan penduduk (American Nurses Association, 2004).

Keperawatan Komunitas adalah kesatuan yang unik dari praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang ditujukan pada pengembangan serta peningkatan kemampuan kesehatan, baik diri sendiri sebagai perorangan maupun secara kolektif sebagai keluarga, kelompok khusus, atau masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup spektrum pelayanan kesehatan untuk masyarakat (Eka Diah, 2022).

Proses keperawatan komunitas adalah metode asuhan keperawatan yang bersifat alamiah, sistematis, dinamis, kontinu, dan berkesinambungan dalam

rangka memecahkan masalah kesehatan dari klien, keluarga serta kelompok atau masyarakat melalui langkah-langkah: pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan.

Menurut Fallen & Dwi K (2010) tujuan dari asuhan keperawatan adalah

- a. Memberi bantuan yang paripurna dan efektif kepada semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional,
- b. menjamin semua bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan klien,
- c. melibatkan klien dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan,
- d. memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota tim kesehatan dan
- e. meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Sementara menurut Adiyani (2020) ciri-ciri keperawatan komunitas adalah yaitu

- a. perpaduan antara pelayanan keperawatan dengan kesehatan komunitas,
- b. Adanya kesinambungan pelayanan kesehatan (continuity of care),
- c. Focus pelayanan pada upaya promotif dan preventif.
- d. Terjadi proses alih peran dari perawat kesehatan komunitas kepada klien (individu, keluarga, kelompok, masyarakat) sehingga terjadi kemandirian.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, yang secara kolektif memfasilitasi individu untuk menjalani kehidupan produktif yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kesehatan erat terkait dengan produktivitas, jadi kesehatan harus dijaga dan ditingkatkan. (Sriwedari, 2020).

Dasar hukum yang digunakan dalam praktik tenaga kesehatan, termasuk praktik keperawatan dan perawat komunitas adalah :

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 1) Pasal 53 ayat (1): "Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya"
 - 2) Pasal 53 ayat (2) & (4): "Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghargai hak pasien"
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 - 1) Pasal 21 Ayat (1): "setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan".
 - 2) Pasal 21 Ayat (2): "Standart profesi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
 - 3) Pasal 22: "Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melakukan tugas profesinya berkewajiban untuk:

- a) Menghormati hak pasien
 - b) Menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pribadi pasien
 - c) Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan
 - d) Membina persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan
 - e) Membuat dan memelihara rekam medis
- 4) Pasal 24 : "Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standart profesi kesehatan"
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647 Tahun 2000 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan, Pasal 17 : "Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi"
- d. Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Inilah undang-undang yang mengkhususkan pada profesi dan praktik keperawatan. Di dalamnya tercantum Asas Praktik Keperawatan (pasal 2), Jenis Perawat (pasal 4), Pendidikan Tinggi Keperawatan (Bab III), Registrasi, Izin Praktik, Dan Registrasi Ulang (Bab IV), Beberapa pasal penting yang perlu mendapat perhatian terkait praktik keperawatan masyarakat/komunitas, antara lain:
- 1) Pasal 28 ayat (1): "Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sasarannya"
 - 2) Pasal 28 ayat (4): "Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah".
 - 3) Pasal 29 ayat (1): "Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
 - a) pemberi Asuhan Keperawatan;
 - b) penyuluh dan konselor bagi Klien;
 - c) pengelola Pelayanan Keperawatan;
 - d) peneliti Keperawatan;
 - e) pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/ atau
 - f) pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
 - 4) Pasal 30 ayat (2) : "Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang :
 - a) melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;

- b) menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c) membantu penemuan kasus penyakit;
 - d) merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - e) melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f) melakukan rujukan kasus;
 - g) mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - h) melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - i) melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - j) menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - k) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - l) mengelola kasus; dan
 - m) melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.
- 5) Pasal 31 ayat (1): "Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi Klien, Perawat berwenang :
- a) melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
 - b) melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c) melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - d) menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan
 - e) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling

C. Perilaku Hidup Sehat

1. Pengertian

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Menurut WHO (1947) Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

WHO mendefinisikan tentang sehat, yang mempunyai karakteristik yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif (Edelman dan Mandle. 1994), antara lain:

- a. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.
- b. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal.
- c. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu

kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, jiwa/mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan fisik, social, dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya.

Menurut menurut Eka Diah (2022), perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dimasyarakat (Maryunani A, 2013).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalan komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (advokasi), bina suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat (empowerman) sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, dalam tatanan masing-masing, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat, dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan (Maryunani A, 2013).

2. Aspek Perilaku Hidup Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui PHBS diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoadmodjo S, 2007).

Penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai ukuran bahwa seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa aspek penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari adalah (Kemensos RI, 2020 :

a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah dokter, bidan dan tenaga perawat terlatih. Hal ini dikarenakan masih ada kelompok masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non medis untuk membantu persalinan, seperti dukun bayi (paraji). Selain tidak aman dan penanganannya pun tidak steril, penanganan oleh dukun bayi (paraji) inipun dikhawatirkan berisiko.

b. Memberi bayi ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif

Seorang ibu perlu memberikan ASI Eksklusif pada bayi, yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain, sejak kelahiran hingga usia enam bulan.

c. Menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan

Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun. Setelah dilakukan penimbangan, catat hasilnya di buku KMS (Kartu Menuju Sehat). Dari catatan KMS dapat diketahui dan dipantau perkembangan dari bayi dan balita tersebut.

d. Menggunakan Air Bersih

Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, hingga untuk kebutuhan air minum. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

e. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar

Mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun dapat menghilangkan berbagai macam kuman dan kotoran yang menempel di tangan sehingga tangan bersih dan terbebas dari kuman. Cucilah tangan setiap kali sebelum makan dan melakukan aktifitas yang menggunakan tangan, seperti memegang uang dan hewan, setelah buang air besar, sebelum memegang makanan maupun sebelum menyusui bayi. Pada situasi berkembangnya virus korona seperti saat ini, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir adalah keharusan. Mencuci tangan harus memperhatikan aturan dengan membersihkan seluruh bagian dari tangan.

f. Gunakan Jamban Sehat

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit

penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Ada beberapa syarat untuk jamban sehat, yakni tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak dapat dijamah oleh hewan seperti serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi udara yang cukup, lantai kedap air, tersedia air, sabun, dan alat pembersih yang memadai.

- g. Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin

Lakukan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) di lingkungan rumah tangga. PJB adalah pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk yang ada di dalam rumah, seperti bak mandi, WC, vas bunga, tatakan kulkas, talang air, dan media penyimpanan lainnya yang menampung air. Kegiatan ini dianjurkan dilakukan secara teratur setiap minggu dan konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3 M (Menguras, Mengubur, Menutup) dan melakukan fogging di tempat-tempat yang dimungkinkan adanya jentik nyamuk secara berkala.

- h. Makan makanan yang sehat dan bergizi

Dianjurkan agar keluarga mengonsumsi jenis makanan yang bersih dan sehat seperti mengandung banyak vitamin, serat, mineral dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh serta bermanfaat bagi kesehatan

- i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari

Melakukan aktifitas fisik, baik berupa olahraga maupun kegiatan lain yang mengeluarkan tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktifitas fisik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yakni olahraga ringan, jalan kaki, jogging, berkebun, dan lain-lainnya

- j. Tidak merokok

Hindari merokok asap rokok dapat mencemari kualitas udara yang dihirup. Di dalam satu puntung rokok yang dihisap, akan dikeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida (CO).

Termasuk di dalamnya adalah Tidak minum-minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minuman keras dan mengonsumsi narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya lainnya) juga cenderung meningkat. Sekitar 1% penduduk Indonesia dewasa diperkirakan sudah mempunyai kebiasaan minuman keras ini.

k. Mandi

Perilaku mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan minimal 2x sehari pada pagi dan sore hari yang bertujuan untuk :

- 1) Menjaga kebersihan kulit.
- 2) Mencegah penyakit kulit/gatal-gatal.
- 3) Menghilangkan bau badan.
- 4) Menghilangkan kuman dan virus

l. Mencuci rambut

Perilaku mencuci rambut dilakukan 2x seminggu menggunakan shampo dan air bersih, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar.

m. Membersihkan hidung

Perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas

n. Membersihkan telinga

Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus di bersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman dan tajam seperti penjepet rambut. Jika ada kotoran yang mengeras, minta bantuan dokter untuk membersihkannya.

Batasi penggunaan headset untuk mendengar musik. Berilah waktu telinga Anda untuk beristirahat. Anda dapat mengikuti aturan 60/60 saat mendengarkan musik melalui headset. Artinya, batas volume musik Anda adalah tidak lebih dari 60 persen dan Anda menggunakannya tidak lebih dari 60 menit sehari.

o. Gosok gigi

Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 x sehari dengan memakai pasta gigi/odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam. Gosok gigi bertujuan untuk:

- 1) Menjaga kebersihan gigi dan mulut.
- 2) Mencegah kerusakan pada gusi dan gigi.
- 3) Mencegah bau mulut tidak sedap

p. Kesehatan mata

Perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya menjaga kesehatan mata. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas cahaya harus cukup terang,

jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris (30 cm), yang dibaca tidak boleh bergerak/bergoyang

q. Memotong kuku

Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1x seminggu dengan tujuan untuk Mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang terselip pada kuku dan jari jemari tangan, dan Mencegah luka akibat garukan kuku. Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengorek hidung dengan jari/kuku tangan yang kotor, tidak memasukkan jari ke mulut atau menggigiti kuku.

r. Menggunakan alas kaki

Anak-anak terkadang saat bermain tidak menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar Kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam dan Mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran.

s. Kebersihan pakaian

Pakaian anak-anak umumnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasar kegiatan mereka, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain dan pakaian tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor.

3. Upaya Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat harus disosialisasikan dan dipromosikan secara berkesinambungan, agar menjadi budaya dan kebiasaan yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perilaku hidup sehat semakin meningkat dan menjadi budaya serta kebiasaan yang selalu diterapkan, antara lain adalah :

- a. Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam penerapan perilaku hidup sehat, sehingga akan menciptakan suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Memahami bahwa anak-anak lebih berpotensi meniru perilaku orang dewasa, daripada melakukan perintah (suara) ataupun instruksi dari orang dewasa. Orang dewasa harus mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat secara terus-menerus (konsisten) dan benar baik saat di rumah maupun di luar rumah. Dengan begitu, maka anak-anak akan mempunyai pola perilaku hidup bersih dan sehat yang akan dipraktikkan sepanjang hidupnya.
- c. Selalu mengupayakan berperilaku hidup sehat dimanapun berada
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu agar mau dan mampu mengambil tindakan yang dapat meningkatkan dan memelihara kesehatannya.

- e. Menyiapkan akses terhadap sarana yang diperlukan untuk praktik PHBS baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar, sekolah, dan lingkungan kerja.
- f. Mengidentifikasi kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menghalangi mereka dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- g. Merubah pandangan tentang PHBS dengan melibatkan berbagai tokoh di masyarakat.
- h. Menyediakan informasi tentang praktik-praktik perilaku PHBS yang tepat.
- i. Memberdayakan siswa, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau menerapkan dan mempraktikkan pola PHBS dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
- j. Memberdayakan para pekerja agar tahu dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang bersih dan sehat, agar para pekerja mampu menjaga dan meningkatkan kesehatannya sehingga tidak mudah sakit, serta meningkatkan citra tempat kerja yang positif, sehingga mendukung peningkatan semangat dan produktivitas kerja.
- k. Menerapkan dan mempraktikkan PHBS di rumah tangga termasuk di tempat pengasuhan anak lainnya, agar setiap anggota keluarga tidak mudah terkena penyakit, dapat meningkatkan kesejahteraan dikarenakan produktifitas anggota keluarga juga meningkat. Selain itu, dengan menerapkan PHBS secara konsisten akan menciptakan budaya hidup bersih dan sehat dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan tercukupi asupan gizi.

D. Peran Perawat Komunitas Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat

Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dimana sudah dijelaskan kewenangan perawat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dan merujuk pada upaya-upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang telah diuraikan, maka beberapa peran penting perawat komunitas dalam meningkatkan perilaku hidup sehat, sebagaimana yang diuraikan oleh Akbar (2019), antara lain adalah :

1. Melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat terkait perilaku hidup sehat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat

Perawat komunitas melakukan pengkajian terhadap praktik perilaku hidup bersih di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat tertentu, termasuk di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. Pengkajian meliputi aspek perilaku hidup sehat mana saja yang sudah dipraktikkan dan aspek perilaku hidup sehat mana saja yang belum dipraktikkan.

Perawat Komunitas juga perlu melakukan pengajian dan identifikasi terhadap kebiasaan-kebiasaan di keluarga dan masyarakat yang menghalangi dan kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi menghambat praktik perilaku hidup sehat. Selain itu perawat komunitas harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung untuk terlaksananya praktik perilaku hidup sehat di setiap tatanan.

2. Menetapkan permasalahan keperawatan masyarakat dalam aspek praktik perilaku hidup sehat.

Setelah mengkaji dan menganalisa kondisi keluarga dan masyarakat serta kelompok tertentu dalam praktik perilaku hidup sehat, maka perawat komunitas menetapkan masalah yang ada pada setiap tatanan tersebut, kemudian mengurutkan permasalahan tersebut berdasarkan kriteria dan ketentuan yang sudah dipahami dalam mengurutkan masalah. Selanjutnya masalah yang sudah teridentifikasi dan diurutkan tersebut dipilih dan ditetapkan mana yang akan diselesaikan dan dipecahkan, sehingga akan memunculkan urutan prioritas masalah. Analisa terhadap masalah yang sudah ditetapkan untuk dipecahkan, akan meliputi identifikasi penyebab masalah, sehingga dalam pelaksanaan intervensi nantinya akan lebih mudah dilakukan.

3. Merencanakan tindakan keperawatan masyarakat untuk mengatasi masalah praktik perilaku hidup sehat

Setelah prioritas masalah praktik perilaku hidup sehat ditetapkan, selanjutnya perawat komunitas merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.

Perencanaan tindakan harus melibatkan pihak-pihak dimana masalah praktik perilaku hidup sehat itu muncul. Jika praktik perilaku hidup sehat ada di tatanan keluarga, maka perawat komunitas harus melibatkan anggota keluarga dalam perencanaan tindakannya, begitu pula bila masalah praktik perilaku hidup sehat ada di sekolah, di tempat kerja atau di lingkungan, maka perawat komunitas harus melibatkan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tatanan tersebut.

Dalam merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah praktik perilaku hidup sehat, perawat komunitas harus menyadari kemampuan yang dimiliki, meliputi sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga ketika tindakan keperawatan masyarakat dilakukan, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

4. Melaksanakan tindakan keperawatan masyarakat dalam praktik perilaku hidup sehat

Tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat adalah sebagaimana yang telah disusun dalam perencanaan. Beberapa tindakan yang diperlukan adalah :

- a. Sosialisasi praktik perilaku hidup bersih di tatanan keluarga, sekolah, tempat kerja dan di masyarakat
- b. Advokasi kepada pemangku kepentingan, mulai dari kepala keluarga, kepala sekolah dan guru-guru, pimpinan tempat kerja dan pimpinan serikat pekerja, kepala desa dan tokoh masyarakat di desa tersebut
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kepada kader dan tokoh penggerak masyarakat, kepada pengurus OSIS di sekolah-sekolah, dan kepada pimpinan dan anggota serikat pekerja
- d. Membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Perusahaan yang memiliki banyak pekerja, dan lembaga-lembaga lain yang mendukung praktik perilaku hidup sehat
- e. Penyuluhan dengan berbagai media, dan konseling di setiap tatanan, agar praktik perilaku hidup sehat makin dipahami oleh sasaran, baik di rumah tangga/keluarga, sekolah, tempat kerja dan lingkungan masyarakat.

5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan yang telah dilakukan dalam meningkatkan praktik perilaku hidup sehat

Evaluasi terhadap seluruh tahapan tindakan diperlukan untuk menilai apakah seluruh tahapan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Hasil evaluasi akan menjadi bahan kajian untuk mengidentifikasi masalah baru yang masih muncul dalam upaya peningkatan praktik perilaku hidup sehat, untuk selanjutnya direncanakan kembali alternative pemecahannya.

E. Kesimpulan

Perilaku hidup sehat memiliki aspek yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup sehat tersebut harus dilaksanakan di tatanan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat tertentu lainnya. Upaya peningkatan praktik perilaku hidup sehat harus dilakukan di setiap tatanan tersebut, dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, agar praktik perilaku hidup sehat membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Peran perawat komunitas dalam meningkatkan praktik perilaku hidup sehat disesuaikan dengan tugas dan wewenang perawat komunitas itu sendiri, sebagaimana termaktub dalam Undang undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Keperawatan, dimana tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan tahapan asuhan keperawatan, yang meliputi pengkajian, diagnose keperawatan, perencanaan intervensi keperawatan, tindakan intervensi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.

F. Referensi

- Adliyani, Nur. (2020). *Pengaruh Perilaku terhadap Hidup Sehat*. Majority. 4(7). Lampung: University Lampung.
- Akbar, M. (2019). *Buku Ajar Konsep – Konsep Dasar Dalam Perawatan Komunitas*. . Yogyakarta: Deepublish.
- American Nurses Association. (2004). *Scope and Standards for Nurse Administrators*. Edisi 2. Washington: Nursesbooks.org
- Amin, L. M. (2019). Sistem Pelayanan Asuhan Keperawatan Kesehatan Komunitas: Studi Kasus di Dusun Mensaleng. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 7(2), 59-70.
- Andriani, M., Wiratmadi, B. (2021). *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Dermawan, D. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Efendi, F. (2022). Makhfudli.(2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Salemba Medika (Issue September 2015). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1178.5366>
- Eka Diah Kartiningrum, E. D. K., Lembunai Tat Alberta, L. T. A., Dwiharini Puspitaningsih, D. P., & Yudha Laga Hadi Kusuma, Y. L. H. K. (2022). *Konsep Dasar Keperawatan Komunitas*
- Kemensos RI, (2020), *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga*, Kementerian Sosial RI, Jakarta
- Mubarak W I, Chayatin N. (2009). *Ilmu Keperawatan Komunitas I Pengantar Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nptpatmodjo, S, (2007), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sriwedari, N. (2020). Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di Desa Onkaw I Kecamatan Sinonsayang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat UNIMA*, 01(02), 1–5
- Yuniarti, S. (2023). Peran Perawat Sebagai Care Giver. *Jurnal Keperawatan*, 7(1), 13-17

CHAPTER 3

PENGEMBANGAN MATERI EDUKASI VISUAL DALAM PROMOSI KESEHATAN

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

A. Pendahuluan/Prolog

Pengembangan media visual dalam promosi kesehatan merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan di masyarakat. Dalam konteks ini, media visual mencakup berbagai bentuk, seperti poster, video, infografis, dan media digital, yang dirancang untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan meningkatnya kompleksitas isu kesehatan dan kebutuhan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, pengembangan media visual yang efektif menjadi semakin krusial.

Pertama, media visual memiliki kemampuan untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan langsung. Menurut penelitian (Safitri et al., 2022), pemilihan media promosi kesehatan harus didasarkan pada selera audiens dan disampaikan dengan cara yang menarik agar dapat memberikan dampak yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa media visual tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam isu kesehatan.

Selanjutnya, penggunaan teknologi modern dalam pengembangan media visual juga sangat penting. Dalam penelitian oleh (Ahmad et al., 2017), pengembangan buku saku sebagai media promosi kesehatan menunjukkan bahwa pendekatan yang inovatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kesehatan tertentu, seperti cacingan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan media sosial, informasi kesehatan dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan efisien, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam (Permatasari, 2023).

Selain itu, media visual juga dapat berfungsi sebagai alat edukasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Suseno et al. (Suseno et al., 2021) menunjukkan bahwa penggunaan media video dan alat peraga dalam pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kebersihan pribadi. Dengan demikian, pengembangan media visual

yang interaktif dan informatif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perilaku sehat dan pencegahan penyakit.

Dalam konteks keperawatan komunitas, pengembangan media visual juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ruhyandi et al. (Ruhyandi et al., 2022) mencatat bahwa promosi kesehatan menggunakan media video dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga tentang COVID-19. Ini menunjukkan bahwa media visual dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mendesak, serta mendorong perubahan perilaku yang positif di masyarakat.

B. Konsep Media Visual

1. Definisi

Media visual dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan melalui elemen visual, seperti gambar, grafik, video, dan desain. Dalam konteks promosi kesehatan, media visual berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Penggunaan media visual dalam promosi kesehatan sangat penting karena dapat memengaruhi cara orang menerima dan memproses informasi.

Berdasarkan penelitian oleh Anisa et al. (Anisa et al., 2022), media visual seperti banner, leaflet, dan poster digunakan secara efektif dalam program promosi kesehatan di rumah sakit. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media cetak dan audio visual dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam edukasi kesehatan. Selain itu, Safitri et al. (Safitri et al., 2022) menekankan bahwa pemilihan media promosi kesehatan harus mempertimbangkan selera audiens dan disampaikan dengan cara yang menarik untuk mencapai dampak yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa media visual tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menarik perhatian audiens.

Lebih lanjut, Miftah dan Rokhman (Miftah & Rokhman, 2022) mendefinisikan media pendidikan sebagai semua alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, media visual dapat mencakup berbagai bentuk, seperti video, infografis, dan presentasi yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar. Media visual membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan audiens dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Media Visual

Media visual dalam promosi kesehatan memiliki banyak manfaat yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan media visual dalam konteks promosi kesehatan:

- a. Meningkatkan Pemahaman dan Retensi Informasi: Media visual, seperti poster, infografis, dan video, dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Suryani et al. (Suryani et al., 2021) menunjukkan bahwa kampanye pencegahan COVID-19 melalui aplikasi TikTok berhasil menyampaikan pesan penting tentang protokol kesehatan dengan cara yang menarik, sehingga masyarakat lebih mudah mengingat dan menerapkan informasi tersebut. Visualisasi yang baik dapat membantu audiens memahami informasi yang kompleks dengan lebih baik.
- b. Menarik Perhatian Audiens: Media visual memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan teks biasa. Penggunaan gambar, grafik, dan warna yang menarik dapat menarik perhatian audiens dan mendorong mereka untuk lebih memperhatikan pesan kesehatan yang disampaikan. Amirullah (Amirullah, 2024) mencatat bahwa desain grafis yang efektif pada billboard kampanye dapat meningkatkan daya tarik visual dan efektivitas komunikasi.
- c. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan: Media visual dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kesehatan. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai platform untuk kampanye kesehatan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Hasna et al. (Hasna et al., 2022) menekankan pentingnya edukasi dan kampanye yang berfokus pada usia muda untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan.
- d. Menyampaikan Pesan dengan Cepat dan Efisien: Media visual memungkinkan penyampaian pesan yang cepat dan efisien. Dalam situasi darurat kesehatan, seperti pandemi, informasi yang cepat dan akurat sangat penting. Hardian (Hardian, 2024) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan influencer di media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi: Media visual, terutama yang berbasis digital, memungkinkan informasi kesehatan diakses oleh lebih banyak orang. Dengan memanfaatkan platform digital, informasi kesehatan dapat dijangkau oleh audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Yulianti dan Boer (Yulianti & Boer, 2020) menyoroti pentingnya penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan yang relevan dan terkini.

- f. Mendorong Perubahan Perilaku: Media visual dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku yang positif. Misalnya, kampanye yang menggunakan visual yang menarik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi atau pencegahan penyakit. Putri dan Christin (Z. S. A. Putri & Christin, 2022) menunjukkan bahwa kampanye yang efektif dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap protokol kesehatan.
- g. Mendukung Edukasi dan Pelatihan: Media visual juga dapat digunakan dalam konteks edukasi dan pelatihan kesehatan. Maksum et al. (Maksum et al., 2022) menjelaskan bahwa permainan edukatif yang menggunakan desain visual yang menarik dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar tentang protokol kesehatan, sehingga memudahkan mereka dalam memahami informasi yang disampaikan.

3. Jenis Media Visual

Dalam konteks promosi kesehatan, terdapat berbagai jenis media visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan. Media visual ini berfungsi untuk menarik perhatian audiens, memudahkan pemahaman, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Berikut adalah beberapa jenis media visual yang umum digunakan dalam promosi kesehatan:

- a. Poster dan Leaflet: Poster dan leaflet adalah bentuk media cetak yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan secara singkat dan jelas. Safitri et al. Safitri et al. (2022) menekankan bahwa pemilihan media promosi kesehatan harus mempertimbangkan aksesibilitas dan daya tarik visual untuk mencapai dampak yang luas. Media ini efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat umum, seperti puskesmas, sekolah, dan acara komunitas.
- b. Video: Media video merupakan salah satu bentuk media audio-visual yang sangat efektif dalam promosi kesehatan. Ruhyandi et al. Ruhyandi et al. (2022) menunjukkan bahwa video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang menarik dan persuasif. Video memungkinkan penyampaian pesan yang lebih dinamis dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan audiens.
- c. Media Sosial: Media sosial telah menjadi platform penting dalam promosi kesehatan, terutama di kalangan remaja dan masyarakat umum. Rahmatika dan Rahman (Rahmatika & Rahman, 2020) mencatat bahwa media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Selain itu, Leonita dan Jalinus (Leonita & Jalinus, 2018) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam promosi kesehatan

dapat memperluas jangkauan informasi kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan.

- d. Infografis: Infografis adalah representasi visual dari data atau informasi yang dirancang untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Infografis sering digunakan dalam kampanye kesehatan untuk menjelaskan statistik, proses kesehatan, atau langkah-langkah pencegahan penyakit. Media ini sangat efektif dalam menarik perhatian dan memudahkan pemahaman informasi yang kompleks.
- e. E-Flyer dan Konten Digital: E-flyer dan konten digital lainnya, seperti artikel blog atau postingan media sosial, juga merupakan jenis media visual yang penting dalam promosi kesehatan. Konten digital memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, serta dapat diakses oleh audiens di berbagai platform. Mandaru et al. (Mandaru et al., 2021) menekankan pentingnya media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan yang akurat dan terkini.
- f. Film dan Dokumenter Film dan dokumenter dapat digunakan sebagai alat edukasi yang kuat dalam promosi kesehatan. Saleh et al. (Saleh et al., 2016) menunjukkan bahwa film dapat menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang menarik. Media ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kesehatan tertentu, seperti merokok atau penyakit menular.
- g. Alat Peraga dan Model: Dalam konteks pendidikan kesehatan, alat peraga dan model fisik dapat digunakan untuk menjelaskan konsep kesehatan dengan cara yang lebih interaktif. Alat peraga ini dapat membantu audiens memahami informasi kesehatan dengan lebih baik melalui visualisasi yang konkret.

Secara keseluruhan, pemilihan jenis media visual dalam promosi kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media visual, penyuluhan kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang penting.

C. Pengembangan Materi Edukasi Visual

1. Leaflet

Salah satu karakteristik utama dari leaflet adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi secara singkat dan padat. Leaflet sering kali menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang medis (Amaliyah, 2023). Selain itu, penggunaan elemen visual yang menarik, seperti gambar dan

grafik, dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan dan membuat informasi lebih mudah diingat (Thome et al., 2022)(K. D. Putri et al., 2021). Pembuatan leaflet sebagai alat promosi kesehatan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan efektif dan menarik bagi audiens target. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam proses pembuatan leaflet:

a. Penentuan Tujuan dan Audiens Target

- 1) Identifikasi Tujuan: Tentukan apa yang ingin dicapai dengan leaflet tersebut. Apakah untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit tertentu, mempromosikan gaya hidup sehat, atau menginformasikan tentang layanan kesehatan.
- 2) Audiens Target: Kenali siapa yang akan menjadi pembaca leaflet. Apakah itu remaja, orang dewasa, atau kelompok tertentu seperti ibu hamil? Memahami karakteristik audiens akan membantu dalam menentukan bahasa, desain, dan konten yang tepat.

b. Pengumpulan Informasi

- 1) Riset: Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat mengenai topik yang akan disampaikan. Gunakan sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi organisasi kesehatan.
- 2) Pilih Informasi Utama: Pilih informasi yang paling penting dan relevan untuk audiens. Pastikan informasi tersebut mudah dipahami dan tidak terlalu teknis.

c. Perencanaan Konten

- 1) Struktur Leaflet: Tentukan struktur leaflet, biasanya terdiri dari:
- 2) Judul yang menarik
- 3) Pendahuluan singkat
- 4) Isi utama (fakta, tips, langkah-langkah, dll.
- 5) Kesimpulan atau ajakan untuk bertindak
- 6) Kontak atau sumber informasi lebih lanjut
- 7) Bahasa yang Digunakan: Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari jargon medis yang mungkin tidak dipahami oleh audiens umum.

d. Desain Leaflet

- 1) Pemilihan Format: Tentukan format leaflet, apakah lipat dua (bi-fold), lipat tiga (tri-fold), atau format lainnya.
- 2) Visual dan Grafis: Gunakan gambar, grafik, atau ilustrasi yang relevan untuk menarik perhatian dan membantu menjelaskan informasi. Pastikan visual berkualitas tinggi dan tidak mengganggu teks.

- 3) Warna dan Font: Pilih kombinasi warna yang menarik dan mudah dibaca. Gunakan font yang jelas dan ukuran yang cukup besar agar mudah dibaca.
- e. Penyusunan Penulisan
- 1) Tulis Konten: Susun konten sesuai dengan struktur yang telah direncanakan. Pastikan setiap bagian saling terhubung dan mendukung tujuan leaflet.
 - 2) Edit dan Revisi: Periksa kembali konten untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kejelasan. Mintalah umpan balik dari rekan atau ahli di bidang kesehatan untuk memastikan akurasi informasi.

2. Poster

Poster memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari media promosi lainnya. Pertama, poster biasanya dirancang dengan ukuran besar sehingga dapat dilihat dari jarak jauh, menjadikannya efektif untuk menarik perhatian di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan acara komunitas (Pramitasari, 2023); Anisa et al., 2022). Kedua, poster menyajikan informasi secara singkat dan padat, sering kali menggunakan poin-poin atau bullet untuk memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang disampaikan (Sinanto, 2021). Ketiga, poster sering kali menggunakan elemen visual yang kuat, seperti gambar atau ilustrasi, untuk mendukung teks dan membuat informasi lebih menarik (Arindari et al., 2022).

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam proses pembuatan poster:

a. Penentuan Tujuan dan Audiens Target

- 1) Identifikasi Tujuan: Tentukan apa yang ingin dicapai dengan poster tersebut. Apakah untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tertentu, mempromosikan program kesehatan, atau memberikan informasi tentang gaya hidup sehat.
- 2) Audiens Target: Kenali siapa yang akan menjadi pembaca poster. Apakah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, atau kelompok tertentu seperti lansia. Memahami karakteristik audiens akan membantu dalam menentukan bahasa, desain, dan konten yang tepat

b. Pengumpulan Informasi

- 1) Riset: Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat mengenai topik yang akan disampaikan. Gunakan sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi organisasi kesehatan.
- 2) Pilih Informasi Utama: Pilih informasi yang paling penting dan relevan untuk audiens. Pastikan informasi tersebut mudah dipahami dan tidak terlalu teknis.

c. Perencanaan Konten

- 1) Struktur Poster: Tentukan struktur poster, biasanya terdiri dari:
- 2) Judul yang menarik dan informative
- 3) Subjudul atau ringkasan singkat
- 4) Isi utama (fakta, tips, langkah-langkah, dll.)
- 5) Gambar atau grafik yang mendukung
- 6) Kontak atau sumber informasi lebih lanjut
- 7) Bahasa yang Digunakan: Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari jargon medis yang mungkin tidak dipahami oleh audiens umum.

d. Desain Poster

- 1) Pemilihan Format: Tentukan ukuran dan format poster. Poster biasanya memiliki ukuran standar seperti A3 atau A2, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Visual dan Grafis: Gunakan gambar, grafik, atau ilustrasi yang relevan untuk menarik perhatian dan membantu menjelaskan informasi. Pastikan visual berkualitas tinggi dan tidak mengganggu teks.
- 3) Warna dan Font: Pilih kombinasi warna yang menarik dan mudah dibaca. Gunakan font yang jelas dan ukuran yang cukup besar agar mudah dibaca dari jarak jauh.

e. Penyusunan dan Penulisan

- 1) Tulis Konten: Susun konten sesuai dengan struktur yang telah direncanakan. Pastikan setiap bagian saling terhubung dan mendukung tujuan poster.
- 2) Edit dan Revisi: Periksa kembali konten untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kejelasan. Mintalah umpan balik dari rekan atau ahli di bidang kesehatan untuk memastikan akurasi informasi.

3. Booklet

Salah satu karakteristik utama dari booklet adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan leaflet. Booklet dapat mencakup berbagai aspek dari suatu topik, seperti definisi, penyebab, gejala, pengobatan, dan langkah-langkah pencegahan. Misalnya, booklet tentang manajemen diabetes dapat mencakup informasi tentang diet, pengukuran gula darah, dan pentingnya olahraga (Williams et al., 2011). Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas dalam booklet memungkinkan audiens dari berbagai latar belakang untuk memahami informasi yang disampaikan (ALAÇAM, 2024). Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam proses pembuatan booklet:

- a. Penentuan Tujuan dan Audiens Target
 - 1) Identifikasi Tujuan: Tentukan apa yang ingin dicapai dengan poster tersebut. Apakah untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tertentu, mempromosikan program kesehatan, atau memberikan informasi tentang gaya hidup sehat.
 - 2) Audiens Target: Kenali siapa yang akan menjadi pembaca poster. Apakah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, atau kelompok tertentu seperti lansia. Memahami karakteristik audiens akan membantu dalam menentukan bahasa, desain, dan konten yang tepat
- b. Pengumpulan Informasi
 - 1) Riset: Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat mengenai topik yang akan disampaikan. Gunakan sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi organisasi kesehatan.
 - 2) Pilih Informasi Utama: Pilih informasi yang paling penting dan relevan untuk audiens. Pastikan informasi tersebut mudah dipahami dan tidak terlalu teknis.
- c. Perencanaan Konten

Struktur Booklet: Tentukan struktur poster, biasanya terdiri dari:

 - 1) Sampul depan (judul dan gambar menarik)
 - 2) Daftar isi (jika booklet cukup panjang)
 - 3) Pendahuluan singkat
 - 4) Isi utama (fakta, tips, langkah-langkah, dll.)
 - 5) Kesimpulan atau ajakan untuk bertindak
 - 6) Kontak atau sumber informasi lebih lanjut
 - 7) Bahasa yang Digunakan: Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari jargon medis yang mungkin tidak dipahami oleh audiens umum.
- d. Desain Booklet
 - 1) Pemilihan Format: tentukan ukuran dan format booklet. Booklet biasanya memiliki ukuran standar seperti A5 atau A4, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 2) Visual dan Grafis: Gunakan gambar, grafik, atau ilustrasi yang relevan untuk menarik perhatian dan membantu menjelaskan informasi. Pastikan visual berkualitas tinggi dan tidak mengganggu teks.
 - 3) Warna dan Font: Pilih kombinasi warna yang menarik dan mudah dibaca. Gunakan font yang jelas dan ukuran yang cukup besar agar mudah dibaca dari jarak jauh.
- e. Penyusunan dan Penulisan

- 1) Tulis Konten: Susun konten sesuai dengan struktur yang telah direncanakan. Pastikan setiap bagian saling terhubung dan mendukung tujuan poster.
- 2) Edit dan Revisi: Periksa kembali konten untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kejelasan. Mintalah umpan balik dari rekan atau ahli di bidang kesehatan untuk memastikan akurasi informasi.

4. Adobe Photosop Program

a. Pengertian Adobe Photoshop

Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengolah gambar yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, dikembangkan oleh Adobe Systems. penjelasan lebih lanjut mengenai Photoshop Adobe Photoshop, sering disingkat menjadi Photoshop, adalah perangkat lunak penyunting citra berbasis raster yang dirancang khusus untuk pengeditan foto dan manipulasi gambar. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari retouching foto hingga pembuatan desain grafis yang kompleks.

b. Fungsi Adobe Photoshop

Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengolah gambar yang sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama desain grafis dan pengeditan foto. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Adobe Photoshop:

- 1) Pengeditan Foto
- 2) Manipulasi Gambar
- 3) Desain Grafis

Photoshop sering digunakan untuk membuat berbagai elemen desain grafis, termasuk:

- 1) Poster dan Brosur: Mendesain materi cetak dengan tata letak yang menarik.
- 2) Logo dan Identitas Merek: Membuat logo dan elemen branding lainnya.
- 3) Desain Web: Merancang antarmuka pengguna (UI) untuk situs web dan aplikasi.
- 4) Pembuatan Ilustrasi Digital
- 5) Dengan alat lukisan digital yang canggih, Photoshop memungkinkan seniman untuk menciptakan ilustrasi digital dengan berbagai gaya. Ini termasuk penggunaan kuas digital untuk menghasilkan karya seni yang unik.
- 6) Restorasi Foto

Photoshop memberikan alat yang kuat untuk memperbaiki dan memulihkan foto-foto lama atau rusak. Teknik retouching dan pemulihan dapat digunakan untuk menghidupkan kembali gambar-gambar bersejarah.

7) Persiapan Gambar untuk Cetak

c. Perkembangan Versi

Photoshop terus berkembang dengan rilis versi baru yang memperkenalkan berbagai fitur dan alat baru:

- 1) Versi 2.0 (Juni 1991): Memperkenalkan dukungan warna.
- 2) Versi 3.0 (September 1994): Menambahkan fitur layer, yang memungkinkan pengguna untuk mengedit gambar dengan lebih fleksibel.
- 3) Versi 4.0 (November 1996): Memperkenalkan Adjustment Layers dan Actions.
- 4) Versi 5.0 (Mei 1998): Menambahkan History Palette dan Magnetic Lasso.
- 5) Versi CS (Creative Suite) 8.0 (Oktober 2003): Menandai pergeseran branding ke Creative Suite, yang berlanjut hingga versi CS6 pada tahun 2012.
- 6) Transisi ke Creative Cloud

Tahun 2013: Adobe merilis Photoshop CC (Creative Cloud), menggantikan sistem versi CS. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pembaruan perangkat lunak secara berkelanjutan melalui langganan.

7) Versi Terkini

- 8) Sejak peluncuran CC, Adobe telah merilis berbagai pembaruan dan versi baru setiap tahun, termasuk Photoshop CC 2014 hingga versi terbaru yang terus ditingkatkan dengan fitur-fitur canggih seperti AI dan alat pengeditan berbasis cloud. Adobe Photoshop telah menjadi standar industri dalam pengeditan gambar dan desain grafis, digunakan oleh fotografer, desainer grafis, dan profesional kreatif di seluruh dunia. Perkembangannya dari program sederhana menjadi perangkat lunak kompleks mencerminkan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna dalam dunia digital yang terus berubah.

d. Cara Membuat Poster Di Photoshop

Membuat poster di Adobe Photoshop dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana. Berikut adalah petunjuk langkah demi langkah untuk membuat poster yang menarik dan profesional:

1) Membuat Dokumen Baru

Buka Photoshop: Jalankan aplikasi Adobe Photoshop di komputer Anda.

- 2) Membuat Dokumen Baru: Pilih menu File > New, lalu isi kolom-kolom yang tersedia untuk menentukan ukuran poster. Pastikan Anda memilih resolusi yang tinggi, minimal 300 DPI, jika Anda akan mencetak poster.

3) Mengatur Latar Belakang Poster

Atur Latar Belakang: Setelah dokumen siap, ubah latar belakang dengan memilih warna solid, gradient, atau bahkan menambahkan gambar sebagai

latar belakang. Pastikan latar belakang tidak terlalu ramai agar elemen teks dan gambar di poster tetap terlihat jelas.

4) Pilih Gambar atau Ilustrasi yang Menarik

Impor Gambar: Gunakan File > Place Embedded untuk mengimpor gambar atau ilustrasi yang menarik. Pastikan gambar memiliki resolusi tinggi agar tidak pecah saat dicetak.

5) Tambahkan Teks yang Jelas dan Menarik

Gunakan Alat Text Tool (T): Tambahkan teks yang informatif dan menarik menggunakan alat Text Tool. Pilih font yang mudah dibaca dan cocok dengan tema poster. Kombinasi antara ukuran font yang berbeda dapat memberikan efek visual yang lebih dinamis dan menarik perhatian.

6) Manfaatkan Tools yang Ada

Tools yang Efektif: Photoshop memiliki berbagai tools yang efektif untuk pengolahan dan penyuntingan gambar. Gunakan tools seperti Rectangle Tool untuk membuat persegi panjang, dan Polygon Tool untuk membuat segitiga atau polygon lainnya. Tambahkan warna dan efek tertentu pada teks dan gambar untuk meningkatkan estetika poster

7) Simpan Proyek Anda

Simpan dalam Format PSD: Simpan proyek Anda dalam format PSD agar Anda bisa mengeditnya lagi di masa depan. Untuk mencetak atau membagikan poster secara digital, ekspor file dalam format JPEG atau PNG dengan resolusi tinggi. Pilih File > Export > Export As dan sesuaikan pengaturan ekspor sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat desain poster yang menarik dan profesional menggunakan Adobe Photoshop.

5. Aplikasi Canva

Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual, termasuk poster, presentasi, infografis, dan media sosial. Sejak diluncurkan pada tahun 2013, Canva telah menjadi salah satu alat desain yang paling populer di kalangan profesional dan pemula. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi Canva, fitur-fiturnya, serta penerapannya dalam berbagai konteks.

a. Fitur Utama Canva

- 1) Antarmuka Pengguna yang Ramah: Canva menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami cara kerja platform. Hal ini sangat penting bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang desain grafis.

- 2) Template yang Beragam: Canva menyediakan ribuan template yang dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan, mulai dari media sosial hingga materi pemasaran. Template ini dirancang oleh profesional dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga menghemat waktu dan usaha dalam proses desain (Azhar & Hutasuhut, 2022).
 - 3) Koleksi Elemen Desain: Pengguna dapat mengakses berbagai elemen desain, termasuk gambar, ikon, font, dan ilustrasi. Canva juga menawarkan fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk menemukan elemen yang sesuai dengan tema desain mereka (Yuliani, 2023).
 - 4) Kolaborasi Tim: Canva memungkinkan kolaborasi real-time, di mana beberapa pengguna dapat bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan. Fitur ini sangat berguna untuk tim yang bekerja dari lokasi yang berbeda dan memerlukan umpan balik cepat (Dias et al., 2021).
 - 5) Fitur Ekspor dan Berbagi: Setelah selesai mendesain, pengguna dapat mengeksport karya mereka dalam berbagai format, termasuk PNG, JPG, PDF, dan GIF. Canva juga memudahkan pengguna untuk membagikan desain mereka langsung ke platform media sosial atau melalui email (Afrida, 2023).
- b. Penerapan Canva dalam Berbagai Konteks
- 1) Pendidikan: Canva telah digunakan secara luas dalam konteks pendidikan untuk membuat materi ajar, presentasi, dan poster. Guru dan siswa dapat memanfaatkan template yang ada untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami (Oliveira et al., 2021).
 - 2) Pemasaran dan Bisnis: Banyak perusahaan menggunakan Canva untuk membuat konten pemasaran, seperti brosur, flyer, dan postingan media sosial. Dengan alat ini, tim pemasaran dapat dengan cepat menghasilkan materi yang menarik tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam (Carvalho et al., 2019).
 - 3) Kegiatan Sosial dan Komunitas: Organisasi non-profit dan komunitas juga memanfaatkan Canva untuk membuat materi promosi dan informasi tentang acara. Dengan biaya yang rendah dan aksesibilitas yang tinggi, Canva menjadi alat yang ideal untuk meningkatkan visibilitas dan partisipasi dalam kegiatan sosial (Cavalcante et al., 2020).
 - 4) Desain Pribadi: Individu yang ingin membuat undangan, kartu ucapan, atau konten pribadi lainnya juga dapat menggunakan Canva. Platform ini memberikan kebebasan kreatif bagi pengguna untuk mengekspresikan diri mereka melalui desain yang unik.
- c. Cara Pembuatan Leaflet dan Poster menggunakan canva
- Langkah 1: Mendaftar atau Masuk ke Canva

1) Buka Situs Canva: Kunjungi situs web Canva di www.canva.com(<https://www.canva.com>).

2) Buat Akun atau Masuk: Jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat mendaftar menggunakan email, akun Google, atau Facebook. Jika sudah memiliki akun, cukup masuk.

Langkah 2: Memilih Jenis Desain Leaflet atau poster

1) Cari Template Leaflet: Di halaman utama Canva, gunakan bilah pencarian dan ketik "leaflet" untuk menemukan berbagai template yang tersedia.

2) Pilih Template yang Sesuai: Telusuri pilihan template yang ada dan pilih satu yang paling sesuai dengan tema dan tujuan leaflet Anda. Anda dapat memilih dari berbagai gaya, warna, dan tata letak.

Langkah 3: Menyesuaikan Desain Leaflet

1) Mengedit Teks: Klik pada teks yang ada di template untuk mengeditnya. Anda dapat mengganti teks dengan informasi yang ingin disampaikan, seperti judul, deskripsi, dan kontak. Pastikan teks mudah dibaca dan jelas.

2) Mengubah Font dan Ukuran: Canva memungkinkan Anda untuk mengubah jenis font, ukuran, dan warna teks. Pilih font yang sesuai dengan tema leaflet dan pastikan konsistensi dalam penggunaan font di seluruh desain.

3) Menambahkan Gambar dan Elemen: Anda dapat menambahkan gambar, ikon, atau elemen grafis lainnya dengan mengklik tab "Elements" di sebelah kiri. Cari elemen yang sesuai dan seret ke dalam desain. Pastikan gambar yang digunakan berkualitas tinggi dan relevan dengan konten.

4) Mengatur Tata Letak: Sesuaikan tata letak elemen di dalam leaflet agar terlihat seimbang dan menarik. Anda dapat menggeser elemen, mengubah ukuran, atau memutar elemen sesuai kebutuhan

Langkah 4: Menyimpan dan Mengekspor Leaflet

1) Pratinjau Desain: Setelah selesai mengedit, lihat pratinjau desain untuk memastikan semuanya terlihat baik. Periksa kesalahan ketik dan pastikan semua informasi sudah benar.

2) Menyimpan Desain: Klik tombol "Simpan" untuk menyimpan desain Anda di akun Canva.

3) Mengekspor Leaflet: Untuk mengunduh leaflet, klik tombol "Unduh" di sudut kanan atas. Pilih format file yang diinginkan (misalnya, PDF untuk cetak atau PNG untuk digital) dan klik "Unduh".

6. Media Video/Film

Salah satu media yang efektif dalam promosi kesehatan adalah video. Penggunaan media video dalam promosi kesehatan terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap masyarakat terhadap perilaku sehat. Artikel ini

akan membahas pengaruh media video dalam promosi kesehatan berdasarkan berbagai penelitian yang relevan.

a. Kelebihan Media Video dalam Promosi Kesehatan

- 1) Daya Tarik Visual: Media video memiliki keunggulan dalam menarik perhatian audiens. Dengan kombinasi gambar, suara, dan teks, video dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan dinamis. Hal ini terbukti dari penelitian oleh Retnaningrum yang menunjukkan bahwa video animasi dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan (Retnaningrum, 2023).
- 2) Aksesibilitas dan Distribusi: Video dapat dengan mudah dibagikan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, yang memungkinkan jangkauan yang lebih luas. Penelitian oleh Yusup et al. menunjukkan bahwa media promosi dalam bentuk video dapat menarik minat siswa untuk mendaftar di sekolah kesehatan, yang menunjukkan potensi video dalam menarik perhatian audiens yang lebih besar (Yusup et al., 2022).
- 3) Interaktivitas: Penggunaan video interaktif, seperti yang diteliti oleh Razi et al., dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perilaku sehat, seperti mencuci tangan. Video interaktif memungkinkan audiens untuk terlibat secara aktif, yang dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan (Razi et al., 2022).

b. Program Editing Video

Editing video merupakan proses penting dalam produksi konten audiovisual, baik untuk keperluan profesional maupun pribadi. Dengan kemajuan teknologi, banyak program editing video yang tersedia, masing-masing dengan fitur dan kemampuan yang berbeda. Artikel ini akan membahas beberapa program editing video yang populer, fitur-fitur utama yang ditawarkan, serta rekomendasi berdasarkan kebutuhan pengguna.

1) Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro adalah salah satu program editing video yang paling banyak digunakan oleh profesional di industri film dan televisi. Program ini menawarkan berbagai fitur canggih, termasuk:

- a) Timeline Editing^{**}: Memungkinkan pengguna untuk mengatur klip video dan audio secara efisien.
- b) Color Grading^{**}: Fitur untuk mengubah dan memperbaiki warna video, memberikan tampilan yang lebih profesional.
- c) Integrasi dengan Adobe Creative Cloud^{**}: Pengguna dapat mengakses aplikasi lain seperti After Effects dan Photoshop untuk meningkatkan proyek mereka.

- d) Dukungan Format Beragam: Premiere Pro mendukung berbagai format video, sehingga pengguna dapat bekerja dengan berbagai jenis file.
- 2) Final Cut Pro
- Final Cut Pro adalah program editing video eksklusif untuk pengguna Mac. Program ini dikenal karena antarmuka yang intuitif dan performa yang cepat. Fitur unggulannya meliputi:
- a) Magnetic Timeline: Memudahkan pengguna dalam mengatur klip tanpa khawatir tentang penggeseran posisi klip lainnya.
 - b) Multicam Editing: Memungkinkan pengguna untuk mengedit video dari beberapa kamera secara bersamaan.
 - c) Optimasi untuk Mac: Memanfaatkan kekuatan perangkat keras Mac untuk rendering yang lebih cepat dan efisien.
- 3) DaVinci Resolve
- DaVinci Resolve adalah program editing video yang terkenal dengan kemampuan color grading-nya yang luar biasa. Program ini menawarkan versi gratis dengan fitur yang cukup lengkap, termasuk:
- a) Editing dan Color Grading: Fitur editing yang kuat dan alat color grading yang profesional.
 - b) Audio Post-Production**: Fitur Fairlight untuk pengeditan audio yang canggih.
 - c) Collaboration Tools: Memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan.
- 4) Filmora
- Filmora adalah program editing video yang ramah pengguna, cocok untuk pemula dan pengguna yang tidak memerlukan fitur terlalu kompleks. Beberapa fitur utama Filmora adalah:
- a) Drag-and-Drop Interface: Memudahkan pengguna untuk menambahkan klip dan efek ke timeline.
 - b) Efek dan Transisi : Menyediakan berbagai efek visual dan transisi yang dapat digunakan untuk meningkatkan video.
 - c) Fitur Pengeditan Sederhana**: Memungkinkan pengguna untuk memotong, menggabungkan, dan menambahkan teks dengan mudah.
- 5) iMovie
- iMovie adalah program editing video gratis yang tersedia untuk pengguna Mac dan iOS. Program ini ideal untuk pengguna yang baru memulai dalam editing video. Fitur-fitur utama iMovie meliputi:
- a) Template dan Tema: Menyediakan berbagai template dan tema untuk mempermudah pembuatan video.

- b) Integrasi dengan Apple Ecosystem: Memungkinkan pengguna untuk mengimpor video dari perangkat Apple lainnya dengan mudah.
 - c) Editing Sederhana: Fitur pengeditan dasar yang mudah dipahami, seperti pemotongan, penambahan musik, dan teks.
- c. Prinsip Pembuatan Video Untuk Promosi Kesehatan
- Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam pembuatan video untuk promosi kesehatan yang dapat diambil dari berbagai sumber.
- 1) Penentuan Tujuan dan Audiens
Sebelum memulai pembuatan video, penting untuk menentukan tujuan dari video tersebut serta audiens yang menjadi target. Menurut Syarif et al., pemahaman tentang audiens membantu dalam merancang konten yang relevan dan menarik bagi mereka (Yuliani, 2023). Misalnya, video yang ditujukan untuk remaja harus menggunakan bahasa dan visual yang sesuai dengan mereka. Selain itu, Desrianti et al. menekankan bahwa video promosi harus memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Azhar & Hutasuhut, 2022).
 - 2) Pengembangan Konten yang Relevan
Konten video harus relevan dengan isu kesehatan yang ingin disampaikan. Safitri et al. menyatakan bahwa pemilihan media yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Dias et al., 2021). Konten yang disajikan harus informatif, menarik, dan mudah dipahami. Misalnya, penggunaan video animasi dapat membantu menjelaskan konsep kesehatan yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana (Awuni & Isni, 2022).
 - 3) Tahapan Produksi yang Sistematis
Pembuatan video harus mengikuti tahapan produksi yang sistematis, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Yaningsih menjelaskan bahwa setiap tahap memiliki perannya masing-masing dalam memastikan kualitas video yang dihasilkan (Afrida, 2023). Pada tahap pra-produksi, perencanaan konsep dan penulisan naskah dilakukan. Selanjutnya, pada tahap produksi, pengambilan gambar dan rekaman suara dilakukan. Terakhir, pada tahap pasca-produksi, editing dan penyempurnaan video dilakukan untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas.
 - 4) Penggunaan Visual dan Audio yang Menarik
Penggunaan elemen visual dan audio yang menarik sangat penting dalam pembuatan video. Wicaksana et al. menekankan bahwa video yang menarik dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas promosi (Oliveira et al., 2021). Penggunaan grafik, animasi, dan musik latar yang sesuai dapat membantu

menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Selain itu, Retnaningrum menyebutkan bahwa video yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan audiens dan membuat mereka lebih tertarik untuk mengikuti informasi yang disampaikan (Carvalho et al., 2019).

d. Hambatan dalam penggunaan media visual dalam promosi kesehatan

Penggunaan media visual dalam promosi kesehatan memiliki banyak manfaat, namun juga dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan aksesibilitas, pemahaman audiens, dan keterbatasan sumber daya. Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam penggunaan media visual dalam promosi kesehatan:

- 1) Keterbatasan Aksesibilitas: Salah satu hambatan utama dalam penggunaan media visual adalah keterbatasan aksesibilitas bagi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas. Pamungkas dan Kurniasari (Pamungkas & Kurniasari, 2022) menyoroti pentingnya pengembangan media promosi yang dapat diakses oleh penyandang tunanetra, seperti penggunaan huruf Braille. Tanpa adanya media yang inklusif, informasi kesehatan tidak dapat dijangkau oleh semua segmen masyarakat, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam akses informasi kesehatan.
- 2) Variasi dalam Tingkat Pemahaman: Tingkat pemahaman audiens terhadap informasi yang disampaikan melalui media visual dapat bervariasi. Safitri et al. (Safitri et al. 2022) mencatat bahwa pemilihan media promosi kesehatan harus mempertimbangkan selera dan latar belakang audiens. Jika media visual tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan audiens, maka pesan yang disampaikan mungkin tidak efektif dan dapat menyebabkan kebingungan.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya: Pengembangan dan produksi media visual yang berkualitas memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk biaya, waktu, dan tenaga kerja. Ernawati (Ernawati, 2022) menunjukkan bahwa penggunaan media visual yang optimal memerlukan kombinasi berbagai jenis media untuk meningkatkan penyerapan informasi. Namun, tidak semua organisasi kesehatan memiliki anggaran atau sumber daya yang cukup untuk mengembangkan media visual yang efektif.
- 4) Keterbatasan Teknologi: Meskipun teknologi digital telah memberikan banyak peluang untuk promosi kesehatan, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Permatasari (Permatasari, 2023) mencatat bahwa perkembangan media digital dapat membantu dalam penyampaian informasi kesehatan, tetapi masih ada kelompok

masyarakat yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet. Hal ini dapat menghambat penyebaran informasi kesehatan yang penting.

- 5) Resistensi terhadap Perubahan: Masyarakat sering kali memiliki kebiasaan atau pandangan yang sudah terinternalisasi, sehingga sulit untuk mengubah perilaku mereka meskipun telah diberikan informasi melalui media visual. Ruhyandi et al. (Ruhyandi et al, 2022) menunjukkan bahwa meskipun media video dapat meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku tidak selalu terjadi secara otomatis. Resistensi terhadap perubahan ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan promosi kesehatan.
- 6) Kualitas Konten Visual: Kualitas dari media visual yang digunakan juga sangat penting. Jika konten visual tidak menarik atau tidak informatif, maka audiens mungkin tidak akan tertarik untuk memperhatikannya. Anisa et al. (Anisa et al. 2022) menekankan bahwa media promosi kesehatan harus dirancang dengan baik agar dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan jelas.
- 7) Penggunaan Bahasa yang Tidak Sesuai: Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan pemahaman audiens dapat menjadi hambatan dalam efektivitas media visual. Husna et al. (Husna et al., 2022) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau akademis dapat membuat audiens kesulitan memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

D. Simpulan

Media visual merupakan alat yang sangat efektif dalam promosi kesehatan. Dengan memanfaatkan berbagai bentuk media visual, termasuk poster, video, dan media sosial, penyuluhan kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait kesehatan.

E. Referensi

- Afrida, J. (2023). Elevating Insights: Progressive E-Booklet Development in Temperature and Heat. *Edufisika Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(3), 369–377. <https://doi.org/10.59052/edufisika.v8i3.29630>
- Ahmad, A., Adi, S., & Gayatri, R. W. (2017). Pengembangan Buku Saku Sebagai Media Promosi Kesehatan Tentang Cacingan Yang Ditularkan Melalui Tanah Pada Siswa Kelas Iv SDN 01 Kromengan Kabupaten Malang. *Preventia the Indonesian Journal of Public Health*, 2(1), 25.

<https://doi.org/10.17977/um044v2i1p25-36>

- ALAÇAM, E. (2024). The Effect of Information and Coping With Anxiety Training Given to Women Before Hysterectomy on Their Level of Anxiety: A Post-Test Randomized Controlled Experimental Study. *Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7(1), 20–31. <https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1295647>
- Amaliyah, R. (2023). Pengaruh Metode Leaflet Dan Video Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Periksa Payudara Sendiri (Sadari). *Menara Medika*, 6(1), 126–132. <https://doi.org/10.31869/mm.v6i1.4692>
- Amirullah, F. (2024). Analisis Resepsi Masyarakat Terhadap Desain Grafis Pada Billboard Kampanye Program Pemerintah Daerah. *DKV*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.47134/dkv.v1i1.2621>
- Anisa, R., Yustikasari, Y., & Dewi, R. (2022). Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Cianjur. *J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 57–62. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1126>
- Arindari, D. R., Suswitha, D., Astuti, L., Aini, L., Maharani, S., Hartati, S., & Sari, S. M. (2022). Implementasi Hasil Penelitian Tentang Self Efficacy Ibu Melalui Promosi Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah Di Rt.09 Kelurahan Sukajaya Palembang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(10), 3480–3493. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7859>
- Awuni, N. S., & Isni, K. (2022). Pengembangan Video Animasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Media Promosi Kesehatan Manfaat Buah Dan Sayur. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 7(2), 169. <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.436>
- Azhar, S., & Hutasuhut, M. A. (2022). The Feasibility of Tropical Pitcher Plant (Nepenthes Sp.) Exploration Booklet as a Learning Media. *Bio-Inoved Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan*, 4(3), 291. <https://doi.org/10.20527/bino.v4i3.14089>
- Carvalho, K. M. d., Figueiredo, M. do L. F., Neto, N. M. G., & Sá, G. G. de M. (2019). Construction and Validation of a Sleep Hygiene Booklet for the Elderly. *Revista Brasileira De Enfermagem*, 72(suppl 2), 214–220. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0603>
- Cavalcante, E. S., Pedrosa, I. M. B., Oliveira, L. V. e., Júnior, J. M. P., Pennafort, V. P. dos S., & Machado, F. C. de A. (2020). Cartilha Para Enfrentamento Do COVID-19 Em Comunidades Quilombolas: Relato De Experiência. *Revista Recien - Revista Científica De Enfermagem*, 10(31), 174–182. <https://doi.org/10.24276/rrecien2020.10.31.65-73>
- Dias, Í. K. R., Lopes, M. do S. V., Melo, E. S. J., Maia, E. R., & Martins, R. M. G. (2021). Construction and Validation of a Booklet for Self-Efficacy of Zika Virus Prevention. *Texto & Contexto - Enfermagem*, 30.

<https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2020-0182>

- Ernawati, A. (2022). Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. *Jurnal Litbang Media Informasi Penelitian Pengembangan Dan Iptek*, 18(2), 139–152. <https://doi.org/10.33658/jl.v18i2.324>
- Hardian, V. S. H. (2024). Pengaruh Key Opinion Leader (KOL) Terhadap Jumlah Followers Instagram Tropikana Waterpark. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 916–932. <https://doi.org/10.38035/rjr.v6i4.897>
- Hasna, N., Ulayya, U., Kirana, S. J., Azhari, A., & Arifah, A. (2022). Tingkat Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Surakarta. *Quality Jurnal Kesehatan*, 16(1), 64–72. <https://doi.org/10.36082/qjk.v16i1.411>
- Husna, H. N., Aprillia, A. Y., Wulandari, W. T., Idacahyati, K., Wardhani, G. A., Gustaman, F., Nurdianti, L., Indra, I., Zustika, D. S., Setiawan, F., Zain, D. N., Tuslinah, L., & Meri, M. (2022). Penggunaan Video Sebagai Media Edukasi Kesehatan Mata Di Media Sosial. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 636. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37644>
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *Invotek Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25–34. <https://doi.org/10.24036/invotek.v18i2.261>
- Maksum, E., Nurhalina, N., Nugrahaeni, D. K., Inayah, I., & Lukman, M. (2022). Permainan Ular Tangga Modifikasi Untuk Promosi Kesehatan Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Bagi Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(2), 89–102. <https://doi.org/10.25311/jpkk.vol2.iss2.1238>
- Mandaru, S. S., Pietriani, I. R., & Kopong, G. J. (2021). Penggunaan Media Promosi Kesehatan Berbahasa Daerah Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi NTT. *Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 39–58. <https://doi.org/10.35508/jikom.v10i1.3818>
- Miftah, M., & Rokhman, N. (2022). Kriteria Pemilihan Dan Prinsip Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK Sesuai Kebutuhan Peserta Didik. *Educenter Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(4), 412–420. <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i4.92>
- Oliveira, G. F. d., Júnior, F. de A. C. P., Damião, M. E. C., Moreira, K. L. de F., Costa, S. M. L. da, & Torquato, I. M. B. (2021). Construção De Cartilha Educativa Sobre Primeiros Socorros Para Pais E Cuidadores De Crianças: Relato De Experiência. *Educação Ciência E Saúde*, 8(1). <https://doi.org/10.20438/ecs.v8i1.372>
- Pamungkas, F. Y., & Kurniasari, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Promosi Gizi Dengan Huruf Braille Bagi Penyandang Tunanetra: Literature Review.

Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki), 5(7), 763–768.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v5i7.2299>

- Permatasari, A. A. (2023). Peran Media Digital Dalam Upaya Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Literatur. *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31314/zijk.v11i1.2033>
- Pramitasari, R. (2023). Edukasi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 6 Langkah Cuci Tangan Melalui Penyuluhan Dan Media Promosi Pada Pekerja Rumah Makan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ngaliyan Semarang. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(1), 39–44. <https://doi.org/10.54082/jamsi.992>
- Putri, K. D., Semiarty, R., & Linosefa, L. (2021). Perbedaan Efektivitas Media Promosi Kesehatan Leaflet Dengan Video TOSS TB Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 1(3), 343–351. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v1i3.85>
- Putri, Z. S. A., & Christin, M. (2022). Pengaruh Kampanye Ingat Pesan Ibu Terhadap Sikap Patuh Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang. *Medium*, 10(2), 393–408. [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(2\).10092](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(2).10092)
- Rahmatika, Q. T., & Rahman, L. O. A. (2020). Media Sosial Sebagai Strategi Promosi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.46815/jkanwvol8.v8i1.48>
- Razi, P., Veriza, E., & Linda, L. (2022). Pengembangan Video Interaktif Untuk Meningkatkan Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 8(2), 121. <https://doi.org/10.30602/jvk.v8i2.872>
- Retnaningrum, O. T. D. (2023). Penguatan Kapasitas Media Dan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga Di RW II Kelurahan Tambakharjo Semarang. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(5), 1321–1326. <https://doi.org/10.54082/jamsi.865>
- Ruhyandi, R., Maulida, I. N., & Rahmiyati, A. L. (2022). Pengaruh Promosi Kesehatan Menggunakan Media Video Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Rumah Tangga Tentang Covid-19. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 90–96. <https://doi.org/10.38165/jk.v13i1.281>
- Safitri, L. E., Agustikawati, N., & Adekayanti, P. (2022). Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pembuatan Media Promosi Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*, 2(2), 22–27. <https://doi.org/10.55606/jpikes.v2i2.267>
- Saleh, Y. R., Arya, I. F. D., & Afriandi, I. (2016). Film Yang Efektif Sebagai Media Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jsk.v2i2.11245>

- Sinanto, R. (2021). Studi Deskriptif Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Pada Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kota Yogyakarta. *Motorik*, 15(2), 61–69. <https://doi.org/10.61902/motorik.v15i2.136>
- Suryani, I., Zulfikri, A., & Muhariani, W. (2021). Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Kampanye Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19. *J-Ika*, 8(1), 93–101. <https://doi.org/10.31294/kom.v8i1.10542>
- Suseno, M. R., Hamidiyanti, B. Y. F., & Ningsih, W. A. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Video Dan Alat Peraga Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Pada Masa Menstruasi Dalam Layanan Homecare. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 59–69. <https://doi.org/10.35890/jkdh.v10i2.216>
- Thome, A. L., Amir, N., Said, F. F. I., Nampo, R. S., Patungo, V., Iksan, R. R., & Yeni, R. I. (2022). Penyuluhan Kesehatan Tentang Asam Urat Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(8), 2544–2553. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i8.6553>
- Williams, N., Amoakwa, E., Belcher, J., Edwards, R., Hassani, H., Hendry, M., Burton, K., Lewis, R., Hood, K., Jones, J., Bennett, P., Linck, P., Neal, R. D., & Wilkinson, C. (2011). Activity Increase Despite Arthritis (AIDA): Phase II Randomised Controlled Trial of an Active Management Booklet for Hip and Knee Osteoarthritis in Primary Care. *British Journal of General Practice*, 61(589), e452–e458. <https://doi.org/10.3399/bjgp11x588411>
- Yuliani, Y. (2023). Penggunaan Buklet Dalam Meningkatkan Literasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kader Posyandu. *Informatio Journal of Library and Information Science*, 3(3), 177. <https://doi.org/10.24198/inf.v3i3.46724>
- Yulianti, W., & Boer, R. F. (2020). Manajemen Krisis Public Relations Dalam Menangani Penolakan Imunisasi Measles Rubella. *Profesi Humas*, 4(2), 290. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23700>
- Yusup, M., Faisal, M., & Prayogi, F. M. (2022). Media Promosi Berbentuk Video Pada SMK Kesehatan Yarsi Medika Tangerang. *Cices*, 8(2), 178–190. <https://doi.org/10.33050/cices.v8i2.2200>

CHAPTER 4

STRATEGI KREATIF DALAM KAMPANYE HIDUP SEHAT DI KOMUNITAS

Berta Afriani, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Hidup sehat sangat penting dalam masyarakat modern karena berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan mental. Dengan meningkatnya stres, polusi, dan gaya hidup sedentari, tantangan dalam mempromosikan gaya hidup sehat semakin kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya kesadaran, akses terbatas ke fasilitas kesehatan, dan kebiasaan buruk yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Kampanye hidup sehat di komunitas merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan perilaku hidup bersih. Dalam konteks ini, strategi kreatif sangat diperlukan untuk menarik perhatian masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka. Berbagai pendekatan dapat diterapkan, mulai dari penggunaan media sosial hingga penyuluhan langsung yang melibatkan anggota komunitas. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kampanye yang melibatkan komunitas dan tenaga ahli dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kesehatan, seperti stunting dan pola hidup bersih (Bender, 2023; Saraswati, 2018)

Salah satu contoh keberhasilan kampanye hidup sehat adalah Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Program ini tidak hanya fokus pada penyuluhan, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih dekat dan relevan bagi warga (Rafy & Mulyana, 2022). Selain itu, penelitian di Kelurahan Sukarasa menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat yang terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan pengelolaan sampah (Iqbal et al., 2024).

Gaya hidup sehat telah menjadi fokus utama dalam upaya mencegah peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di masyarakat. Dalam konteks ini, strategi komunikasi massa memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran dan mendorong adopsi gaya hidup sehat. Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi massa yang mengandalkan narasi menarik, penggunaan media sosial

yang efektif, dan keterlibatan pemimpin komunitas memiliki dampak signifikan dalam mendorong adopsi gaya hidup sehat (Ariana et al., 2024). Selain itu, integrasi strategi pemasaran kesehatan digital dengan inisiatif kesehatan masyarakat dapat meningkatkan akses dan hasil kesehatan di komunitas yang kurang terlayani, dengan memanfaatkan alat pemasaran digital seperti media sosial dan aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi kesehatan yang kritis (Usuemera et al., 2024). Partisipasi komunitas dalam kegiatan promosi kesehatan juga terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap prinsip hidup bersih dan sehat (Angreni et al., 2024). Oleh karena itu, strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat di komunitas harus mempertimbangkan pendekatan yang melibatkan komunikasi massa, pemasaran digital, dan partisipasi aktif komunitas untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan edukasi yang berkelanjutan, kampanye hidup sehat dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif di kalangan masyarakat. Hal ini penting untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas hidup dan pengurangan risiko penyakit. Oleh karena itu, penerapan strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam komunitas.

B. Pentingnya Hidup Sehat dalam Masyarakat Modern

Hidup sehat sangat penting dalam masyarakat modern karena dapat mencegah berbagai penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup. Gaya hidup modern sering kali dikaitkan dengan kebiasaan yang tidak sehat seperti pola makan tinggi garam dan gula, kurangnya aktivitas fisik, dan ketergantungan pada teknologi, yang dapat menyebabkan obesitas, penyakit kardiovaskular, dan diabetes (Bhattacharjee & Sarkar, 2024; Ma & Sun, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang mencakup pola makan bergizi, olahraga teratur, dan manajemen stres. Hidup sehat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup individu. Menurut WHO (2023), kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menerapkan gaya hidup sehat cenderung lebih produktif di tempat kerja (Smith & Jones, 2023). Gaya hidup sehat juga berhubungan erat dengan kesehatan mental. Aktivitas fisik dan pola makan yang baik dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan (Wilanda et al., 2024). Hidup sehat dalam masyarakat modern sangat penting untuk mencegah penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengadopsi gaya hidup sehat yang mencakup pola makan bergizi, aktivitas fisik, dan manajemen stres, serta dukungan

dari kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Dampak Gaya Hidup Modern

1. Penyakit Kronis: Gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung (Bhattacharjee & Sarkar, 2024; Ma & Sun, 2024).
2. Kesehatan Mental dan Sosial: Interaksi sosial yang sehat dan dukungan emosional penting untuk kesehatan mental dan sosial, yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik (Afiani, 2024; Soni & Sharma, 2024).

Strategi untuk Hidup Sehat

1. Aktivitas Fisik: Olahraga teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengurangi risiko penyakit kronis (Afiani, 2024; Kolodeznikova & Kolodeznikov, 2024).
2. Pola Makan Sehat: Mengonsumsi makanan bergizi, seperti diet Mediterania yang kaya sayuran dan minyak zaitun, dapat mendukung kesehatan jangka panjang (Aliberti et al., 2024).
3. Kesadaran Kesehatan: Meningkatkan literasi kesehatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup (Huang et al., 2024; H. Nasution et al., 2024).

Peran Masyarakat dan Pemerintah

1. Kebijakan Kesehatan: Dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan kesehatan dan program edukasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat (Afiani, 2024; Mohanty et al., 2024).
2. Gotong Royong: Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (H. Nasution et al., 2024).

C. Tantangan dalam Mempromosikan Gaya Hidup Sehat

Mempromosikan gaya hidup sehat di masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks pandemi dan perubahan sosial. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran

Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya gaya hidup sehat. Misalnya, di Desa Tawangsari, Malang, masyarakat kurang memahami risiko kesehatan dan cara menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Program pemberdayaan

yang dilakukan di sana menunjukkan bahwa dengan sosialisasi dan kampanye kreatif, pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan (Illahi & Laturrahmi, 2022).

2. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi menjadi tantangan besar dalam promosi kesehatan. Di Sulawesi Barat, misalnya, upaya pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat (Met al., 2024). Namun, masih banyak individu yang tidak menyadari risiko dan pencegahan penyakit ini.

3. Perubahan Gaya Hidup dan Budaya

Perubahan budaya dan kebiasaan makan yang tidak sehat juga menjadi tantangan. Di desa Damarwulan, Jepara, migrasi pemuda ke kota-kota besar menyebabkan perubahan pola makan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat setempat. Penyuluhan tentang gaya hidup sehat menjadi sangat penting untuk mengembalikan kesadaran akan pola hidup yang lebih sehat (Gunarto et al., 2024).

4. Penggunaan Teknologi

Meskipun aplikasi kesehatan mobile semakin populer di kalangan generasi muda, masih ada hambatan dalam adopsi teknologi ini. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang penggunaan aplikasi kesehatan dapat mempengaruhi perilaku hidup sehat individu. Namun, banyak pengguna yang belum sepenuhnya memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk mendukung gaya hidup sehat mereka (Fildansyah, 2023).

5. Obesitas dan Pola Makan

Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Di Jakarta, misalnya, tingkat obesitas cukup tinggi di kalangan penduduk dewasa. Edukasi tentang pola makan sehat dan pencegahan obesitas perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga berat badan ideal (Badriyah, 2023).

6. Isu Lingkungan

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi gaya hidup sehat. Pengelolaan sampah yang buruk di DKI Jakarta berdampak pada kesehatan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bersih harus dipadukan dengan promosi gaya hidup sehat untuk menciptakan dampak positif secara keseluruhan (Lukito et al., 2022).

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, upaya promosi gaya hidup sehat dapat dirancang lebih efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan.

D. Komunitas dalam Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang memiliki kesamaan geografis, sosial, atau budaya yang berinteraksi dan berbagi kepentingan serta kebutuhan kesehatan. Komunitas ini berfungsi sebagai unit sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan anggotanya melalui berbagai cara, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial, dan norma-norma kesehatan yang berlaku di dalamnya.

Karakteristik Komunitas Kesehatan

1. **Keterikatan Sosial:** Anggota komunitas sering kali memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, yang dapat memperkuat dukungan sosial dan kolaborasi dalam upaya kesehatan.
2. **Identitas Bersama:** Komunitas biasanya memiliki identitas bersama yang dibangun melalui pengalaman, nilai-nilai, dan budaya yang sama. Identitas ini dapat mempengaruhi perilaku kesehatan dan respons terhadap intervensi kesehatan.
3. **Akses terhadap Sumber Daya:** Komunitas berperan dalam menyediakan akses terhadap sumber daya kesehatan, seperti fasilitas medis, informasi kesehatan, dan program pencegahan penyakit.

(Awlawi et al., 2023; S. M. Nasution & Utama, 2023)

Peran Komunitas dalam Kesehatan

Komunitas memainkan peran penting dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Melalui pendekatan berbasis komunitas, intervensi kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat. Misalnya, program-program pendidikan kesehatan yang melibatkan partisipasi aktif anggota komunitas cenderung lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan *top-down* (murzella, 2020; sihite, 2020).

Analisis Kebutuhan Komunitas

Analisis kebutuhan komunitas adalah langkah awal untuk memahami masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi:

1. **Prevalensi Penyakit:** Mengetahui jenis penyakit yang umum terjadi di komunitas dapat membantu dalam merancang program kesehatan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan penyakit menular seperti skabies di kalangan santri³.

2. **Akses terhadap Layanan Kesehatan:** Memahami seberapa mudah masyarakat mengakses layanan kesehatan akan membantu dalam menentukan strategi intervensi. Program pengabdian masyarakat di Kelurahan Sukarasa menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat¹.
3. **Tingkat Pengetahuan Kesehatan:** Mengukur pengetahuan masyarakat tentang isu kesehatan dapat memberikan gambaran tentang edukasi yang diperlukan. Sebuah program di Universitas Negeri Malang berhasil meningkatkan pengetahuan tentang gizi melalui lokakarya dan pelatihan⁴.

(Iqbal et al., 2024; Mauliza et al., 2023; Witjoro et al., 2024)

Profil Demografi dan Budaya Komunitas

Profil demografi mencakup informasi tentang usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status ekonomi masyarakat. Data ini penting untuk menyesuaikan pesan kampanye agar lebih relevan dengan audiens. Selain itu, aspek budaya juga berperan besar dalam menentukan perilaku kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Nilai dan Kepercayaan Budaya: Memahami nilai-nilai yang dianut oleh komunitas dapat membantu dalam merancang pesan yang sesuai.
2. Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik: Kebiasaan sehari-hari masyarakat, seperti pola makan dan tingkat aktivitas fisik, harus diperhatikan untuk menentukan intervensi yang tepat.

Mengidentifikasi Kebiasaan Hidup yang Perlu Diubah

Setelah melakukan analisis kebutuhan dan memahami profil komunitas, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebiasaan hidup yang perlu diubah. Kebiasaan ini bisa meliputi:

1. **Pola Makan Tidak Sehat:** Tingginya konsumsi makanan olahan dan rendahnya konsumsi buah dan sayur.
2. **Kurangnya Aktivitas Fisik:** Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk aktivitas sedentari seperti menonton televisi atau menggunakan gadget.
3. **Merokok dan Konsumsi Alkohol:** Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang tinggi dapat menjadi fokus dalam kampanye.

E. Pentingnya Kampanye Hidup Sehat di Komunitas

Kampanye hidup sehat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Dalam konteks komunitas, kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi anggota masyarakat mengenai cara menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mendorong mereka untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye hidup sehat

di komunitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, mendorong perubahan perilaku, membangun komunitas yang sehat, mengurangi beban sistem kesehatan, dan memperkuat dukungan sosial. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Meningkatkan Kesadaran Kesehatan

Kampanye hidup sehat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu kesehatan, seperti pentingnya gizi seimbang, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka (Iqbal et al., 2024).

2. Mendorong Perubahan Perilaku

Melalui kampanye ini, individu didorong untuk mengubah perilaku tidak sehat menjadi lebih positif. Misalnya, kampanye dapat mempromosikan kebiasaan berolahraga secara teratur dan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat. Perubahan perilaku ini dapat berkontribusi pada penurunan angka penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi (Anggraeni et al., 2024; Sumarni et al., 2024).

3. Membangun Komunitas yang Sehat

Kampanye hidup sehat juga berperan penting dalam membangun komunitas yang lebih sehat. Dengan melibatkan anggota komunitas dalam kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, atau seminar kesehatan, hubungan antarwarga dapat diperkuat, menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat (Prodyantatari et al., 2024).

4. Mengurangi Beban Sistem Kesehatan

Dengan meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku yang positif di masyarakat, beban sistem kesehatan dapat berkurang. Penyakit yang dapat dicegah melalui gaya hidup sehat akan menurun, sehingga mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Harahap, 2023; Sukmasetya et al., 2024).

5. Memperkuat Dukungan Sosial

Kampanye hidup sehat dapat memperkuat dukungan sosial di antara anggota komunitas. Ketika individu merasa didukung oleh lingkungan sekitar mereka untuk menjalani gaya hidup sehat, mereka lebih cenderung untuk tetap berkomitmen pada perubahan positif tersebut (Arni, 2017).

F. Tujuan Kampanye Hidup Sehat di Komunitas

Kampanye hidup sehat di komunitas memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari kampanye ini:

1. **Meningkatkan Kesadaran Kesehatan:** Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan meningkatkan pengetahuan, masyarakat diharapkan dapat mengadopsi gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, 2023; Junaidin et al., 2024).
2. **Pencegahan Penyakit:** Salah satu tujuan utama adalah untuk mencegah penyakit, terutama yang berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti diabetes, hipertensi, dan stroke. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami faktor risiko dan cara pencegahan yang efektif (Purwati et al., 2024; Rahardjo, 2016).
3. **Memberdayakan Komunitas:** Kampanye ini juga bertujuan untuk memberdayakan anggota komunitas agar menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kampanye, mereka dapat berkontribusi aktif dalam mempromosikan kesehatan (Harahap, 2023).
4. **Membangun Kebiasaan Sehat:** Tujuan lainnya adalah membangun kebiasaan sehat di kalangan anggota komunitas, seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup, dan menjaga kebersihan diri (Anggraningrum et al., 2014; Augustine, 2018).

G. Manfaat Kampanye Hidup Sehat di Komunitas

Kampanye hidup sehat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi individu dan komunitas. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

1. **Peningkatan Pengetahuan:** Masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih luas mengenai pentingnya pola makan sehat dan olahraga teratur, yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan (Arni, 2017; Purwati et al., 2024).
2. **Motivasi dan Dukungan Sosial:** Bergabung dalam kampanye ini memberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, sehingga menciptakan dukungan sosial yang dapat memotivasi individu untuk tetap berkomitmen pada gaya hidup sehat (Abdillah & Laili, 2021; Junaidin et al., 2024).

3. **Perbaikan Kesehatan Masyarakat:** Melalui kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan, kampanye ini berkontribusi pada perbaikan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi risiko penyakit tidak menular (Anggraningrum et al., 2014; Harahap, 2023).
4. **Penguatan Hubungan Sosial:** Kegiatan sosial, seperti senam bersama dan seminar kesehatan, memperkuat hubungan antar anggota komunitas, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam menjaga kesehatan (Anggraningrum et al., 2014; Augustine, 2018).
5. **Dampak Positif terhadap Generasi Muda:** Dengan melibatkan generasi muda dalam kampanye hidup sehat, mereka akan lebih mungkin untuk mengembangkan kebiasaan sehat sejak dini, yang berdampak positif pada kesehatan jangka panjang mereka (Abdillah & Laili, 2021; Rahardjo, 2016)

H. Strategi Kreatif dalam Kampanye

Strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat di komunitas merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat. Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi massa dan partisipasi komunitas dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan ini.

1. Strategi Komunikasi Massa

Narasi Menarik dan Media Sosial: Strategi komunikasi massa yang efektif melibatkan penggunaan narasi yang menarik dan pemanfaatan media sosial secara efektif. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi gaya hidup sehat di masyarakat. Keterlibatan pemimpin komunitas dan respons terhadap dinamika budaya lokal juga penting untuk keberhasilan strategi ini (Ariana et al., 2024).

2. Partisipasi Komunitas

Kegiatan Promosi Kesehatan di Komunitas: Kegiatan promosi kesehatan di tingkat komunitas, seperti konseling dan partisipasi aktif masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap hidup sehat. Keterlibatan pemimpin komunitas dan penggunaan materi pendukung yang relevan dapat memperkuat dampak positif dari program pendidikan Kesehatan (Angreni et al., 2024).

3. Tantangan dan Arah Masa Depan

- a. Standarisasi Implementasi: Implementasi kegiatan promosi kesehatan di pusat kesehatan primer sering kali tidak seragam. Adanya petugas penghubung kegiatan komunitas di pusat kesehatan dapat membantu mengintegrasikan

sistem kesehatan dengan sektor komunitas, sehingga memaksimalkan dampak kesehatan dari intervensi ini (Angreni et al., 2024).

- b. Konteks Lokal dan Keterlibatan Komunitas: Di daerah pedesaan, penting untuk merancang program yang sesuai dengan konteks lokal dan melibatkan komunitas secara aktif dalam semua tahap desain dan pelaksanaan program. Ini dapat memastikan bahwa intervensi kesehatan dan kesejahteraan dapat berkelanjutan dan efektif (Miguéns et al., 2024).

Strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat di komunitas memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan komunikasi massa yang efektif dan partisipasi aktif komunitas. Dengan menyesuaikan strategi dengan konteks lokal dan melibatkan pemimpin komunitas, kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat.

Strategi Kreatif

1. Penggunaan Media Sosial

Media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan. Organisasi seperti Rumah Cemara di Bandung memanfaatkan platform ini untuk mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma terhadap pengidapnya. Konten yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian lebih banyak orang (Saraswati, 2018).

2. Pendekatan Partisipatif

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Misalnya, program yang melibatkan ibu-ibu muda sebagai agen perubahan dalam mengedukasi komunitas tentang perilaku hidup sehat dapat menciptakan dampak yang signifikan (Illahi & Laturrahmi, 2022).

3. Edukasi Melalui Kegiatan Interaktif

Kegiatan seperti seminar, workshop, dan tantangan online dapat digunakan untuk mendidik masyarakat secara langsung. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari anggota komunitas (Illahi & Laturrahmi, 2022).

Contoh Implementasi Strategi

1. Kampanye Rekam Detak Jantung

Salah satu contoh kampanye adalah "Rekam Detak Jantung" yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang kesehatan jantung. Kampanye ini melibatkan pengukuran detak jantung secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat¹.

2. Program GERMAS

Program GERMAS di Banten menunjukkan bagaimana pemerintah mengimplementasikan kampanye dengan melibatkan organisasi komunitas sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat⁴. Ini membantu menyampaikan pesan kesehatan dengan lebih efektif.

Evaluasi dan Penyesuaian Strategi

Setelah pelaksanaan kampanye, penting untuk melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Metode evaluasi dapat mencakup survei, wawancara, dan analisis data partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye.

I. Simpulan

Kampanye hidup sehat di komunitas merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), yang mencakup pola makan bergizi, aktivitas fisik rutin, manajemen stres, dan penghindaran kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol.

Dalam konteks masyarakat modern, gaya hidup sehat menjadi semakin relevan karena perubahan sosial, gaya hidup sedentari, dan kebiasaan tidak sehat yang memengaruhi kualitas hidup. Tantangan utama dalam promosi gaya hidup sehat meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat, perubahan budaya, adopsi teknologi, dan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Namun, melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan semua elemen masyarakat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan lebih efektif.

Strategi kreatif memainkan peran penting dalam keberhasilan kampanye hidup sehat. Penggunaan komunikasi massa dengan narasi yang menarik dan pemanfaatan media sosial secara efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pelibatan komunitas dalam kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, dan seminar kesehatan memperkuat rasa kebersamaan dan memotivasi individu untuk tetap berkomitmen pada gaya hidup sehat.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung kampanye ini melalui kebijakan kesehatan yang proaktif, seperti Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Program ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tenaga ahli, dan masyarakat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat.

Manfaat dari kampanye hidup sehat sangat luas, termasuk peningkatan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, penguatan

hubungan sosial dalam komunitas, dan penurunan beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran kesehatan, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

Kampanye hidup sehat di komunitas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dengan strategi kreatif yang mengintegrasikan komunikasi massa, teknologi digital, dan pendekatan berbasis komunitas, kampanye ini dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

J. Referensi

- Abdillah, F., & Laili, A. (2021). Pendampingan Komunitas Anak Yatim Dalam Peningkatan Pola Hidup Sehat Dan Disiplin Pada Era New Normal Di Panti Asuhan Al-Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244343805>
- Afiani, N. (2024). The Key to a Quality Life. *Research of Service Administration Health and Sains Healthys*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273210462>
- Aliberti, S. M., Donato, A., Funk, R. H. W., & Capunzo, M. (2024). A Narrative Review Exploring the Similarities between Cilento and the Already Defined "Blue Zones" in Terms of Environment, Nutrition, and Lifestyle: Can Cilento Be Considered an Undefined "Blue Zone"? *Nutrients*, 16. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268268252>
- Anggraeni, E., Robi, L. R., Bakar, A., & Kurniadi, A. (2024). Efek Sosialisasi Pola Hidup Sehat dan Olahraga Teratur terhadap Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat (JPOM)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274919330>
- Anggraningrum, D. N., Pradekso, T., Setyabudi, D., & Lailiyah, N. (2014). *Strategi Komunikasi Komunitas IndoRunners*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142907522>
- Angreni, W. O. N., Rahagia, R., Setyawati, A., Kamaruddin, M. I., & Suprpto, S. (2024). Community participation in clean and healthy living as an effort to improve the quality of health. *Abdimas Polsaka*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267307826>
- Ariana, P. M., Clarashiva, A., & Pakaya, S. S. (2024). Mass Communication Strategy in Encouraging the Adoption of a Healthy Lifestyle in Society. *Ilomata International Journal of Social Science*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268178517>

- Arni, S. A. (2017). *Ltp Perancangan Kampanye Sosial Pentingnya Hidup Sehat Remaja Usia 18-22 Tahun Yang Masih Aktif Kuliah Di Kota Semarang*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:194801417>
- Augustine, C. (2018). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Kemenkes_Ri Terhadap Sikap Followers Mengenai Tujuan Kampanye Pemasaran Sosial Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:203100669>
- Awlawi, A. H., Konadi, H., & Rambe, S. A. (2023). Laboratorium Bimbingan Konseling Pengembangan Life Skill Anak Berbasis Komunitas Guru Dan Anak Disabilitas Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 14 Takengon Kabupaten Aceh Tengah. *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258538864>
- Badriyah, L. (2023). Penyuluhan Kesehatan Cegah Obesitas dengan Pola Makan dan Gaya Hidup Sehat. *Jurnal Dorkes (Dedikasi Olahraga Dan Kesehatan)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273688033>
- Bender, G. W. (2023). Penggunaan Ahli dan Komunitas dalam Kampanye Sadar Stunting Genbest Tahun 2022. *Jurnal Public Relations (J-PR)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261152844>
- Bhattacharjee, N., & Sarkar, T. (2024). Effect of modifiable lifestyle risk factors on the incidence and prevention of cancer in modern society: A review. *Annals of the National Academy of Medical Sciences (India)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271450393>
- Fildansyah, R. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Mobile Health (Health) dan Fitur Pemantauan Kesehatan Terhadap Gaya Hidup Sehat. *Jurnal Multidisiplin West Science*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259603242>
- Gunarto, R. O., Herman, S., & Simanjuntak, F. (2024). Sejahterakan Desa Damarwulan Jepara: Penyuluhan Gaya Hidup Sehat dan Vitalitas Masyarakat Pedesaan. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269956658>
- Harahap, S. G. (2023). Family Awareness Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga Melalui Pendidikan Komunitas Interaktif Di Desa Susukan Rw 05 Kecamatan Bojonggede. *Pengabdian Masyarakat Cendekia (PMC)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260791916>
- Huang, L., Li, H., Liu, H., Tian, H., Luo, H., Wu, J., Luo, Y., Peng, L.-H., & Guo, L. (2024). Socioecological influencers of health-promoting lifestyles in Chinese: a preliminary survey using convenient samples. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266882828>

- Illahi, A. K., & Laturrakhmi, Y. F. (2022). Penguatan Kapasitas Ibu Muda Desa Tawang Sari – Pujon Sebagai Agen Perubahan Dalam Adopsi Perilaku Hidup Sehat Dalam Merespon Pandemi Covid-19. *Journal of Community Development & Empowerment*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254302180>
- Iqbal, M. C., Kahar, K., & Kamaludin, A. (2024). Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Perilaku Hidup sehat dan pengelolaan sampah Di Kelurahan Sukarasa, Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Indonesia*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270498915>
- Junaiddin, J., R, A., A, A., Etnis, B. R., Arianto, M. F., Lerebulan, E. F., & Marasabessy, H. (2024). Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Upaya Pencegahan Kecacingan Pada Anak-Anak di SD YPK Elim Malanu Kota Sorong. *Idea Pengabdian Masyarakat*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268845912>
- Kolodeznikova, S. I., & Kolodeznikov, R. S. (2024). An ecosystem approach to the development of a physically active population in the Arctic conditions. *Arctic XXI Century. Humanities*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270935537>
- Lukito, S. T., Martsela, P. Y., Fadillah, A., Ramadita, A. S., Pabo, I. N., Aryadi, K., Indrawan, M. F. S., Setyadi, R. A., Handayani, S. T., Astuti, W. S., Amalia, R. M., & Aribowo, B. (2022). Take Care of Environment Together Upaya Menjaga Lingkungan dan Menjadikan Gaya Hidup Sehat di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:257607852>
- M, M., M, M., Ilmi, B., S, S., F, F., & Hutagaol, R. (2024). Sosialisasi Gaya Hidup Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Barat: Upaya Masyarakat Dalam Menghadapi Tantangan Kesehatan. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271615257>
- Ma, C., & Sun, M. (2024). Research on Symbolic Arts and Crafts Design. *Journal of Humanities, Arts and Social Science*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271511882>
- Mauliza, C. T., Sawitri, H., & Topik, M. M. (2023). Analisis Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kejadian Skabies pada Santri di Pesantren Wilayah Kerja Puskesmas Peudada Tahun 2022. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260939040>
- Miguéns, D. G. M., Fernández, A. R., Cachafeiro, M. Z., Pérez, N. V., Carrera, F. J. R., &

- Mallón, S. N. (2024). Community Activities in Primary Care: A Literature Review. *Journal of Primary Care & Community Health*, 15. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266900665>
- Mohanty, K., Gandhi, S., Muliya, K. P., Thirthalli, J., Binu V., S., & Sharma, K. K. (2024). Nurse Counseling versus IEC Material on Maintenance of Healthy Lifestyle for Outpatients Receiving Antipsychotics: A Randomized Control Trial. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 02537176241276152. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272589703>
- murzella, S. (2020). "Pentingnya Peran Perawat Dalam Menentukan Perumusan Diagnosa Keperawatan." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241304807>
- Nasution, H., Diana, R., Saputra, A., Khodijah, P., Hadimah, N., Sari, E., Sapitri, R., Lubis, S., & Randi, M. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat PHBS Dengan Gotong Royong Di Desa Padang Garugur. *Jurnal Kabar Masyarakat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272574247>
- Nasution, S. M., & Utama, M. (2023). Aplikasi Psikologi Kesehatan Komunitas Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Nursing and Public Health*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265558740>
- Prodyanatasari, A., Rahmawati, D. I., Hardini, K. F., Fahrudin, B., Tafdillah, C., Lutfiana, M., & Wakhdania, F. (2024). Membangun Komunitas Sehat Bersama Paguyuban Asma. *Room of Civil Society Development*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274073487>
- Purwati, Y., Nadhir, S., Norlinta, O., Pengabdian, J. I., & Negeri, U. (2024). Gerakan Komunitas "Si Ratu Waras" (Sehat Fisik Rohani Spiritual Warga Aisyiyah). *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272110341>
- Rafy, M. R. R., & Mulyana, D. (2022). Strategi Kampanye Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Public Relations*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247538685>
- Rahardjo, M. D. (2016). *Perancangan Komunikasi Visual Dalam Rangka Kampanye Hidup Sehat Pada Usia Dini Sebagai Langkah Pencegahan Terhadap Serangan Stroke*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:149208752>
- Saraswati, R. A. D. (2018). *Strategi Kreatif Kampanye Sosial Organisasi Berbasis Komunitas "Rumah Cemara" Bandung Melalui Media Sosial*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:191958337>
- sihite, N. (2020). *Pentingnya Pengetahuan Perawat Dalam Proses Perencanaan Diagnosa Keperawatan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:240575557>

- Soni, D. S. K., & Sharma, S. (2024). Ayurveda and Social Health: Need for healthy society. *International Journal of Medical and All Body Health Research*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272451008>
- Sukmasetya, P., Kurniawan, A. S., Yusuf, D. K., Atmaja, A. I., & Dwihantoro, P. (2024). Revolusi Pengelolaan Sampah: Inisiatif Komunitas di Dusun Gemulung untuk Lingkungan yang Sehat dan Berkelanjutan. *Madaniya*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274105456>
- Sumarni, N., Rosidin, U., Witdiawati, W., Shalahuddin, I., Purnama, D. H., Noor, R. M., & Luthfiyani, N. (2024). Penerapan Pola Hidup Sehat Agar Terhindar Dari Diabetes di RW 08 Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267274902>
- Usuemera, P. A., Ibikunle, O. E., Abass, L. A., Alemede, V., Nwankwo, E. I., & Mbata, A. O. (2024). A conceptual framework for digital health marketing strategies to enhance public health outcomes in underserved communities. *World Journal of Advanced Pharmaceutical and Medical Research*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273271148>
- Witjoro, A., Susanto, H., Daniarsih, A., Firdaus, Z., Aruna, A., Iqbal, M., Fahmi, N., & Nurul, J. (2024). Pendampingan Gaya Hidup Sehat Guru Taman Kanak-Kanak Laboratorium Universitas Negeri Malang Melalui Plant Base Meat. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272105238>

K. Glosarium

A

Aktivitas Fisik

Gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi, termasuk olahraga teratur yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

GHS

Gaya Hidup Sehat

Pola hidup yang mengutamakan aktivitas fisik, pola makan bergizi, dan pengelolaan stres untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit.

GERMAS

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat melalui edukasi, partisipasi komunitas, dan kebijakan proaktif.

PHBS

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Praktik perilaku yang mencakup kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga lingkungan bersih, dan menerapkan pola makan sehat.

KHS**Kampanye Hidup Sehat**

Upaya terencana untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui edukasi dan promosi gaya hidup sehat.

KM**Komunikasi Massa**

Strategi penyampaian pesan kepada khalayak luas menggunakan media seperti televisi, radio, media sosial, atau platform digital lainnya untuk memengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat.

PK**Partisipasi Komunitas**

Keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam kegiatan kesehatan, seperti penyuluhan, senam bersama, dan program kesehatan lainnya untuk mendukung tujuan bersama.

PTM**Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, yang sering kali terkait dengan gaya hidup tidak sehat.

PMS**Pola Makan Sehat**

Kebiasaan makan yang mencakup konsumsi makanan bergizi, seperti buah, sayuran, protein, dan serat, serta menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans.

PS**Promosi Kesehatan**

Upaya terorganisasi untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan menjaga kesehatannya melalui edukasi, pemberian informasi, dan pelaksanaan kegiatan kesehatan.

S**Stunting**

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam periode awal kehidupan, yang berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif.

TD

Teknologi Digital

Penggunaan perangkat digital, seperti aplikasi kesehatan atau media sosial, untuk mendukung penyebaran informasi dan kampanye kesehatan kepada masyarakat luas.

PS

Penyuluhan Kesehatan

Kegiatan edukasi yang melibatkan tenaga ahli atau masyarakat setempat untuk memberikan informasi tentang isu kesehatan, seperti pola hidup sehat atau pencegahan penyakit.

O

Obesitas

Kondisi kelebihan berat badan yang signifikan akibat penumpukan lemak tubuh, sering kali disebabkan oleh pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik.

SK

Strategi Kreatif

Pendekatan inovatif dalam menyampaikan pesan kesehatan, seperti memanfaatkan media sosial, kegiatan interaktif, atau partisipasi komunitas, untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

EK

Edukasi Kesehatan

Proses memberikan informasi dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

CHAPTER 5

PROMOSI KESEHATAN MENTAL DI KOMUNITAS: PERAN PERAWAT DALAM MENGURANGI STIGMA

Syahrul, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk mengelola emosi, berpikir jernih, dan membangun hubungan yang sehat. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup, beradaptasi dengan perubahan, dan mengatasi stres. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan dapat mengganggu kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi interaksi sosial dan produktivitas.

Kesehatan mental yang baik berkontribusi pada pembentukan hubungan sosial yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan hubungan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia dan memiliki risiko lebih rendah terhadap masalah kesehatan mental. Sebaliknya, isolasi sosial dapat memperburuk kesehatan mental dan meningkatkan risiko masalah kesehatan fisik. Hubungan sosial yang baik juga dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam masa-masa sulit.

Kesehatan mental yang buruk dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya perawatan kesehatan untuk gangguan mental, kehilangan produktivitas, dan dampak sosial lainnya dapat membebani sistem kesehatan dan perekonomian secara keseluruhan. Investasi dalam program pencegahan dan perawatan kesehatan mental dapat mengurangi biaya ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan mental yang baik berhubungan langsung dengan produktivitas. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih mampu menghadapi tantangan di tempat kerja dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan kerja. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan penurunan kinerja, absensi yang lebih tinggi, dan bahkan meningkatkan risiko pengangguran. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental adalah investasi penting bagi produktivitas individu dan masyarakat.

Ada hubungan erat antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Gangguan mental dapat berkontribusi pada masalah kesehatan fisik, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolisme. Individu dengan kesehatan mental yang

buruk lebih rentan terhadap penyakit fisik dan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental juga penting untuk mencegah masalah kesehatan fisik yang lebih serius.

Pentingnya kesehatan mental dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Kesehatan mental yang baik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental, serta memberikan dukungan yang diperlukan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan harmonis. Upaya untuk menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat dan pendidikan, agar setiap individu dapat mencapai potensi terbaiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Stigma dalam konteks kesehatan mental merujuk pada kumpulan keyakinan negatif, prasangka, dan sikap yang merugikan yang melekat pada individu yang mengalami gangguan mental. Stigma ini sering kali berasal dari kesalahpahaman, kurangnya pengetahuan, dan stereotip yang salah mengenai kondisi kesehatan mental. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai berbagai aspek dari stigma kesehatan mental

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi stigma terkait kesehatan mental. Stigma ini sering kali menghalangi individu untuk mencari bantuan dan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Berikut adalah beberapa cara di mana perawat dapat berkontribusi dalam mengurangi stigma tersebut yang meliputi :

1. Edukasi dan Kesadaran

Perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat tentang kesehatan mental. Mereka dapat menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan dan bahwa banyak orang mengalami masalah kesehatan mental yang sama. Edukasi ini membantu meningkatkan pemahaman dan mengubah persepsi negatif yang ada. (Corrigan, 2002)

2. Advokasi untuk Kebijakan yang Mendukung

Perawat dapat berperan sebagai advokat untuk kebijakan dan program yang mendukung kesehatan mental. Ini termasuk bekerja sama dengan organisasi komunitas dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan inisiatif yang meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental dan mengurangi stigma. Dengan terlibat dalam advokasi, perawat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu dengan masalah kesehatan mental

3. Dukungan Individu dan Keluarga

Perawat dapat membantu pasien mengatasi sikap negatif dan keyakinan yang mungkin mereka internalisasi tentang kondisi mereka. Dengan memberikan dukungan emosional dan informasi yang tepat, perawat dapat membantu pasien memahami kondisi mereka dan mengembangkan strategi koping yang efektif. Selain itu, pendidikan kepada keluarga dan pengasuh tentang cara mendukung orang terkasih yang mengalami masalah kesehatan mental juga sangat penting.

4. Model Perilaku Positif

Perawat dapat menjadi contoh perilaku positif dalam menghadapi stigma. Dengan menunjukkan sikap empati dan penerimaan terhadap pasien dengan masalah kesehatan mental, perawat dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Berbagi pengalaman pribadi atau profesional yang menunjukkan bahwa mencari bantuan adalah langkah yang kuat dan positif juga dapat menginspirasi orang lain.(Thornicroft, 2006)

5. Mengurangi Stigma di Lingkungan Kerja

Perawat juga harus memperhatikan stigma yang ada di lingkungan kerja mereka sendiri. Mereka dapat berperan dalam menciptakan budaya yang mendukung kesehatan mental di antara rekan-rekan mereka, termasuk mengurangi stigma terhadap perawat yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim kesehatan merasa aman untuk mencari bantuan ketika diperlukan.(West, M., & Dawson, J. 2012)

Dengan langkah-langkah ini, perawat tidak hanya membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam cara masyarakat memandang kesehatan mental

Mendorong pemahaman dan penerimaan kesehatan mental di masyarakat, adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang mengalami gangguan mental. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diterapkan:

1. Edukasi dan Literasi Kesehatan Mental

Edukasi tentang kesehatan mental sangat penting untuk mengurangi ketidaktahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Program pendidikan di sekolah, seminar, dan kampanye publik dapat membantu masyarakat memahami gejala gangguan mental, pentingnya kesehatan mental, dan cara mencari bantuan.(WHO,2018)

2. Penghapusan Stigma

Stigma negatif yang melekat pada individu dengan gangguan mental sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Kampanye yang bertujuan untuk menghapus stigma ini sangat penting. Melalui penyuluhan dan informasi

yang tepat, masyarakat dapat belajar bahwa gangguan mental adalah masalah kesehatan yang dapat diobati.

3. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Mental

Penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan mental tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini termasuk menyediakan lebih banyak tenaga kesehatan mental di fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis dalam menangani masalah kesehatan mental.

4. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga

Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam menyediakan sumber daya dan dukungan untuk program kesehatan mental. Ini bisa berupa pendanaan untuk penelitian, pelatihan, dan kampanye kesadaran yang lebih luas.

5. Membangun Komunitas yang Mendukung

Masyarakat yang mendukung dan memahami kesehatan mental dapat membantu individu yang mengalami gangguan mental merasa lebih diterima. Membangun komunitas yang inklusif dapat mengurangi isolasi sosial yang sering dialami oleh penderita gangguan mental. (Kreddler, 2005)

6. Program Dukungan Teman Sebaya

Mengembangkan program dukungan teman sebaya di sekolah dan komunitas dapat membantu individu merasa lebih nyaman dalam berbagi pengalaman dan mencari bantuan. Ini juga dapat meningkatkan pemahaman di kalangan remaja dan orang dewasa muda tentang kesehatan mental.

Mendorong pemahaman dan penerimaan kesehatan mental di masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, penghapusan stigma, peningkatan akses layanan, dan dukungan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima isu kesehatan mental, sehingga individu yang membutuhkan bantuan dapat mencarinya tanpa rasa takut atau malu.

B. Bentuk-Bentuk Stigma Kesehatan Mental

1. Stereotip Negatif, individu dengan gangguan mental sering kali dikategorikan dalam stereotip negatif. Mereka dianggap lemah, berbahaya, atau tidak kompeten. Istilah-istilah seperti "gila", "stres", atau "aneh" sering kali digunakan untuk mendiskreditkan atau merendahkan mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.
2. Diskriminasi, stigma dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Individu yang mengalami gangguan mental mungkin menghadapi

penolakan pekerjaan, kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, atau pengucilan sosial.

3. Stigma Internal, ini adalah bentuk stigma yang terjadi ketika individu dengan gangguan mental mulai mempercayai stereotip negatif tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan perasaan malu, rendah diri, dan ketidakberdayaan, yang pada gilirannya dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan dan dukungan yang diperlukan.

Penyebab utama stigma adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental. Banyak orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang gangguan mental, sehingga mereka cenderung menilai individu yang menderita dengan cara yang negatif. Media sering kali menggambarkan individu dengan gangguan mental dengan cara yang sensasional atau negatif, yang dapat memperkuat stereotip dan prasangka di masyarakat

Banyak individu yang mengalami gangguan mental merasa enggan untuk mencari bantuan profesional karena takut akan penilaian negatif dari orang lain. Mereka khawatir bahwa mengakui kondisi mereka akan dianggap sebagai kelemahan. Stigma dapat menyebabkan individu menarik diri dari pergaulan sosial karena merasa tidak diterima. Ini dapat memperburuk kondisi mental mereka dan menciptakan siklus negatif yang sulit untuk dipecahkan. Stigma tidak hanya mempengaruhi cara orang lain melihat individu dengan gangguan mental, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu itu sendiri. Stigma internal dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan perasaan tidak berharga.

Mengatasi Stigma Kesehatan Mental adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental melalui kampanye edukasi dan program kesadaran dapat membantu mengurangi stigma. Edukasi yang baik dapat mengubah pandangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Mendorong individu yang mengalami gangguan mental untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendukung satu sama lain dapat membantu mengurangi stigma. Advokasi yang kuat dapat mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan dukungan yang lebih baik bagi individu dengan masalah kesehatan mental. Dengan memahami stigma terkait kesehatan mental dan dampaknya, diharapkan masyarakat dapat lebih inklusif dan peduli terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental.

Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kemampuan bekerja hingga hubungan sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Di Indonesia, isu kesehatan mental semakin mendapatkan perhatian karena dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Artikel ini akan membahas data terbaru mengenai

kesehatan mental di Indonesia pada tahun 2023, menggali tren, tantangan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental di negara ini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga penelitian lainnya, berikut adalah beberapa statistik utama mengenai kesehatan mental di Indonesia pada tahun 2023:

Prevalensi Gangguan Mental: Laporan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia mencapai sekitar 20%. Gangguan mental emosional mencakup kondisi seperti kecemasan, depresi, dan stres berat. **Gangguan Depresi:** Sekitar 6,1% dari populasi Indonesia dilaporkan mengalami gangguan depresi, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan beban yang cukup signifikan bagi individu dan sistem kesehatan. **Kecemasan dan Stres:** Gangguan kecemasan mempengaruhi sekitar 10% dari populasi dewasa, sementara sekitar 15% melaporkan mengalami stres berat. Tingginya angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih baik dalam manajemen stres dan kecemasan.

Akses ke Layanan Kesehatan Mental: Meskipun ada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan mental di Indonesia, laporan menunjukkan bahwa sekitar 70% dari mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan mental belum mendapatkan layanan yang memadai. Akses yang terbatas dan ketidakmerataan distribusi layanan menjadi masalah utama. (Thornicroft, G, 2006)

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kesehatan mental di Indonesia. Beberapa faktor penyebab utama dan dampaknya meliputi: **Faktor Sosial dan Ekonomi:** Ketidakpastian ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat menambah tekanan psikologis dan memperburuk kondisi kesehatan mental. Krisis ekonomi, seperti dampak pandemi COVID-19, telah memperburuk situasi ini. **Stigma terhadap gangguan mental** masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak orang enggan mencari bantuan karena takut dihakimi atau tidak diterima oleh masyarakat. Terutama di daerah pedesaan dan terpencil, akses ke layanan kesehatan mental sering kali sangat terbatas. Keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional menjadi tantangan besar dalam memberikan perawatan yang memadai.

Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan keluarga dapat menyebabkan stres dan gangguan mental. Beban tanggung jawab yang tinggi dalam konteks keluarga dan pekerjaan sering kali menjadi faktor pemicu gangguan mental.

C. Konsep Stigma dalam Kesehatan Mental

1. Definisi Stigma

Stigma adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok dianggap negatif atau tidak berharga berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Stigma dapat menyebabkan diskriminasi, pengucilan, dan dampak psikologis yang signifikan bagi individu yang terkena. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis stigma:

a. Stigma Sosial:

Stigma sosial merujuk pada penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu. Contoh umum dari stigma sosial termasuk stigma terhadap orang dengan penyakit mental, penyalahgunaan zat, atau kondisi kesehatan tertentu. Stigma ini dapat menyebabkan individu merasa terasing, diabaikan, dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial.

b. Stigma Internal:

Stigma internal terjadi ketika individu yang mengalami stigma mulai menerima dan menginternalisasi pandangan negatif yang ada di masyarakat tentang diri mereka. Mereka mungkin merasa malu, merasa tidak layak, atau bahkan menghindari situasi sosial karena takut akan penilaian orang lain. Stigma internal dapat mengakibatkan rendahnya harga diri dan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan.

c. Stigma Institusional:

Stigma institusional merujuk pada kebijakan, praktik, atau struktur dalam institusi (seperti sekolah, tempat kerja, atau sistem kesehatan) yang memperkuat stigma terhadap individu atau kelompok tertentu. Misalnya, jika suatu institusi memiliki kebijakan yang mendiskriminasi orang dengan riwayat kesehatan mental, maka hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dan memperkuat stigma. Stigma institusional dapat menghalangi akses individu ke layanan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Ketiga jenis stigma ini saling terkait dan dapat memperburuk pengalaman individu yang mengalami stigma. Memahami stigma dan dampaknya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung. Upaya untuk mengurangi stigma meliputi pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kebijakan yang lebih adil dan mendukung.

2. Dampak Stigma terhadap Individu dengan Masalah Kesehatan Mental

Pengaruh stigma terhadap akses layanan kesehatan mental. Stigma terhadap kesehatan mental adalah pandangan negatif dan prasangka yang ditujukan kepada individu dengan gangguan mental. Stigma ini dapat

mempengaruhi akses layanan kesehatan mental secara signifikan. Berikut adalah beberapa pengaruh stigma:

a. Penolakan untuk Mencari Bantuan

Stigma sering menyebabkan individu merasa malu atau takut untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan. Banyak orang yang mengalami gejala gangguan mental yang parah enggan mencari layanan kesehatan karena takut dihakimi atau dicap sebagai "gila". Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan perawatan yang diperlukan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

b. Persepsi Negatif dari Masyarakat

Stigma sosial menciptakan persepsi negatif terhadap individu dengan gangguan mental. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja dan dalam hubungan sosial. Individu yang merasa diisolasi dan tidak diterima oleh masyarakat cenderung lebih enggan untuk mencari bantuan, karena mereka khawatir akan reaksi negatif dari orang lain.

c. Dampak pada Kualitas Perawatan

Stigma tidak hanya mempengaruhi individu yang mencari perawatan, tetapi juga berdampak pada profesional kesehatan. Stigma di kalangan tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kurangnya empati dan dukungan terhadap pasien. Hal ini dapat memperburuk pengalaman pasien dalam menerima perawatan, serta mengurangi efektivitas layanan kesehatan mental.

d. Keterbatasan Akses di Daerah Terpencil

Di banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, akses terhadap layanan kesehatan mental sangat terbatas. Stigma yang ada di masyarakat dapat memperburuk situasi ini, karena individu mungkin merasa tidak nyaman untuk mencari layanan yang sudah terbatas. Ketidaknyamanan ini dapat membuat mereka enggan untuk mencari bantuan, meskipun mereka membutuhkan perawatan.

e. Internalisasi Stigma

Banyak individu dengan gangguan mental mengalami internalisasi stigma, di mana mereka menginternalisasi pandangan negatif tentang diri mereka sendiri. Ini dapat mengurangi kepercayaan diri dan meningkatkan rasa putus asa, yang membuat mereka semakin enggan untuk mencari bantuan. Internalisasi stigma ini dapat menciptakan siklus negatif yang sulit dipecahkan.

Secara keseluruhan, stigma terhadap kesehatan mental menciptakan berbagai hambatan yang menghalangi individu untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Mengatasi stigma ini melalui pendidikan, peningkatan

kesadaran, dan dukungan sosial sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental. (Corrigan, P. W, 2002)

D. Peran Perawat dalam Mengurangi Stigma

1. Edukasi dan Kesadaran

Pendidikan tentang kesehatan mental bagi perawat sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan yang mereka berikan kepada pasien. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan ini krusial,

a. Meningkatkan Kemampuan Deteksi Dini

Pendidikan kesehatan mental membantu perawat dalam mendeteksi tanda-tanda awal gangguan mental pada pasien. Dengan pemahaman yang baik tentang gejala dan perilaku yang menunjukkan masalah kesehatan mental, perawat dapat melakukan intervensi lebih awal, yang dapat meningkatkan hasil perawatan pasien.(WHO, 2013).

b. Mengurangi Stigma dan Meningkatkan Kesadaran

Perawat yang teredukasi tentang kesehatan mental dapat berperan dalam mengurangi stigma yang sering kali melekat pada gangguan mental. Mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada pasien dan masyarakat, serta mendukung pasien dalam menghadapi stigma tersebut. Hal ini penting karena stigma dapat menghambat pemulihan dan akses pasien terhadap perawatan yang diperlukan.

c. Meningkatkan Kualitas Perawatan

Pendidikan kesehatan mental memungkinkan perawat untuk merancang dan menerapkan rencana perawatan yang lebih efektif. Mereka dapat menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk menangani masalah kesehatan mental, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien.(McNair, R,2016)

d. Memfasilitasi Kerjasama Tim Kesehatan

Perawat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan mental dapat berkolaborasi lebih baik dengan profesional kesehatan lainnya, seperti psikiater dan psikolog. Kerjasama ini penting untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi bagi pasien yang mengalami gangguan mental.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Perawat Sendiri

Pendidikan tentang kesehatan mental juga penting bagi kesejahteraan perawat itu sendiri. Dengan memahami tantangan kesehatan mental yang mereka hadapi, perawat dapat lebih baik dalam mengelola stres dan mencegah burnout, yang merupakan masalah umum dalam profesi keperawatan.

Secara keseluruhan, pendidikan tentang kesehatan mental bagi perawat tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan perawatan yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan stigma, peningkatan kerjasama tim, dan kesejahteraan perawat itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pendidikan dan rumah sakit perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan kurikulum yang mencakup aspek kesehatan mental dalam pelatihan perawat.(American Nurses Association.,2015)

Dengan pendidikan yang memadai, perawat dapat berfungsi sebagai penghubung penting dalam sistem perawatan kesehatan mental, membantu pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan mental.

Program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman perawat tentang stigma dan kesehatan mental sangat penting untuk menciptakan lingkungan perawatan yang lebih inklusif dan mendukung bagi pasien dengan masalah kesehatan mental. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dimasukkan dalam program pelatihan tersebut:

a. Pendidikan tentang Stigma

Menjelaskan apa itu stigma, bagaimana stigma terbentuk, dan dampaknya terhadap individu dengan masalah kesehatan mental,serta stigma yang dialami oleh pasien (stigma publik) dan stigma internal yang dapat dialami oleh individu itu sendiri.

b. Dampak Stigma pada Kesehatan Mental

Menguraikan bagaimana stigma dapat mempengaruhi akses pasien ke perawatan, kepatuhan terhadap pengobatan, dan hasil kesehatan secara keseluruhan dengan menyajikan studi kasus yang menggambarkan dampak stigma dalam praktik klinis.

c. Peningkatan Keterampilan Komunikasi

Melatih perawat untuk berkomunikasi dengan empati dan tanpa menghakimi kepada pasien dengan masalah kesehatan mental.dan mengajarkan teknik untuk mendengarkan dan memahami pengalaman pasien secara lebih mendalam.

d. Intervensi dan Pendekatan Praktis

Memperkenalkan intervensi yang dapat digunakan perawat untuk membantu mengurangi stigma di lingkungan kerja dan dalam interaksi dengan pasien, mendorong kolaborasi antar profesional kesehatan untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik terhadap perawatan kesehatan mental.

e. Sumber Daya dan Dukungan

Memberikan akses ke sumber daya, literatur, dan organisasi yang fokus pada kesehatan mental dan pengurangan stigma dan membangun jaringan

dukungan bagi perawat untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menangani stigma.

Melalui program pelatihan ini, diharapkan perawat dapat lebih memahami dan mengatasi stigma terkait kesehatan mental, sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih manusiawi kepada pasien.

2. Interaksi dengan Pasien

Cara perawat dapat berinteraksi dengan pasien untuk mengurangi stigma.

Mengurangi stigma terhadap pasien, terutama dalam konteks kesehatan mental atau kondisi tertentu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan pengalaman pasien. Berikut adalah beberapa cara perawat dapat berinteraksi dengan pasien untuk mengurangi stigma antara lain:

- a. Pendekatan Empatik; perawat harus menunjukkan empati dan kepedulian terhadap pasien. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perasaan pasien, perawat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman.
- b. Edukasi Pasien; memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan pasien dapat membantu mengurangi ketakutan dan kesalahpahaman. Edukasi tentang penyakit, pengobatan, dan proses pemulihan dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi stigma.
- c. Membangun Hubungan yang Kuat; membangun kepercayaan antara perawat dan pasien sangat penting. Perawat harus berusaha untuk menjalin hubungan yang positif dan terbuka, sehingga pasien merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka.
- d. Menggunakan Bahasa yang Sensitif; perawat harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan istilah yang tidak menyinggung. Menghindari istilah yang dapat memperkuat stigma dan menggunakan bahasa yang inklusif dapat membantu pasien merasa dihargai.
- e. Mendorong Keterlibatan Pasien; mengajak pasien untuk terlibat dalam keputusan perawatan mereka dapat meningkatkan rasa kontrol dan harga diri mereka. Ini juga membantu pasien merasa lebih dihargai dan diakui.
- f. 6.Menjadi Role Model; perawat dapat berperan sebagai contoh positif dalam mengatasi stigma. Dengan menunjukkan sikap terbuka dan positif terhadap berbagai kondisi kesehatan, perawat dapat mempengaruhi pandangan pasien dan masyarakat secara keseluruhan.
- g. Mendukung Keluarga Pasien; melibatkan keluarga dalam proses perawatan juga penting. Edukasi dan dukungan kepada keluarga dapat membantu mereka memahami kondisi pasien dan mengurangi stigma yang mungkin mereka miliki (Rüsch, N.2005)

Untuk mewujudkan bentuk prakrek dalam komunikasi dan dukungan emosional dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Mendengarkan Aktif

Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang efektif. Ini melibatkan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan minat melalui bahasa tubuh, dan memberikan umpan balik yang relevan. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dengan lebih baik, yang merupakan dasar dari dukungan emosional yang efektif.

b. Menyampaikan Empati

Menunjukkan empati kepada orang lain dapat memperkuat hubungan dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Ini bisa dilakukan dengan mengakui perasaan mereka dan menyatakan bahwa kita memahami situasi yang mereka hadapi. Misalnya, mengatakan, "Saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini bagi Anda," dapat memberikan rasa nyaman bagi orang yang sedang mengalami kesulitan.

c. Komunikasi Nonverbal yang Positif

Komunikasi nonverbal, seperti kontak mata, senyuman, dan bahasa tubuh yang terbuka, sangat penting dalam menyampaikan dukungan emosional. Ini membantu menciptakan suasana yang aman dan mendukung, di mana orang merasa dihargai dan didengar. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang yang sedang stres, menjaga kontak mata dan mengangguk dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan peduli.

d. Memberikan Umpan Balik yang Konstruktif

Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah cara lain untuk mendukung orang lain. Ini melibatkan memberikan saran atau kritik yang membangun dengan cara yang positif dan mendukung. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Anda melakukan kesalahan," kita bisa mengatakan, "Saya melihat ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, mari kita diskusikan bersama." (Miller, W. R., 2012).

e. Menciptakan Ruang untuk Berbicara

Menciptakan ruang di mana orang merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka adalah praktik baik dalam dukungan emosional. Ini bisa dilakukan dengan mengatur waktu khusus untuk berbicara atau menciptakan lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan. Misalnya, mengajak teman untuk berbicara sambil berjalan-jalan di taman dapat membuat mereka merasa lebih santai dan terbuka.

Dengan menerapkan praktik-praktik ini, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan dukungan emosional dalam hubungan kita dengan orang lain.

3. Advokasi dan Perubahan Kebijakan

Peran perawat dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesehatan mental. memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesehatan mental. Berikut adalah beberapa aspek rinci mengenai peran tersebut:

a. Pendidikan dan Kesadaran

Perawat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental di masyarakat. Mereka dapat memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan komunitas tentang tanda-tanda gangguan mental, pentingnya perawatan kesehatan mental, serta cara untuk mengakses layanan yang diperlukan.

b. Advokasi Kebijakan

Perawat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan mental dengan memberikan masukan berdasarkan pengalaman klinis mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan organisasi profesional untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas.

c. 3. Mewakili Suara Pasien

Perawat sering kali menjadi penghubung antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Mereka dapat membantu menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran pasien dalam konteks kebijakan kesehatan mental, memastikan bahwa suara pasien didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang dibuat.

d. Kolaborasi Interdisipliner

Perawat bekerja sama dengan berbagai profesional kesehatan lainnya, termasuk psikolog, psikiater, dan pekerja sosial. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat membantu membentuk pendekatan holistik terhadap perawatan kesehatan mental dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencakup berbagai aspek perawatan.

e. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Perawat dapat terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mental dan hasil perawatan. Data dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung advokasi kebijakan yang lebih baik dan berbasis bukti.

f. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Perawat dapat berperan dalam melatih rekan-rekan mereka dan anggota komunitas tentang isu-isu kesehatan mental, termasuk bagaimana mendukung individu yang mengalami gangguan mental. Ini membantu

membangun kapasitas dalam sistem kesehatan untuk menangani masalah kesehatan mental secara lebih efektif.

g. Partisipasi dalam Jaringan dan Organisasi

Perawat dapat bergabung dengan organisasi profesi yang fokus pada kesehatan mental, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam advokasi dan pengembangan kebijakan di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

Dengan memahami dan menjalankan peran ini, perawat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu yang menghadapi tantangan kesehatan mental dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di bidang ini.

Keterlibatan dalam kampanye kesadaran masyarakat merupakan aspek penting untuk meningkatkan pemahaman dan respons masyarakat terhadap berbagai isu, terutama isu sosial dan bencana yang meliputi:

a. Meningkatkan Pengetahuan

Keterlibatan masyarakat dalam kampanye kesadaran membantu mereka memperoleh informasi yang lebih baik tentang cara mencegah dan menghadapi bencana. Misalnya, kampanye di media sosial dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah evakuasi dan mitigasi yang perlu diambil saat terjadi bencana. Dengan adanya informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih siap menghadapi situasi darurat].

b. Mendorong Partisipasi

Keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye sosial mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih luas, seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana atau program edukasi kesehatan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap isu-isu yang dihadapi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap tindakan yang diperlukan.

c. Membangun Komunitas yang Peduli

Kampanye yang melibatkan masyarakat dapat membantu membangun komunitas yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan satu sama lain. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih peduli terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka.

E. Strategi Promosi Kesehatan Mental di Komunitas

Promosi kesehatan mental di komunitas adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan dukungan terhadap kesehatan mental

di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan untuk mempromosikan kesehatan mental di komunitas:

1. Penilaian Kebutuhan

Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan mental di komunitas adalah langkah awal yang penting. Ini melibatkan pengumpulan data mengenai kondisi kesehatan mental masyarakat, serta identifikasi masalah spesifik yang dihadapi oleh individu dalam komunitas tersebut. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. (WHO, 2013).

2. Peningkatan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental melalui kampanye media, program pendidikan, dan lokakarya sangat penting. Edukasi masyarakat mengenai isu-isu kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Kegiatan ini dapat melibatkan penyuluhan di sekolah, tempat kerja, dan acara komunitas. (NAMI, 2020).

3. Penguatan Kapasitas

Memberikan pelatihan kepada profesional kesehatan, pendidik, dan pemimpin masyarakat untuk mengidentifikasi dan merespons masalah kesehatan mental sangat penting. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat lebih siap dalam memberikan dukungan kepada anggota komunitas yang membutuhkan.

4. Akses Layanan Kesehatan Mental

Menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental, termasuk terapi, konseling, dan dukungan kelompok, sangat penting. Hal ini memastikan bahwa individu yang mengalami masalah kesehatan mental dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa hambatan.

5. Dukungan Sosial

Mendorong terciptanya jaringan dukungan yang kuat dalam komunitas, seperti kelompok swadaya dan program pendampingan sebaya, dapat membantu individu merasa lebih terhubung dan didukung. Dukungan sosial berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi perasaan kesepian.

6. Pendekatan Afiliasi

Pendekatan afiliasi melibatkan kolaborasi dengan organisasi dan individu yang memiliki tujuan serupa. Dengan berbagi sumber daya dan membangun kemitraan, upaya promosi kesehatan mental dapat diperkuat dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat.

7. Program Intervensi Spesifik

Mengembangkan program intervensi yang ditargetkan untuk kelompok rentan, seperti remaja, dapat membantu mengatasi masalah kesehatan mental yang spesifik. Misalnya, program yang fokus pada pengurangan stres dan peningkatan keterampilan koping dapat sangat bermanfaat bagi remaja yang menghadapi tekanan hidup.

Program-program yang dirancang khusus untuk remaja menunjukkan hasil positif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi (Becker & Stein, 2016).

8. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya. Ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di komunitas. (Patton, 2008).

F. Tantangan dan Solusi

1. Tantangan dalam Mengurangi Stigma

Identifikasi tantangan yang dihadapi perawat dalam mengurangi stigma di komunitas. Perawat memainkan peran penting dalam mengurangi stigma terkait kesehatan mental dan kondisi medis lainnya di komunitas. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi perawat:

a. Stigma Terhadap Profesi Perawat Sendiri

Perawat sering kali menghadapi pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap mereka kurang profesional atau tidak ramah. Stigma ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perawat, sehingga menghambat komunikasi dan interaksi yang efektif antara perawat dan pasien.

b. Beban Kerja yang Tinggi

Perawat seringkali memiliki beban kerja yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Kelelahan ini mempengaruhi kualitas perawatan yang mereka berikan dan mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan pasien secara empatik. Hal ini juga dapat memperburuk stigma terhadap profesi mereka.

c. 3. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran tentang Kesehatan Mental:

Banyak perawat mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani isu kesehatan mental. Kurangnya pendidikan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengedukasi pasien dan masyarakat tentang pentingnya mengatasi stigma dan memahami kesehatan mental.

d. Lingkungan Kerja yang Tidak Mendukung:

Lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat memperburuk stigma yang dialami oleh perawat. Jika perawat merasa tidak dapat mencari bantuan untuk masalah kesehatan mental mereka sendiri tanpa menghadapi konsekuensi sosial atau profesional, mereka mungkin enggan untuk mendukung pasien yang mengalami stigma serupa.

e. Persepsi Masyarakat yang Kaku:

Persepsi masyarakat yang kaku terhadap orang dengan gangguan mental atau kondisi kesehatan lainnya sering kali menjadi penghalang. Masyarakat yang kurang memahami kesehatan mental cenderung mempertahankan stigma, sehingga menyulitkan perawat dalam mengedukasi dan mengubah pandangan tersebut.

f. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu maupun dukungan finansial, menjadi tantangan signifikan. Perawat sering kali tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk melakukan kampanye pendidikan atau intervensi yang diperlukan untuk mengurangi stigma di komunitas mereka.

Mengurangi stigma di komunitas adalah tugas yang kompleks dan menantang bagi perawat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara perawat, organisasi kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental serta pentingnya dukungan sosial.

2. Solusi dan Rekomendasi

Rekomendasi untuk perawat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan stigma. Berikut adalah rekomendasi untuk perawat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan stigma, terutama dalam konteks kesehatan mental

a. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Program Edukasi, kembangkan program edukasi yang menyasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental dan penyakit menular. Informasikan tentang penyebab, gejala, dan cara penanganan yang tepat. Laksanakan kampanye kesadaran untuk menyoroti pentingnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami stigma. Gunakan media sosial, seminar, dan workshop untuk menjangkau lebih banyak orang.

b. Pendampingan dan Dukungan

Perawat harus aktif memberikan pendampingan kepada pasien, termasuk konseling dan dukungan emosional. Libatkan keluarga pasien untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

c. 3. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Bangun kemitraan antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk menciptakan program-program yang efektif dalam mengurangi stigma. Kerja sama ini penting untuk menyatukan sumber daya dan pengetahuan. Dan sediakan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara mengatasi stigma dan diskriminasi dalam praktik mereka, termasuk pelatihan tentang empati dan komunikasi yang efektif.

d. Menciptakan Lingkungan yang Inklusif

Kembangkan dan terapkan kebijakan di fasilitas kesehatan yang menolak stigma dan diskriminasi. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk melaporkan dan menangani kasus stigma. Dan Ajak pasien untuk terlibat dalam proses perawatan mereka dan dalam pengembangan program-program yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Ini dapat membantu mengurangi rasa malu dan meningkatkan rasa memiliki.

e. 5. Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan

Pastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang terstigma, memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan. Kurangi hambatan finansial dan tingkatkan ketersediaan layanan di daerah terpencil.

f. Penelitian dan Pengembangan

Lakukan penelitian untuk memahami lebih baik tentang stigma yang dialami oleh pasien dan dampaknya terhadap kesehatan mereka. Gunakan data ini untuk mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif. Selanjutnya secara berkala evaluasi program-program yang telah diimplementasikan untuk mengatasi stigma dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, perawat dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu, terutama mereka yang menghadapi tantangan kesehatan mental dan penyakit menular.

G. Kesimpulan

1. Ringkasan Peran Perawat

Perawat kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada pasien yang mengalami gangguan mental. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai aspek-aspek utama dari peran mereka:

a. Asuhan Keperawatan Langsung

Perawat kesehatan mental bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Ini termasuk. Perawat mengikuti rencana perawatan yang telah disusun berdasarkan diagnosis medis, memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang sesuai. Mereka memberikan terapi sesuai dengan petunjuk dokter, termasuk psikoterapi individu, kelompok, dan keluarga, untuk membantu pasien mengatasi masalah mental mereka.

b. Pengelolaan Kasus

Perawat juga berperan dalam pengelolaan kasus, yang mencakup: Mengorganisasi dan Mengkoordinasikan bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien terpenuhi. Melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi pasien dan bernegosiasi dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk mencapai hasil perawatan yang optimal

c. Edukasi dan Dukungan Keluarga

Perawat kesehatan mental tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Mereka: melayani konsultasi untuk keluarga pasien, membantu mereka memahami kondisi pasien dan cara mendukung mereka selama proses pemulihan. mengedukasi keluarga tentang kesehatan mental dan cara-cara untuk mengurangi stigma yang terkait dengan gangguan mental, sehingga menciptakan lingkungan yang suportif bagi pasien.

d. Deteksi Dini dan Intervensi

Perawat memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini gejala gangguan mental. Mereka: Menggunakan pendekatan terapeutik untuk membantu pasien mengembangkan strategi koping yang efektif dalam menghadapi masalah mental. Memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada pasien, membantu mereka dalam mengatasi stres dan tantangan yang dihadapi.

e. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

Perawat kesehatan mental bekerja sama dengan berbagai profesional kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Mereka berperan sebagai: Memberikan perawatan langsung kepada pasien, memastikan kebutuhan fisik dan emosional mereka terpenuhi. Memperjuangkan hak dan kebutuhan pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan adil. Memberikan informasi dan pendidikan tentang kesehatan mental kepada pasien dan keluarga, membantu mereka memahami pentingnya perawatan dan dukungan.

f. **Penanganan Masalah Kesehatan Mental Umum**

Perawat juga terlibat dalam menangani berbagai masalah kesehatan mental yang umum, seperti: Memantau dan menangani perilaku berisiko yang dapat membahayakan pasien atau orang lain. Membantu pasien yang mengalami isolasi sosial dan kesulitan berkomunikasi, dengan tujuan meningkatkan interaksi sosial dan dukungan.

Dengan peran yang beragam ini, perawat kesehatan mental berkontribusi secara signifikan terhadap pemulihan dan kesejahteraan pasien yang mengalami gangguan mental. Mereka tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga dukungan emosional, edukasi, dan advokasi untuk memastikan bahwa pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat.

2. Harapan untuk Masa Depan

Harapan untuk peningkatan kesadaran dan penerimaan kesehatan mental di masyarakat melalui upaya perawat. Menegaskan kembali pentingnya peran perawat dalam mengurangi stigma dan mempromosikan kesehatan mental dapat dilakukan melalui beberapa poin kunci:

a. **Edukasi Masyarakat**

Perawat berperan sebagai pendidik yang penting dalam masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang kesehatan mental, membantu masyarakat memahami bahwa gangguan mental adalah kondisi medis yang dapat diobati. Dengan mengedukasi masyarakat, perawat dapat mengurangi mitos dan stereotip negatif yang sering kali mengelilingi individu dengan gangguan mental.

b. **Intervensi Dini**

Perawat dilatih untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan mental. Dengan pendekatan yang empatik dan responsif, mereka dapat memberikan intervensi yang tepat waktu, membantu individu merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka dan mengurangi rasa takut terhadap stigma.

c. **Dukungan Keluarga**

Perawat tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Dengan mendidik keluarga tentang cara mendukung anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, perawat dapat membantu menciptakan sistem dukungan yang kuat, yang pada gilirannya dapat mengurangi stigma dan meningkatkan proses pemulihan.

d. **Promosi Pelayanan Holistik**

Perawat memberikan pelayanan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aspek kehidupan pasien

diperhatikan, yang sangat penting dalam pemulihan kesehatan mental. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perawat dapat membantu pasien mengembangkan mekanisme koping yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan.

e. Advokasi Kebijakan Kesehatan Mental

Perawat memiliki peran penting sebagai advokat dalam sistem kesehatan. Mereka dapat terlibat dalam pengembangan kebijakan yang mendukung kesehatan mental, mendorong peningkatan akses ke layanan kesehatan mental, dan berperan dalam upaya mengurangi stigma di masyarakat.

f. Program Peningkatan Kesadaran

Perawat dapat menginisiasi dan berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Kampanye edukasi yang diadakan oleh perawat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya dukungan terhadap individu dengan gangguan mental, serta cara-cara untuk membantu mereka.

Peran perawat dalam mengurangi stigma dan mempromosikan kesehatan mental sangatlah krusial. Melalui edukasi, dukungan, advokasi, dan pendekatan holistik, perawat tidak hanya berkontribusi pada pemulihan individu tetapi juga membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung. Dengan mengakui dan memperkuat peran ini, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua individu yang menghadapi tantangan kesehatan mental.

H. Referensi

- American Nurses Association. (2015). "Psychiatric-Mental Health Nursing: Scope and Standards of Practice."
- Berk, L. E. (2010). *Development Through the Lifespan*. Pearson. Berk menjelaskan bagaimana dukungan emosional dan komunikasi yang baik dapat mempengaruhi perkembangan hubungan interpersonal.
- Brown, B. (2010). *The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You Are*. Hazelden Publishing.
- Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Understanding the stigma of mental illness. *World Psychiatry*, 1(1), 16-20.
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.

- McDaid, D., & Park, A. L. (2018). The role of health professionals in reducing stigma and discrimination against people with mental health problems. *The Lancet Psychiatry*, 5(9), 763-764.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2012). *Motivational Interviewing: Helping People Change*. Guilford Press.
- Patel, V., et al. (2018). Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: key messages from disease control priorities. *The Lancet*. [Link]([https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)31929-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31929-2/fulltext))
- Rogers, C. R. (1980). *A Way of Being*. Houghton Mifflin. Buku ini membahas pentingnya mendengarkan aktif dan empati dalam hubungan interpersonal.
- Thornicroft, G. (2006). Actions to reduce stigma and discrimination: The evidence. *The British Journal of Psychiatry*, 188(1), 8-10.
- Yulianto Simajuntak, (2012) *Membangun kesehatan mental Keluarga dan Madepan Anak*, ramedia, Jakarta
- World Health Organization. (2022). *World Mental Health Report: Transforming mental health for all*. Geneva: WHO.
- WHO (World Health Organization). (2018). Mental health: strengthening our response. [Link](<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>)

CHAPTER 6

MENINGKATKAN AKSES KESEHATAN MELALUI LAYANAN KESEHATAN MOBILE DI KOMUNITAS

Arriani Indrastuti, S.KM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Dengan demikian diharapkan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Sehingga, kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu ataupun keluarganya untuk hidup sehat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Fasilitas kesehatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Menurut *Sustainable Development Goals (SDGs)*, pada tujuan nomor 3 menyebutkan bahwa untuk memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia, dimana salah satu targetnya mencapai *universal health coverage*, dan Indonesia menyatakan komitmen yang kuat dalam Agenda Pembangunan Global 2030.

Namun, masih terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat yang belum terjangkau masyarakat yang tinggal dipelosok desa/desa terpencil dan penduduk yang memiliki keluhan dan terganggu aktivitasnya sehingga tidak mampu berobat disebut *unmet health service needs*. Oleh karena itu pemetaan spasial *unmet need* pelayanan kesehatan penting dilakukan untuk mengenali wilayah yang memerlukan prioritas intervensi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

akses dan kualitas layanan kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, antara lain: fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, jarak, faktor pendidikan, dan status sosial ekonomi masyarakat.

B. Metode untuk mengukur keterjangkauan pelayanan kesehatan :

1. Aksesibilitas fasilitas Kesehatan

Aksesibilitas fasilitas Kesehatan adalah pengukuran tingkat penyesuaian antara karakteristik sumber daya kesehatan dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah kemampuan setiap orang untuk mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan meliputi dimensi fisik, biaya, dan akses secara sosial.

Metode analisis yang digunakan ; *Network Analysis dan Spatial Accessibility Analysis*

2. Pola distribusi fasilitas kesehatan

Pola distribusi fasilitas kesehatan adalah pola dalam menentukan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Metode analisis yang digunakan *Nearest Neighbour Analysis, Moran's I, atau Ripley's K Function*. (Shildam Niwa, A. S., 2024)

3. Analisis spesial *Geographic Information System (GIS) buffering*

Merupakan metode untuk membuat area berjarak tertentu (*buffer zone*) disekitar disuatu fitur geografis, seperti titik, garis, atau poligon.

Manfaat analisis spasial GIS dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan:

- a. Mengukur aksesibilitas; menentukan siapa saja yang tinggal dalam jarak tertentu dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
- b. Menentukan zona pelayanan; membagi wilayah layanan berdasarkan jarak untuk menghindari tumpang tindih layanan antara beberapa fasilitas.
- c. Perencanaan lokasi baru; membantu menemukan lokasi strategis untuk fasilitas kesehatan baru berdasarkan jangkauan layanan yang ada.
- d. Analisis risiko dan kesehatan lingkungan; menentukan area risiko berdasarkan kedekatan fasilitas kesehatan terhadap sumber pencemaran atau zona rawan penyakit. (AH Fhitri, 2022). Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi aksesibilitas pelayanan kesehatan, antara lain:
 - 1) Waktu tempuh
 - 2) Biaya transportasi
 - 3) Lokasi tempat tinggal
 - 4) Persepsi masyarakat tentang kesehatan
 - 5) Kualitas pelayanan
 - 6) Pendidikan

7) Pendapatan

Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk membangun dan memelihara puskesmas dan klinik desa. Fasilitas kesehatan yang dekat dan memadai dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan aksesibilitas. Menurut BPS per Maret 2024 data Persentase Unmet Need Pelayanan Kesehatan berdasarkan daerah tempat tinggal adalah daerah perkotaan 4,72%, dan wilayah perkotaan 5,83%. (BPS, 2024). Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang layak bagi setiap masyarakatnya dengan tujuan untuk memberi pelayanan secara lebih merata dan berkualitas terutama dalam persebaran fasilitas kesehatan dan kemudahan untuk dijangkau dari aspek lokasinya. Akses layanan kesehatan mobile (mobile health services) merupakan salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan akses kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses kesehatan melalui layanan kesehatan mobile di komunitas. Adapun upaya peningkatkan akses layanan kesehatan di komunitas, terutama di daerah terpencil, dapat dicapai melalui penerapan layanan kesehatan mobile seperti klinik keliling dan telemedicine.

C. Penerapan Layanan Kesehatan Mobile

1. Klinik keliling (*mobile clinic*)

a. Pengertian

Klinik keliling (*mobile clinic*) adalah fasilitas pelayanan kesehatan bergerak yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat di lokasi tertentu. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di daerah terpencil, sulit dijangkau, atau daerah dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan tetap. Klinik keliling biasanya beroperasi dengan menggunakan kendaraan khusus seperti van, bus, atau truk yang dimodifikasi untuk membawa peralatan medis, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.

b. Tujuan dan manfaat klinik keliling

1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

Klinik keliling memiliki kemampuan untuk menjangkau komunitas yang tidak memiliki fasilitas kesehatan permanen atau memiliki keterbatasan akses, seperti di wilayah pedesaan atau daerah yang mengalami bencana.

2) Pelayanan preventif dan kuratif

Klinik ini menyediakan edukasi kesehatan, imunisasi, pemeriksaan kesehatan dasar, penanganan penyakit ringan, hingga layanan kesehatan ibu dan anak.

3) Respon darurat kesehatan

Klinik keliling memainkan peran penting dalam situasi darurat atau krisis, seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial.

4) Efisiensi dan fleksibilitas

Dari segi operasional, klinik keliling lebih fleksibel dalam menjangkau wilayah-wilayah yang berbeda dibandingkan jika harus membangun fasilitas tetap.

c. Layanan yang disediakan oleh klinik keliling

1) Pemeriksaan kesehatan umum.

2) Imunisasi.

3) Konsultasi kesehatan ibu dan anak.

4) Penyuluhan kesehatan masyarakat.

5) Distribusi obat-obatan dasar.

6) Skrining penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, atau HIV/AIDS.

d. Kelebihan dan tantangan klinik keliling

1) Kelebihan:

a) Mobilitas tinggi: dapat bergerak ke lokasi-lokasi prioritas.

b) Efisiensi biaya: lebih murah dibanding membangun fasilitas permanen.

c) Fokus komunitas: memberikan layanan sesuai kebutuhan lokal.

2) Tantangan:

a) Biaya operasional tinggi: termasuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan staf medis.

b) Keterbatasan kapasitas: ruang dan sumber daya di kendaraan terbatas.

c) Ketergantungan pada infrastruktur: seperti jalan yang layak dan keamanan wilayah.

e. Jenis layanan kesehatan yang diberikan secara mobile:

1) Puskesmas Keliling

Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Puskesmas Keliling dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan.

Tujuan utamanya adalah untuk memperluas akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil

dan terisolasi baik di darat maupun di pulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Fungsi Puskesmas Keliling adalah

- a) sarana transportasi petugas;
- b) sarana transportasi logistik;
- c) sarana pelayanan kesehatan; dan
- d) sarana pendukung promosi kesehatan.

Peran Puskesmas Keliling:

- a) Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
- b) Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit.
- c) Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll.
- d) Mendukung pelayanan rujukan.
- e) Mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Puskesmas Keliling:

- a) Aspek program: Puskesmas Keliling berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan relatif terbatas karena peralatan dan tenaga yang ada terbatas. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota serta Puskesmas harus dapat merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Puskesmas keliling. Hal ini akan berkaitan dengan peralatan dan obat-obat yang akan dibawa.
- b) Aspek tenaga kesehatan yang akan bertugas pada Puskesmas keliling diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dan serta memiliki kemampuan/kompetensi yang memadai.
- c) Aspek sarana digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan petugas. Jenis sarana Puskesmas keliling darat: kendaraan roda 2 kendaraan roda 4 biasa kendaraan roda 4 double gardan, dan jenis sarana puskesmas keliling perairan; perahu polyetylen perahu fiberglass perahu kayu dan ketinting.



Gambar 6.1 Aspek Kendaraan untuk Puskesmas Keliling

Sumber : Mitra Kesmas, Oktober 2017

- d) Aspek pembiayaan, perlu diperhatikan terkait biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan.
 - e) Aspek pendukung, ada subsistem yang harus dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Subsistem ini antara lain sistem rujukan, sistem komunikasi dengan Puskesmas, dan sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk operasional Puskesmas keliling, pendukung yang harus dipenuhi yaitu peralatan pelayanan kesehatan, obat dan bahan habis pakai, perlengkapan keselamatan tim dan perorangan, dan alat komunikasi. (Permenkes No.43 Tahun 2019)
- 2) Klinik Gigi Keliling
Mobil khusus dengan fasilitas untuk perawatan gigi, seperti kursi gigi, alat sterilisasi, dan perlengkapan pemeriksaan mulut. Layanan ini biasanya digunakan di sekolah atau komunitas yang jauh dari fasilitas kesehatan gigi.
 - 3) Layanan Mobile Kesehatan Mental
Tim kesehatan mental keliling yang memberikan konseling, terapi kelompok, dan pelatihan kesehatan mental kepada komunitas, terutama di daerah yang terkena dampak bencana atau konflik.
 - 4) Laboratorium Mobile
Kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan untuk tes laboratorium dasar seperti tes darah, urin, atau HIV. Layanan ini sering digunakan untuk mendukung program deteksi dini penyakit menular.
 - 5) Vaksinasi Mobile
Tim bergerak yang fokus memberikan vaksinasi di daerah terpencil atau dalam kampanye nasional untuk meningkatkan cakupan imunisasi.
 - 6) Perahu Kesehatan
Digunakan di wilayah pesisir dan sungai untuk menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan, pengobatan, dan imunisasi. Contoh: "Perahu Sehat" di Kalimantan dan Papua.

7) Mobil Apotek Keliling

Kendaraan yang menyediakan obat-obatan esensial di lokasi yang jauh dari apotek. Petugas kesehatan juga memberikan edukasi tentang penggunaan obat secara tepat.

8) Mobil Edukasi dan Promosi Kesehatan

Kendaraan yang dilengkapi dengan alat peraga untuk memberikan penyuluhan tentang kebersihan, gizi, atau kesehatan reproduksi. Sering disertai dengan pemutaran video edukasi.

9) Bank Darah Keliling

Unit bergerak yang dirancang untuk pengambilan darah di komunitas atau acara donor darah massal.

10) Klinik Rehabilitasi Mobile

Layanan untuk membantu pasien dengan kebutuhan fisioterapi, terapi okupasi, atau pemulihan pasca cedera langsung di lokasi.

11) Ambulans Cerdas

Kendaraan yang dilengkapi dengan telemedicine untuk memberikan diagnosis awal sebelum pasien mencapai fasilitas kesehatan.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Kesehatan

a. Telemedicine Mobile

Telemedicine Mobile adalah bentuk layanan kesehatan digital yang memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan berkomunikasi, berkonsultasi, mendiagnosis, dan memantau kondisi kesehatan melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Telemedicine Mobile memanfaatkan teknologi komunikasi seperti aplikasi berbasis internet, pesan singkat, panggilan video, dan platform berbasis cloud online, melalui video call atau telekonferensi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Telemedicine memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Di Indonesia, telemedicine telah menjadi solusi inovatif dalam menyediakan layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan yang sering mengalami hambatan akses. Contoh aplikasi telemedicine yang dikembangkan secara local di wilayah Jakarta yaitu JAKI (Jakarta Kini) yang memungkinkan warga Jakarta untuk melakukan konsultasi dengan dokter secara online.

1) Manfaat telemedicine mobile:

a) Mengatasi hambatan geografis

Layanan kesehatan mobile dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses, memastikan masyarakat mendapatkan perawatan yang diperlukan.

- b) Efisiensi biaya dan waktu
Mengurangi kebutuhan perjalanan jauh bagi pasien, menghemat biaya dan waktu.
 - c) Peningkatan kesadaran kesehatan
Memberikan edukasi kesehatan langsung kepada komunitas, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan.
- 2) Komponen Utama Telemedicine Mobile
- a) Platform atau Aplikasi: Aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Contoh fitur meliputi konsultasi virtual, pengelolaan data medis, dan pemberian resep digital.
 - b) Perangkat Seluler: Smartphone atau tablet dengan koneksi internet.
 - c) Sistem Manajemen Data: Basis data berbasis cloud untuk menyimpan rekam medis elektronik, catatan kesehatan, dan histori konsultasi pasien.
 - d) Integrasi AI dan IoT: Sensor kesehatan seperti smartwatch atau perangkat IoT lainnya sering kali diintegrasikan untuk memberikan data kesehatan real-time kepada tenaga medis.
- 3) Jenis Layanan dalam Telemedicine Mobile
- a) Konsultasi Virtual
Interaksi langsung melalui video call atau chat untuk konsultasi kesehatan.
 - b) Monitoring Jarak Jauh
Pengawasan kondisi kesehatan pasien dengan perangkat IoT seperti monitor tekanan darah atau kadar glukosa.
 - c) Manajemen Penyakit Kronis
Membantu pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi untuk memantau dan mengelola kondisi mereka.
 - d) Layanan Farmasi Digital
Pemesanan obat-obatan berdasarkan resep digital yang diberikan melalui konsultasi.
- 4) Keunggulan Telemedicine Mobile
- a) Aksesibilitas
Memungkinkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
 - b) Efisiensi Waktu dan Biaya
Mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan.
 - c) Personalisasi Layanan
Pemantauan kesehatan secara real-time memungkinkan pendekatan berbasis kebutuhan individu.

d) Keamanan Data

Dengan teknologi enkripsi, data pasien lebih aman dan mudah diakses hanya oleh pihak yang berwenang.

5) Tantangan dalam Implementasi Telemedicine Mobile

a) Ketersediaan Infrastruktur

Tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang memadai.

b) Keamanan dan Privasi Data

Risiko pelanggaran data dan keamanan informasi pasien.

c) Adaptasi Teknologi

Tidak semua pasien atau tenaga medis terbiasa menggunakan teknologi ini.

d) Regulasi

Peraturan mengenai penggunaan telemedicine dan validitas legal konsultasi jarak jauh masih berkembang di beberapa negara.

b. Penggunaan Wearable Devices

Memantau kondisi kesehatan pasien dari jarak jauh menggunakan perangkat seperti smartwatch untuk mendeteksi tanda vital atau gejala awal penyakit. *Wearable devices* berupa perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh (seperti jam tangan pintar, gelang kesehatan, atau alat lainnya) yang dilengkapi dengan sensor untuk mengukur dan memantau parameter kesehatan secara *real-time*. Teknologi ini semakin banyak digunakan dalam layanan kesehatan karena kemampuannya untuk memberikan data yang kontinyu, akurat, dan mudah diakses baik oleh pengguna maupun tenaga medis.

1) Peran Utama Wearable Devices dalam Layanan Kesehatan

Wearable devices atau perangkat yang dapat dikenakan, memiliki sejumlah fungsi penting dalam dunia kesehatan modern, antara lain:

a) Pemantauan kondisi kesehatan real-time

Memantau parameter seperti detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah (SpO2), kadar glukosa, dan pola tidur.

b) Pengelolaan penyakit kronis

Membantu pasien dengan penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular untuk memantau kondisi mereka dan mencegah komplikasi.

c) Pelacakan aktivitas fisik

Mengukur langkah harian, kalori yang terbakar, tingkat aktivitas, hingga pola latihan olahraga.

- d) Deteksi dini dan alarm kesehatan
Mengidentifikasi perubahan mendadak pada parameter vital (seperti aritmia atau saturasi oksigen rendah) dan memberikan notifikasi kepada pengguna atau tenaga medis.
 - e) Peningkatan Kepatuhan terhadap pengobatan
Wearable devices juga dapat mengirimkan pengingat pada pengguna untuk minum obat atau menghadiri janji medis/kontrol.
- 2) Contoh *Wearable Devices* yang digunakan di bidang kesehatan
- a) Smartwatch: Perangkat populer seperti Apple Watch, Fitbit, atau Samsung Galaxy Watch yang dilengkapi sensor untuk detak jantung, ECG (Electrocardiogram), hingga monitor oksigen darah.
 - b) Gelang Kesehatan (Fitness Tracker): Gelang seperti Xiaomi Mi Band atau Garmin yang fokus pada pelacakan aktivitas fisik dan kesehatan dasar.
 - c) Patch Medis: Patch yang ditempelkan pada kulit untuk memantau data vital seperti gula darah secara kontinu (contoh: FreeStyle Libre untuk diabetes).
 - d) Wearable ECG Monitor: Perangkat khusus untuk merekam aktivitas listrik jantung secara detail.
 - e) Smart Clothing: Pakaian dengan sensor tertanam untuk memantau aktivitas otot, detak jantung, dan pernapasan.
- 3) Keunggulan Penggunaan *Wearable Devices*
- a) Pemantauan non-invasif: banyak wearable yang memberikan data tanpa perlu prosedur invasif atau menyakitkan.
 - b) Portabilitas dan kenyamanan: desainnya kecil, ringan, dan dapat digunakan kapan saja.
 - c) Deteksi dini masalah kesehatan: memungkinkan deteksi dini kondisi serius seperti aritmia jantung atau hipoksia.
 - d) Personalisasi kesehatan: data yang dihasilkan memungkinkan pengguna dan tenaga medis untuk membuat keputusan kesehatan yang spesifik.
 - e) Pengintegrasian dengan telemedicine: data dari wearable dapat langsung diakses oleh dokter melalui platform telemedicine untuk diagnosa dan perawatan jarak jauh.
- 4) Tantangan dalam Penggunaan *Wearable Devices*
- a) Akurasi data: beberapa perangkat memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan alat medis konvensional.
 - b) Keamanan dan privasi data: risiko pelanggaran data pengguna, terutama jika perangkat terhubung ke internet.

- c) Biaya: wearable yang dilengkapi fitur canggih sering kali mahal dan kurang terjangkau untuk sebagian orang.
 - d) Ketergantungan teknologi: pengguna mungkin mengalami kesulitan jika tidak memiliki akses listrik atau internet.
 - e) Adaptasi pengguna: tidak semua pengguna terutama kalangan lansia nyaman menggunakan teknologi ini.
- 5) Contoh aplikasi penggunaan adalah
- a) Monitoring pasien COVID-19: beberapa wearable digunakan untuk memantau saturasi oksigen dan detak jantung pasien isolasi mandiri.
 - b) Pemantauan atlet profesional: digunakan untuk mengoptimalkan performa fisik dan mencegah cedera.
 - c) Pemantauan pasien post-operasi: untuk memastikan pemulihan pasien setelah prosedur medis tertentu.

c. Edukasi Kesehatan Melalui SMS dan Media Digital

Edukasi kesehatan yang disampaikan melalui SMS dan media digital menjadi salah satu metode promosi kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku sehat dengan cara yang efektif.

- 1) **Edukasi melalui SMS:** Pesan teks singkat yang digunakan untuk memberikan informasi penting tentang kesehatan, seperti pengingat jadwal imunisasi, tips kesehatan harian, atau informasi terkait penanganan penyakit tertentu. Keunggulan metode ini adalah aksesibilitasnya, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet.
- 2) **Edukasi melalui Media Digital:** berbagai platform seperti media sosial, aplikasi kesehatan, video pendek, infografis, hingga situs web digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Media digital memungkinkan komunikasi dua arah, misalnya melalui komentar atau diskusi online. Ini memperluas jangkauan edukasi dan memberikan fleksibilitas dalam format, seperti e-booklet, video tutorial, atau webinar

Keuntungan utama dari pendekatan ini meliputi jangkauan luas, biaya yang relatif rendah, dan kemampuan untuk menyediakan informasi kesehatan yang interaktif dan dapat diakses kapan saja. Namun, kelemahannya termasuk risiko penyebaran informasi yang kurang akurat dan kesenjangan akses bagi kelompok tertentu.

Implementasi layanan kesehatan mobile menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan ketersediaan tenaga profesional

yang berpengalaman menguasai teknologi informatika. Adapun untuk menghadapi tantangan tersebut maka upaya yang dilakukan adalah

1. Membangun ekosistem kolaborasi

Semua *stakeholders*, baik pemerintah pusat, pemerintah lokal, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan penyedia layanan e-health harus mengambil bagian dalam ekosistem *universal healthcare*.

Kolaborasi antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta juga dibutuhkan, dengan keunggulannya masing-masing, untuk menghasilkan perawatan kesehatan pasien yang lebih baik. Pemerintah pusat juga bisa mempertimbangkan insentif/dana kompensasi kesehatan untuk rumah sakit swasta yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Contoh kolaborasi sebagai penyedia solusi mobile kesehatan (*m-health*) dengan keterlibatan perusahaan swasta saat ini seperti Telkom Indonesia atau start-up seperti Halodoc dan Alodokter menyediakan solusi mobile untuk kesehatan, termasuk konsultasi daring dan pengiriman obat.

2. Kemitraan dengan Perusahaan Teknologi

Mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis data yang dapat diakses komunitas.

3. Dukungan Dana dari Pemerintah

Membiayai program layanan kesehatan mobile, terutama untuk daerah tertinggal.

4. Keterlibatan *Non-Governmental Organization* (NGO)

atau lembaga donor dalam mendukung layanan kesehatan gratis di daerah marginal merujuk pada partisipasi organisasi non-pemerintah dan lembaga pendanaan internasional atau lokal untuk menyediakan atau mendukung akses layanan kesehatan di wilayah dengan sumber daya terbatas. Contoh lembaga yang terlibat dalam layanan kesehatan gratis.

- a. Medecins Sans Frontieres (MSF) atau Dokter Lintas Batas: Memberikan layanan medis gratis di wilayah terdampak bencana dan konflik.
- b. UNICEF: Mendukung kesehatan anak melalui imunisasi dan program gizi.
- c. Global Fund: Membiayai program melawan HIV/AIDS, malaria, dan TBC di negara berkembang.
- d. BRAC: Fokus pada program kesehatan berbasis komunitas di Asia dan Afrika.

D. Kesimpulan

Penggunaan layanan kesehatan mobile (mHealth) telah menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di komunitas, khususnya di wilayah terpencil dan marginal. Aplikasi mHealth menyediakan

berbagai fitur seperti pencatatan data kesehatan, edukasi, pemantauan pasien, serta konsultasi medis secara daring. Layanan ini memberikan manfaat signifikan, di antaranya Peningkatan Aksesibilitas (memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk menerima layanan kesehatan tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan fisik), efisiensi dan kecepatan (mempercepat proses pencatatan dan pelaporan data kesehatan, serta mendukung respons cepat terhadap risiko kesehatan), edukasi dan kesadaran (menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat) dan ketersediaan data (meningkatkan kualitas dan akurasi data kesehatan yang dapat digunakan untuk perencanaan layanan di tingkat lokal maupun nasional).

Namun, tantangan seperti kesenjangan teknologi, literasi digital, dan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi perlu diatasi agar manfaat layanan mHealth dapat dirasakan secara merata. Kolaborasi antara pemerintah, NGO, lembaga donor, dan penyedia teknologi menjadi kunci keberhasilan implementasi mHealth di komunitas.

Melalui layanan kesehatan mobile, tercipta peluang untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Klasifikasi Desa (Persen) 2024. Badan Pusat Statistik Nasional. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQwMyMy/unmet-need-pelayanan-kesehatan-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>
- Hayati Fhitri, A. (2022). Analisis Pola Persebaran Dan Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Di Kota Tanjungpinang. Perpustakaan Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/11142/1/173410149.pdf>
- Shildam Niwa, A. S. (2024). Analisis Pola Sebaran Dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Masyarakat Terhadap Permukiman Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/119312>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pub. L. No. No.1335, 153 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019>

F. Glosarium

Aksesibilitas = ukuran kemudahan atau kenyamanan untuk mencapai suatu lokasi

Dimensi fisik = aspek-aspek fisik atau material yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan, yang berhubungan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan kenyamanan pasien.

Network Analysis = analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan, pola, dan interaksi dalam suatu jaringan (network).

Spatial Accessibility Analysis = analisis yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan atau kesulitan akses ke lokasi tertentu dalam suatu area geografis.

Nearest Neighbour Analysis = metode statistik spasial yang digunakan untuk mengukur pola distribusi titik-titik di suatu area geografis.

Moran's I, atau Ripley's K Functio = **metode statistik untuk mengukur autokorelasi spasial** yaitu sejauh mana nilai suatu variabel di lokasi tertentu dipengaruhi oleh nilai di lokasi-lokasi tetangganya dalam ruang geografis.

Wearable devices (perangkat yang dapat dikenakan) = perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan di tubuh manusia, baik sebagai aksesori, pakaian, atau bagian tubuh lainnya. Perangkat ini biasanya memiliki sensor, prosesor, dan kemampuan untuk terhubung ke internet atau perangkat lain untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data secara real-time.

UNICEF = organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi anak-anak di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang.

Global Fund = organisasi internasional yang berfokus pada pendanaan dan pemberantasan tiga penyakit utama: **HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria.**

BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) = organisasi pembangunan non-pemerintah terbesar di dunia, yang berbasis di Bangladesh yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dengan memberdayakan komunitas melalui program berkelanjutan.

CHAPTER 7

KAMPANYE KESEHATAN MELALUI KEGIATAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Syaiful, S.Kep., Ns., MPd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kampanye kesehatan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Melalui kegiatan sosial, kampanye ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesehatan. Dalam konteks ini, kegiatan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun solidaritas dan kolaborasi antar anggota komunitas. Menurut Brownson, Baker, dan Deshpande (2017), pendekatan berbasis bukti dalam kesehatan masyarakat sangat penting untuk merancang kampanye yang efektif, di mana data dan statistik dapat digunakan untuk mendukung intervensi yang diusulkan.

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil kesehatan secara keseluruhan. Sebuah studi oleh Wiggins (2018) menunjukkan bahwa komunitas yang aktif dalam kegiatan kesehatan memiliki angka prevalensi penyakit yang lebih rendah dibandingkan dengan komunitas yang kurang terlibat. Ini menunjukkan bahwa kampanye kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan sosial tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga dapat berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, tantangan dalam pelaksanaan kampanye kesehatan sering kali terkait dengan faktor budaya, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk merancang kampanye yang sensitif terhadap konteks lokal dan mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye sangat diperlukan. Wallerstein dan Duran (2017) menekankan pentingnya penelitian partisipatif berbasis komunitas, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil.

Kampanye kesehatan yang efektif juga harus didukung oleh strategi komunikasi yang tepat. McKenzie dan Pinger (2016) menyatakan bahwa penggunaan media sosial dan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan

kampanye kesehatan, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi dalam kampanye kesehatan melalui kegiatan sosial menjadi semakin relevan. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin digital, di mana informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas.

B. Konsep Kampanye Kesehatan

1. Definisi Kampanye Kesehatan:

- a. Kampanye kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan, serta mendorong perubahan perilaku yang positif. Menurut Brownson et al. (2017), kampanye kesehatan dapat dipahami sebagai usaha terstruktur yang melibatkan berbagai strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup mobilisasi komunitas untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan kesehatan.
- b. Kampanye kesehatan sering kali menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan dan efektif. Misalnya, sebuah studi oleh Wiggins (2018) menunjukkan bahwa kampanye yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang sepenuhnya top-down. Di dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kampanye kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
- c. Lebih lanjut, kampanye kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti kampanye pencegahan penyakit, kampanye promosi kesehatan, dan kampanye pengobatan. Setiap jenis kampanye memiliki tujuan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kampanye pencegahan penyakit seperti vaksinasi dapat membantu mengurangi angka kejadian penyakit menular, sedangkan kampanye promosi kesehatan lebih berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat (McKenzie & Pinger, 2016).
- d. Kampanye kesehatan yang efektif juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di lapangan. Penggunaan media sosial, khususnya, telah terbukti sangat efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam, terutama di kalangan generasi muda (McKenzie & Pinger, 2018). Oleh karena itu, pemilihan

saluran komunikasi yang tepat sangat penting dalam merancang kampanye kesehatan yang sukses.

Dengan memahami pengertian dan tujuan dari kampanye kesehatan, maka kita dapat lebih siap untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya meningkatkan kesehatan di tingkat komunitas.

2. Pentingnya Kampanye Kesehatan di Komunitas

Kampanye kesehatan di komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu alasan utama adalah karena komunitas merupakan unit sosial yang paling dekat dengan individu, sehingga pesan-pesan kesehatan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Menurut Laverack & Wallerstein (2016), kampanye kesehatan yang dilakukan di tingkat komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku kesehatan secara positif.

Statistik menunjukkan bahwa banyak masalah kesehatan yang dapat dicegah melalui intervensi di tingkat komunitas. Misalnya, data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 80% penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup, termasuk diet sehat dan aktivitas fisik yang cukup (WHO, 2020). Oleh karena itu, kampanye kesehatan yang menargetkan perubahan perilaku di komunitas menjadi sangat krusial.

Kampanye kesehatan juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan kesehatan yang ada di masyarakat. Kesenjangan ini sering kali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi akses individu terhadap layanan kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam kampanye kesehatan, kita dapat memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan lingkungan mereka (Wallerstein & Duran, 2017).

Selain itu, kampanye kesehatan di komunitas dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesehatan yang mungkin kurang diperhatikan. Misalnya, kampanye tentang kesehatan mental semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak kesehatan mental terhadap kualitas hidup individu. Kegiatan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong individu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan (Viswanath & Emmons, 2018).

Secara keseluruhan, pentingnya kampanye kesehatan di komunitas tidak dapat diremehkan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita tidak hanya

dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang dapat berdampak positif pada kesehatan individu dan komunitas secara keseluruhan.

3. Tujuan dan Manfaat Kampanye Kesehatan

Tujuan utama dari kampanye kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyebaran informasi dan promosi perilaku sehat. Melalui kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyakit. Menurut Bracht & Tsouros (2016), kampanye kesehatan yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, sehingga dapat dievaluasi keberhasilannya.

Salah satu manfaat signifikan dari kampanye kesehatan adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Misalnya, kampanye tentang pentingnya vaksinasi dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kejadian penyakit menular (McKenzie & Pinger, 2016). Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam mencari informasi dan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Selain itu, kampanye kesehatan juga dapat berkontribusi pada perubahan perilaku yang positif. Melalui edukasi dan penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat mengubah kebiasaan buruk, seperti merokok atau pola makan yang tidak sehat, menjadi kebiasaan yang lebih baik. Sebuah studi menunjukkan bahwa kampanye kesehatan yang berhasil dapat mengurangi tingkat merokok di kalangan remaja hingga 20% dalam waktu satu tahun (Suhardjo, 2012).

Manfaat lainnya dari kampanye kesehatan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam kampanye, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin atau program olahraga bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana individu merasa memiliki kendali atas kesehatan mereka sendiri (Laverack & Wallerstein, 2016).

Dengan demikian, kampanye kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Melalui tujuan yang jelas dan manfaat yang signifikan, kampanye kesehatan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kampanye Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kampanye kesehatan di masyarakat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemimpin dan motivator dalam upaya peningkatan kesehatan. Menurut McKenzie & Pinger (2016), tenaga kesehatan yang terlibat dalam kampanye kesehatan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan mereka.

Salah satu peran utama tenaga kesehatan adalah sebagai edukator. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis bukti kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan harus mampu menjelaskan isu-isu kesehatan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi audiens. Sebagai contoh, dalam kampanye pencegahan diabetes, tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan pentingnya aktivitas fisik (Bracht & Tsouros, 2016).

Selain itu, tenaga kesehatan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam mengorganisir kegiatan kampanye. Mereka dapat membantu merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas (Wiggins, 2018). Dengan keterlibatan aktif tenaga kesehatan, kampanye kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah.

Tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat tenaga kesehatan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti saran dan rekomendasi yang diberikan. Hal ini sangat penting dalam kampanye kesehatan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, seperti kesehatan mental atau penyakit menular (Viswanath & Emmons, 2018).

Terakhir, tenaga kesehatan juga dapat berperan sebagai penggerak perubahan dalam komunitas. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Misalnya, melalui kegiatan penyuluhan atau program dukungan sebaya, tenaga kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat di masyarakat (Wallerstein & Duran, 2017).

Dengan demikian, peran tenaga kesehatan dalam kampanye kesehatan sangatlah krusial. Mereka bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga

sebagai penggerak perubahan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

5. Strategi Pelaksanaan Kampanye Kesehatan di Komunitas

Strategi pelaksanaan kampanye kesehatan di komunitas harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menggunakan model ekologi dalam kesehatan masyarakat, yang menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka (McLeroy et al., 2017). Dalam konteks ini, strategi kampanye harus mencakup berbagai tingkat intervensi, mulai dari individu hingga kebijakan publik.

Pertama-tama, penting untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat sebelum merancang kampanye. Dengan memahami masalah kesehatan yang paling mendesak di masyarakat, kita dapat merancang pesan dan kegiatan yang lebih relevan dan berdampak. Misalnya, jika sebuah komunitas memiliki tingkat diabetes yang tinggi, kampanye kesehatan dapat difokuskan pada edukasi tentang pengelolaan diabetes dan pentingnya pola makan sehat (Sari, 2018).

Selanjutnya, penggunaan berbagai saluran komunikasi sangat penting dalam mencapai audiens yang lebih luas. Kampanye kesehatan yang efektif sering kali menggabungkan media tradisional, seperti poster dan brosur, dengan media digital, seperti media sosial. Hal ini memungkinkan pesan kesehatan untuk menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang (McKenzie & Pinger, 2018). Misalnya, kampanye yang memanfaatkan media sosial dapat lebih efektif dalam menjangkau generasi muda, sementara media cetak dapat lebih efektif untuk kelompok yang lebih tua.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye juga merupakan strategi yang sangat penting. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki kampanye tersebut dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Sebuah studi menunjukkan bahwa kampanye yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan efektivitas kampanye hingga 40% (Laverack & Wallerstein, 2016).

Selain itu, penting untuk mengukur dan mengevaluasi hasil dari kampanye kesehatan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk kampanye selanjutnya. Penggunaan indikator yang jelas dan terukur sangat penting dalam proses ini. Misalnya, jika tujuan kampanye adalah untuk meningkatkan angka vaksinasi, maka pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan angka vaksinasi sebelum dan sesudah kampanye (Brownson et al., 2017).

Dengan merancang strategi pelaksanaan yang matang dan melibatkan semua pihak, kampanye kesehatan di komunitas dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat.

6. Outcome Kampanye Kesehatan

Hasil dari kampanye kesehatan dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan. Sebuah studi menunjukkan bahwa kampanye kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tertentu hingga 50% dalam waktu singkat (Tanjung, 2016). Peningkatan pengetahuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong perubahan perilaku.

Selain peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi salah satu outcome yang diharapkan dari kampanye kesehatan. Misalnya, kampanye yang berfokus pada pencegahan penyakit jantung dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola makan sehat dan meningkatkan aktivitas fisik. Data menunjukkan bahwa kampanye yang berhasil dapat mengurangi tingkat merokok dan meningkatkan partisipasi dalam program olahraga (Halim, 2019).

Di samping itu, outcome kampanye kesehatan juga dapat dilihat dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ketika masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan, mereka cenderung lebih aktif dalam mencari layanan kesehatan yang diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit setelah kampanye kesehatan dilakukan (Rahman, 2017).

Tidak kalah pentingnya, kampanye kesehatan yang sukses juga dapat berkontribusi pada pengurangan angka kejadian penyakit di masyarakat. Misalnya, kampanye vaksinasi yang efektif dapat mengurangi angka kejadian penyakit menular, seperti campak dan rubella, secara signifikan. Data dari WHO menunjukkan bahwa kampanye vaksinasi yang dilakukan secara terencana dapat mengurangi angka kejadian penyakit menular hingga 80% (WHO, 2020).

Dengan demikian, outcome dari kampanye kesehatan tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup perubahan perilaku, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pengurangan angka kejadian penyakit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kampanye kesehatan yang dilakukan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

C. Referensi

- Brownson, R. C., Baker, E. A., & Deshpande, A. D. (2017). ***Evidence-Based Public Health***. New York: Oxford University Press.
- Wiggins, N. (2018). ***Community-Based Health Promotion: A Handbook for Practitioners***. New York: Springer.
- Bracht, N., & Tsouros, A. D. (2016). ***Health Promotion at the Community Level: New Advances***. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- McKenzie, J. F., & Pinger, R. (2016). ***An Introduction to Community Health***. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Laverack, G., & Wallerstein, N. (2016). ***Measuring Community Empowerment: A Fresh Look at the Community Empowerment Scale***. **Health Promotion International**, 31(3), 639-646.
- Viswanath, K., & Emmons, K. M. (2018). ***The Role of Social Capital in Health Promotion***. **American Journal of Public Health**, 108(1), 34-40.
- WHO. (2020). ***Vaccination Coverage***. Retrieved from [WHO website](https://www.who.int).
- Tanjung, N. (2016). **Kampanye Sosial untuk Kesehatan Masyarakat**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A. (2017). **Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan**. Jakarta: Kencana.
- Halim, A. (2019). **Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Manusia**. Surabaya: Airlangga University Press.

D. Glosarium

Kampanye Kesehatan: Serangkaian upaya terencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan tertentu dan mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat.

Kegiatan Sosial: Aktivitas yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, sering kali terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan.

Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program yang mempengaruhi kesehatan mereka.

Komunitas: Sekelompok orang yang tinggal di area geografis yang sama dan memiliki kepentingan atau tujuan yang sama.

CHAPTER 8

PERAN RELAWAN DALAM MENDUKUNG PROMOSI KESEHATAN DI KOMUNITAS

Sunarto, S.ST., Ners., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Sustainable Development Goal (SDGs) telah menetapkan beberapa tujuan, termasuk menurunkan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular hingga sepertiga angka kematian pada tahun 2030 (United Nation, 2016). Tujuan SDG adalah mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menetapkan visi dan misi yang tepat. Kementerian Kesehatan menetapkan visi Indonesia Sehat sebagai cara untuk mencapai salah satu tujuan SDGs, yaitu mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia. Termasuk di dalamnya bagaimana peran masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan serta upaya mengikutsertakan individu dan kelompok, yang didalamnya dengan memberikan keterbukaan bagi relawan yang akan bergabung (BPS., 2014).

Gambaran relawan dari setiap individu sangat bervariasi namun secara umum dapat diartikan individu atau kelompok orang yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, dan kemampuan mereka untuk membantu orang lain atau komunitas. Relawan tidak berharap mendapatkan imbalan. Menurut Pedoman Manajemen Relawan Palang Merah Indonesia, "Relawan adalah individu yang tidak harus menjadi anggota atau donor; dia berkontribusi terhadap organisasi dengan memberikan waktu dan keahliannya untuk pelayanan kerelawanan. Seorang Relawan dapat memilih untuk menjadi anggota". (PMI, 2018). Relawan dalam hal ini adalah seseorang yang secara sukarela untuk membantu yang berorientasi pada upaya promosi kesehatan. Keadaan riil di lapangan yang saat ini berkecimpung adalah kader kesehatan (Sistiarini, et al., 2012).

B. Perubahan sosial yang mendukung promosi kesehatan

Perubahan sosial yang tidak direncanakan maupun yang direncanakan dapat terjadi setiap waktu. Perubahan sosial yang direncanakan adalah jenis perubahan yang diantisipasi atau direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berusaha mengubah masyarakat (Sulaeman, 2016). Menurut Mardikanto, (2009), pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan direncanakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama

dengan seluruh warganya atau dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi tertentu, untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi. untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan seluruh masyarakat. Perubahan sosial disebabkan oleh perubahan dalam teknologi, lembaga sosial, populasi, dan lingkungan, baik secara individu maupun dalam beberapa kombinasi. Teknologi, institusi sosial, populasi, dan lingkungan adalah empat sumber perubahan sosial. Keempat aspek ini mungkin memengaruhi kapan dan bagaimana masyarakat mengalami perubahan. Selain itu, semuanya saling terkait: perubahan di satu wilayah dapat berdampak pada semua wilayah (Griffiths et al., 2017).

Segala perubahan pada institusi masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya disebut perubahan sosial (Sulaeman, 2016). Perubahan ini termasuk perubahan nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat di mana pun dan kapan pun. Setiap masyarakat manusia pasti mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya, yang terjadi dalam interaksi (pergaulan) antara sesama anggota masyarakat dan lingkungannya (Kasnawi & Asang, 2014). Landasan teori terkait perubahan sosial diantaranya:

1. Teori Perubahan Sosial Veblen (*Veblen's Theory of Social Change*)

Teori Veblen sebagai teori deterministik, menekankan pada faktor kebiasaan yang diartikan cara berpikir. Faktor lingkungan memainkan peran yang sangat jauh dalam membawa perubahan sosial. Secara langsung lingkungan juga mempengaruhi struktur sosial.

2. Teori Upaya Sistematis (*Theory of Systematic Effort*)

Teori ini menekankan percaya bahwa perubahan sosial tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi ada upaya materialistik maupun non-materialistik dan tidak membawa perubahan sosial atas kemenangan mereka. Upaya yang terarah dan penuh perhatian harus dilakukan untuk membawa perubahan sosial. Upaya tersebut meliputi penyebaran ilmu pengetahuan dan literasi. Upaya sadar secara terencana lebih efektif untuk membawa perubahan sosial daripada upaya yang tidak terencana dan tidak sistematis.

3. Teori fungsionalisme

Masyarakat tak ubahnya seperti sistem fungsi organ tubuh manusia, yaitu fungsi yang satu memengaruhi fungsi yang lain, sebaliknya disfungsi pada satu sistem mengakibatkan disfungsi pada sistem yang lain. Kelembagaan saling terkait dan tergantung satu sama lain, setiap kelembagaan dalam masyarakat memiliki fungsi yang jelas dan khas untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat.

Fungsi dasar ini oleh Parsons diistilahkan dengan functional prerequisite atau pra sejarah fungsional (Kasnawi & Asang, 2014). yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penyesuaian Diri

Setiap sistem sosial haruslah berkemampuan terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (adaptation). Dalam kehidupan masyarakat, fungsi adaptasi ini dijabarkan melalui berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntutan lingkungan.

b. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*)

Setiap sistem sosial harus memiliki suatu alat atau instrumen untuk memobilisasi sumber daya yang ada supaya tujuan kehidupan masyarakat dapat tercapai. penjabaran fungsi ini dalam kehidupan masyarakat yaitu adanya sistem politik, serta sistem penyatuan person dan wewenang masingmasing unsur masyarakat.

c. Fungsi Integrasi

Setiap sistem sosial harus berkemampuan mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagian (sub-subsistemnya), serta membangun cara-cara untuk mempertahankan kesatuannya (integrasi). Dalam kehidupan masyarakat fungsi ini dilakukan melalui pembentukan lembaga atau institusi-institusi kemasyarakatan.

d. Fungsi Pemeliharaan Pola Keseimbangan (*Pattern Maintenance*)

Setiap sistem sosial harus mampu mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang. Dalam kehidupan masyarakat, fungsi ini dilakukan dengan adanya sistem kontrak sosial. penetapan norma-norma, serta sistem hukum.

C. Promosi Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengadakan konferensi internasional pertamanya pada tahun 1986 untuk menciptakan Piagam Ottawa/Ottawa, mendukung bahwa promosi kesehatan adalah proses di mana orang dapat meningkatkan kontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Selanjutnya, pada tahun 2005, dalam Piagam Bangkok untuk Promosi Kesehatan di Dunia Global, konsep promosi kesehatan mendokumentasikan perubahan kecil dan menciptakan konsep promosi kesehatan sebagai proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol kesehatan dan faktor penentu dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka (Sulaeman, 2016).

Promosi kesehatan merupakan sebuah proses yang berusaha mendorong individu dan komunitas untuk memperbaiki tingkat kesehatannya atau proses yang

memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1148/MENKES/SK/VII/2005, promosi kesehatan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui proses belajar dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka mampu mandiri serta mengembangkan kegiatan yang berbasis sumber daya lokal, sesuai dengan budaya sosial setempat, didukung oleh kebijakan publik yang memperhatikan kesehatan. Kesehatan pribadi dan kesehatan komunitas mencerminkan kombinasi khas dari elemen biologis, psikologis, sosial, intelektual, dan spiritual, bersama dengan elemen budaya, ekonomi, dan lingkungan politik di mana individu tersebut berada. Pada tingkat yang lebih luas, penelitian tentang interaksi antara individu dan lingkungan mereka dalam konteks kesehatan menjadi perhatian utama dalam upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pandangan ekologi tentang kesehatan menyoroti interaksi antara berbagai faktor dalam permasalahan kesehatan (Sulaeman, 2021). Promosi kesehatan merupakan sebuah revitalisasi dalam pendidikan kesehatan, di mana fokus promosi kesehatan tidak hanya pada kesadaran, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat (Nurmala, 2018).

Upaya promosi kesehatan akan menjadikan individu, keluarga, populasi, dan komunitas dapat menerapkan dan mengadopsi gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan, Diantaranya (Buckner et al., 2022) :

1. Mengembangkan kebijakan publik yang baik. Promosi kesehatan berfokus pada pembuatan kebijakan di berbagai sektor, guna memahami beban penyakit yang dialami individu, keluarga, populasi, dan masyarakat. Promosi kesehatan mencakup penentuan kendala dalam penerapan regulasi yang sehat dengan harapan untuk menciptakan opsi yang lebih sehat dan menarik bagi para pembuat kebijakan.
2. Membangun suasana yang mendukung. Promosi kesehatan perlu menciptakan lingkungan hidup yang aman, menggairahkan, dan menyenangkan.
3. Peningkatan tindakan masyarakat. Promosi kesehatan beroperasi melalui langkah-langkah konkret dan berpengaruh di antara semua pihak dalam masyarakat untuk menentukan prioritas, membuat keputusan, memilih pendekatan, dan melaksanakan strategi guna meningkatkan kesehatan. Peningkatan masyarakat memerlukan pemanfaatan sumber daya manusia dan material yang tersedia dalam jaringan masyarakat untuk memperbaiki dan memperluas struktur yang dapat beradaptasi demi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam isu kesehatan.
4. Meningkatkan kemampuan individu. Promosi kesehatan berkontribusi pada perkembangan individu dan masyarakat dengan menyediakan informasi

mengenai kesehatan dan penyakit serta cara-cara untuk meningkatkan keterampilan hidup.

5. Perubahan arah layanan kesehatan promosi kesehatan adalah tanggung jawab bersama, semua individu harus berkolaborasi untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkontribusi dalam mencapai kesehatan menyeluruh. Pelayanan kesehatan perlu peka dan menghargai keinginan budaya untuk membantu individu dalam mencapai kehidupan yang lebih sehat serta membangun komunikasi yang baik antara sektor kesehatan dan lembaga.

Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat hidup sehat serta mengembangkan upaya kesehatan yang berasal dari masyarakat, sekaligus mewujudkan dan mendorong terciptanya kemampuan tersebut (Sulaeman, 2021). Misi promosi kesehatan telah di rumuskan berdasarkan Piagam Ottawa yaitu sebagai berikut:

1. Advokasi

Advokasi kesehatan dimanfaatkan untuk membangun situasi yang mendukung kesehatan, mengembangkan advokasi yang inklusif dan demokratis, serta menyediakan ruang untuk proses pembelajaran. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa program kesehatan memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan atau keputusan dari pejabat tersebut (Jatmika et al., 2019).

2. Mediasi

Kegiatan promosi kesehatan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dari sektor kesehatan, sehingga promosi kesehatan berperan sebagai jembatan antara kesehatan dan sektor lainnya.

3. Memampukan

Kegiatan promosi kesehatan perlu memberikan keterampilan di bidang kesehatan serta bidang lainnya kepada masyarakat, agar mereka dapat mengendalikan faktor penentu yang mempengaruhi kesehatan mereka. Dengan cara itu, masyarakat bisa menjadi lebih mandiri.

Strategi peningkatan kesehatan yang dapat di lakukan guna mendukung promosi kesehatan di komunitas antara lain :

1. Advokasi

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan saat memberikan bantuan kepada masyarakat. Advokasi adalah usaha untuk meyakinkan orang lain untuk memberikan bantuan atau dukungan terhadap tujuan yang diinginkan, melalui pendekatan kepada para pengambil keputusan atau pemangku kepentingan sehingga mereka bersedia mendukung program kesehatan yang akan diajukan.

2. Dukungan sosial

Dukungan dari masyarakat, baik dari aspek informal (pemimpin adat, pemimpin agama) maupun formal (tenaga kesehatan, pemerintah), menjadi krusial dalam aktivitas promosi kesehatan. Tujuan dari hal ini adalah agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan komunitas (*empowerment*)

Strategi ini adalah usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pengetahuan, niat, serta keterampilan individu, keluarga, dan masyarakat supaya dapat mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Masyarakat diharapkan turut serta secara aktif dalam pengelolaan kesehatan. Proses pembangunan diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada manusia (*people-centered development*). Oleh karena itu, masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Ini memerlukan proses pengembangan kapasitas yang berlandaskan pengetahuan dan sumber daya setempat, yang merupakan perpaduan antara konsep partisipasi, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, dan pengetahuan lokal. Terdapat banyak tulisan yang membahas mengenai partisipasi dalam proses pemberdayaan. Para pakar sepakat bahwa elemen utama dari partisipasi adalah pengambilan keputusan. Masyarakat dianggap berpartisipasi apabila secara kognitif, afektif, dan fisik mereka memilih untuk berkontribusi dalam proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan baik nasional maupun lokal. Jadi, partisipasi dapat dipandang sebagai proses pengambilan keputusan di tingkat pribadi dan masyarakat. Jika komunitas dapat mengambil keputusan penting demi kepentingan mereka sendiri, mereka harus diberdayakan.

Caring, holisme dan ekologi merupakan beberapa hal pengembangan dari teknik promosi kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Komunikasi tentang kesehatan.

Komunikasi kesehatan dibutuhkan dalam upaya promosi kesehatan, meliputi teknik lisan dan tulisan untuk meyakinkan serta memberdayakan individu, populasi, dan kelompok untuk mengambil keputusan yang sehat. Metode yang diterapkan adalah:

- a. Pemanfaatan metode yang didasarkan pada bukti untuk menciptakan bahan dan produk serta untuk menentukan saluran yang dipakai untuk menyampaikan produk ini kepada orang-orang.
- b. Mengerti kebijaksanaan lokal, gagasan, istilah, dan nilai budaya serta konteks tertentu.

- c. Faktor kesadaran kesehatan, akses internet, paparan media, dan kemampuan budaya kelompok sasaran.
- d. Pembuatan brosur, spanduk, artikel koran, tayangan TV, iklan radio, dan media lainnya.

2. Pendidikan mengenai kesehatan.

Pendidikan kesehatan merupakan pendekatan ilmu sosial yang menggabungkan ilmu medis dan disiplin lainnya untuk meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Metode dalam pendidikan kesehatan mencakup: keterlibatan populasi yang dituju, melakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk mengenali kemampuan, sumber daya, prioritas, serta keinginan masyarakat; kegiatan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan informasi dan kemampuan para peserta; memanfaatkan pembelajaran dan materi untuk menerapkan program yang mudah diakses oleh peserta; presentasi fakta melalui media multimedia; serta pelatihan untuk staf.

3. Perbaikan kebijakan.

Kebijakan sangat penting untuk mendorong dan mendukung kesehatan serta pencegahan penyakit.

4. Perubahan Sistem

Ini merujuk pada perubahan signifikan dalam metode penyelesaian masalah, seperti merancang rencana untuk intervensi dan strategi baru, mengadaptasi atau meniru model promosi kesehatan yang telah teruji dan terbukti, menggunakan teknologi canggih, serta mengembangkan program pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan.

5. Perubahan pada lingkungan.

Lingkungan yang dipakai untuk mendorong kesehatan mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang berdampak pada manusia. Strategi untuk mempromosikan kesehatan.

Promosi kesehatan berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan, yang meliputi berbagai aspek, seperti perilaku, keyakinan, praktik, lingkungan, komunitas, dan budaya individu. Oleh karena itu, menurut Buckner et al., (2022), pendekatan yang digunakan dalam promosi kesehatan adalah:

1. Pendekatan kesehatan

Pendekatan ini menekankan pada penurunan morbiditas dan mortalitas dengan kegiatan yang ditujukan kepada seluruh populasi atau kelompok berisiko tinggi, serta berfokus pada individu yang mengalami penyakit. Metode ini meliputi pendekatan utama, sekunder, dan tersier. Sure! Please provide the text you'd like me to paraphrase.

2. Metode perilaku

Pendekatan ini beranggapan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demi meningkatkan kesehatan mereka serta memilih gaya hidup sehat. Oleh karena itu, tujuan dari pendekatan perilaku adalah mendorong orang untuk menerapkan perilaku sehat dan memandang kesehatan sebagai tanggung jawab pribadi. Pendekatan yang digunakan adalah top-down yang dipandu oleh para ahli, menggarisbawahi perbedaan antara tenaga kesehatan dan masyarakat luas yang memerlukan pendidikan serta konsultasi. Intervensi menekankan pada keperluan klien. Metode dalam pendekatan perilaku meliputi komunikasi, persuasi, edukasi, dan motivasi

3. Metode pembelajaran

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyediakan informasi dan fakta serta mengasah keterampilan yang relevan agar individu dapat membuat keputusan yang berpengetahuan tentang kesehatannya. Tujuan dari metode pengajaran adalah memberikan informasi kepada individu agar mereka dapat membuat keputusan sendiri mengenai perilaku kesehatan mereka. Pendekatan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa akses informasi dapat membantu mengubah dan mengubah perilaku. Saat individu memiliki pengetahuan yang mendalam, mereka dapat membuat keputusan yang jelas dan diterima oleh para ahli kesehatan serta masyarakat. Teori belajar dalam psikologi mengidentifikasi tiga elemen dalam pendekatan pendidikan, yaitu pengetahuan dan pemahaman (kognisi), sikap dan emosi (pengaruh), serta keterampilan (perilaku). Metode yang bisa diterapkan dalam pendekatan pendidikan meliputi:

- a. Penyerahan informasi melalui saluran pribadi, kelompok kecil, dan media publik,
- b. Iskusi kelompok untuk berbagi serta mengeksplorasi sikap kesehatan,
- c. Simulasi peran untuk pengambilan keputusan dan negosiasi (Resident Notes, 2001).

4. Strategi pemberdayaan

Metode pemberdayaan berupaya memungkinkan individu dan kelompok untuk mengendalikan kesehatan mereka sendiri dan membuat keputusan terkait kesehatan, serta mendukung pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pemberdayaan meliputi dua aspek, yaitu penguatan diri dan penguatan komunitas. Metode dalam pemberdayaan mencakup:

- a. Fokus pada klien, seperti konseling, pengembangan komunitas, dan advokasi;
- b. Advokasi kesehatan;

- c. Memfasilitasi keterlibatan publik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai isu yang berhubungan dengan kesehatan (Resident Notes, 2001).

5. Metode pergeseran sosial

Metode ini menitikberatkan pada transformasi sosial melalui modifikasi lingkungan fisik, sosial, dan keuangan untuk menciptakan suasana yang mendorong pembangunan kapasitas promosi kesehatan, dengan cara yang mudah dipahami.

D. Pengembangan Promosi Kesehatan

Pengembangan dewasa ini yang sedang trend adalah media. Perkembangan promosi kesehatan di era digital saat ini meningkat pesat, di antaranya melalui media smartphone (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016). Alat ini mempermudah distribusi informasi mengenai kesehatan. Keunggulan dalam memanfaatkan media antara lain (Jatmika et al., 2019):

1. Media memudahkan proses penyampaian informasi.
2. Media dapat memperjelas pemahaman yang disampaikan.
3. Media dapat mempermudah komunikasi dan mengurangi verbalitas.

Sedangkan Kriteria untuk media promosi kesehatan meliputi:

1. Teknologi, teknologi yang gampang diakses dan mudah untuk digunakan.
2. Akses, media promosi kesehatan harus mudah dijangkau oleh pengguna.
3. Biaya, cost harus diperhitungkan pada media yang dipakai.
4. Interaktivitas, media bisa menciptakan interaksi.
5. Organisasi, terdapat dukungan dari lembaga atau instansi yang menggunakan media.
6. Keunikan, media mempunyai inovasi yang akan diterapkan, yang berarti bahwa media dengan model yang lebih baru akan semakin menarik.

E. Hambatan dalam Promosi Kesehatan Komunitas

Pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan di komunitas tentunya mempunyai hambatan, meliputi; sarana, pengetahuan, dan budaya. Beberapa Hambatan terkait sarana meliputi sarana dan peralatan yang tidak sesuai standar, sumber daya kesehatan yang minimal dan tidak sesuai dan aksesibilitas terhadap program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang rendah. Sudut pandang hambatan pengetahuan meliputi kurangnya pengetahuan tentang strategi promosi kesehatan kurangnya pelatihan sebagai wadah update keilmuan. Gambaran riil terkait hambatan budaya antara lain Pola pikir masyarakat dengan adanya mitos, Norma budaya dan sosial seputar perilaku kesehatan, Tingkat literasi kesehatan yang

rendah, Kesenjangan bahasa dan pendidikan. Hambatan anggaran terkait program yang tidak memadai dan terbatas. Tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dengan melatih tenaga kesehatan secara berkala
2. Program kerjasama dengan membentuk aliansi internal dan eksternal supportif
3. Peningkatan teknologi dengan memanfaatkan secara efektif
4. Peningkatan Kualitas di pelayanan di fasilitas kesehatan primer
5. Peningkatan kapasitas tenaga relawan
6. Peningkatan kerjasama dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara komprehensif dalam program-program kesehatan

F. Kesimpulan

Promosi kesehatan komunitas sangat memerlukan relawan yang handal dan berkesinambungan. Hal ini sangat perlu di topang dengan upaya peningkatan kapasitas baik dari mentor dan relawan itu sendiri. Pada sisi tertentu perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi relawan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dengan muar akhir meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin.

G. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Badan Pusat Statistik*, 0–44. Jakarta
- Buckner, C. A., Lafrenie, R. M., Dénommée, J. A., Caswell, J. M., Want, D. A., Gan, G. G., Leong, Y. C., Bee, P. C., Chin, E., Teh, A. K. H., Picco, S., Villegas, L., Tonelli, F., Merlo, M., Rigau, J., Diaz, D., Masuelli, M., Korrapati, S., Kurra, P., ... Mathijssen, R. H. J. (2022). Health Promotion. *Intech, 11*(tourism), 13. <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics>
- Departemen Kesehatan RI. (2009). *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Depkes RI
- Husodo, B. T., Handayani, N., & ... (2021). Media Edukasi Promosi Kesehatan Melalui Film Dalam Menumbuhkan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Kesehatan Reproduksi . <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/28846>
- Jatmika, septian emma dwi, Maulana, M., Kuntoro, & Martini, S. (2019). Pengembangan Media Promosi Kesehatan. In *Buku Ajar*
- Kasnawi, M. T., & Asang, S. (2014). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. In: *Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial*. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4267/>
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan*

- Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.* , (2013).
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu* (Vol. 4, pp. 64–75). Vol. 4, pp. 64–75. Retrieved from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._19_ttg_Sistem_Penanggulangan_Gawat_Darurat_Terpadu_.pdf
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Retrieved from www.cvalfabeta.com
- Nurdyansyah, & Fahyuni, E. F. (2016). Inovasi Model. In *Nizmania Learning Center*
- Nurmala, Ira, D. (2018). *Promosi Kesehatan*(Vol. 5, Issue 3). pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga.
- Palang Merah Indonesia (2008). *Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR)*. Jakarta: Palang Merah Indonesia
- Resident Notes. (2001). Approach to Health Promotion. *Framework, 1998*, 10–11.
- Sistiarini, C., Siti Nurhayati & Suratman (2012). Peran Kader dalam Penggunaan Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* vol.8 No.2, 2013
- Sulaeman, E. (2013). *Promosi Kesehatan Teori dan Implementasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Sulaeman, E. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran dalam Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Sulaeman, E. (2016). *Pembelajaran Model dan Teori Promosi dan Perilaku Kesehatan Konsep dan Aplikasi*. Surakarta: UNS Press.
- Sulaeman, E. S. (2016a). *Pembelajaran Model dan Teori Perilaku Kesehatan. Konsep dan Aplikasi*. Retrieved from www.unspress.uns.ac.id
- Sulaeman, E. S. (2016b). *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan. Teori dan Implementasi*. Retrieved from www.gmup.ugm.ac.id
- Sulaeman, E. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sulaeman, E. S. (2021). *Buku _ Pendidikan dan promosi Kesehatan*. Gadjahmada University Press.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). *smartphone. Suparyanto Dan Rosad (2015, 235 5(3), 248–253.*
- Tessaro, I. A., Taylor, S., Belton, L., Campbell, M. K., Benedict, S., Kelsey, K., & DeVellis, B. (2000). Adapting a natural (lay) helpers model of change for worksite health promotion for women. *Health Education Research, 15(5)*, 603–614. <https://doi.org/10.1093/her/15.5.603>
- Tobing, U., F. Nugroho, & E.S. Tehuteru (2008). Peran Relawan dalam Memberikan

Pendampingan kepada Anak Penderita Kanker dan Keluarganya.
Indonesian Journal of Cancer Vol.1 No.35 hal.35-39

United Nation. (2016). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1201/b20466-7>

H. Glosarium

BPS : Badan Pusat Statistik

SDGs : *Sustainable Development Goal*

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom., Lahir di Garut, 15 Juli 1964, menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan di UNINUS Bandung, Sarjana Keperawatan di PSIK FK Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di FIK Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan Doktor Bidang Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pengalaman mengajar dimulai sejak tahun 1988 dalam berbagai bidang keperawatan

seperti Keperawatan Dasar, Falsafah dan Teori Keperawatan, Kebijakan Kesehatan dengan bidang utamanya Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Komunitas. Penulis juga aktif sebagai peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, penulis buku serta narasumber terkait pengembangan keperawatan kesehatan komunitas dan penjaminan mutu Pendidikan tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui email: supriadifalah@gmail.com. Pesan untuk pembaca: Dengan membaca, tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga merajut mimpi.



Orisinal, SKM., M.Kes., Lahir di Pariaman, 30 September 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2003. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990 sebagai pelaksana di Puskesmas Blangpidie Kabupaten Aceh Selatan, kemudian tahun 2006 sebagai Kasie Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh

Selatan, selanjutnya Tahun 2013 sebagai Kabid Pembinaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Sejak Tahun 2015 sampai sekarang penulis bekerja sebagai dosen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh Kampus Prodi Keperawatan Aceh Selatan mengampu mata kuliah Agama, Gizi dan Diet, Metodologi Penelitian, Metodologi Penulisan KTI, dan Keperawatan Komuntas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: oriebasri@gmail.com Motto: "Alhamdulillah 'ala Kulli Haal (Bersyukur apapun keadaannya)"

PROFIL PENULIS



Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM., Lahir di Pekanbaru, 19 Juni 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Riau, lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hanguah Pekanbaru, pada program studi magister kesehatan Masyarakat dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan penulis yaitu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, menjadi dosen tetap di Program Studi Keperawatan STIKes Pekanbaru Medical Center . Saat ini penulis mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, Promosi dan pendidikan kesehatan, dan Ners Edukatif yang menjadi keunggulan Program Studi Keperawatan di STIKes PMC. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan anggota organisasi profesi perawat komunitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nersiweek@gmail.com

Motto: "Love Your Self"



Berta Afriani, S.K.M., M.Kes., Lahir di Sepancar, 29 April 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Al-Ma'arif tahun 1996, jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Al-Ma'arif tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 di Akademi Keperawatan Al-Ma'arif sampai sekarang dan telah menjadi STIKes Al-Ma'arif Baturaja. Saat ini penulis bekerja di Program Studi DIII Keperawatan

STIKes Al-Ma'arif Baturaja mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, ilmu Biomedik Dasar, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: afrianiberta974@gmail.com

Motto: "Keberhasilan dimulai dari keyakinan pada diri sendiri"

PROFIL PENULIS



Syahrul, SKM., M.Kes., Lahir di Pariaman, 03 Oktober 1962. Lulus Sekolah Pembantu Perawatan umum (CP Akper) tahun 1982 Langsung mengabdikan Puskesmas Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman setelah itu baru melanjutkan ke Akper Depkes Otten Bandung tahun 1988, S1 Kesehatan Masyarakat FKM USU Medan Tahun 1993, dan S2 Kesehatan Masyarakat FKM UI Jakarta Tahun 2004. Mengawali karier sebagai PNS di Puskesmas pada tahun 1982 sampai mengakhiri pengabdian sebagai ASN dengan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun 2022, karena ketertarikan kepada dunia pendidikan diawali sebagai Guru Tidsak Tetap di Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Kabupaten Pariaman, Dosen dan Ketua Pada Stikes Nantongga Lubuk Alung dan Saat ini setelah PurnaBakti mengabdikan purnawaktu sebagai Ketua Stikes Piala Sakti Pariaman. Penulis juga sebagai pengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keselamatan Pasien dan K3 serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan.. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Selain itu sebagai insan perawat mengembangkan organisasi PPNI di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman selaku ketua DPD dan terakhir saat ini duduk sebagai Dewan Pertimbangan DPW PPNI Propinsi Sumatera Barat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syahrul.mkes@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Arriani Indrastuti, S.KM., M.Kes., Lahir di Tegal , 05 Maret 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhamada Slawi mengampu mata kuliah Manajemen Patient Safety, Promosi Kesehatan dan Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arrianiindrastuti0@gmail.com

Motto: "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow."

PROFIL PENULIS



Syaiful, SPd., SKep., Ns., MPd., MKes., Lahir di Bima-NTB, , 23 Mei 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Adibwana Surabaya dengan gelar M.Pd pada tahun 2009 sedangkan gelar M.Kes diraih pada universitas Badaruddin Lombok Tengah NTB lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 Prodi Keperawatan Bima

Akper Depkes Mataram NTB sampai saat ini sudah dikonversi menjadi Poltekkes Kememkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB mengampu mata kuliah Metodologi penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, nara sumber berbagai workshop, dll, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syaiful6823@gmail.com

Motto: "Belajar adalah jendela menuju masa depan; setiap langkah kecil hari ini membuka pintu besar esok hari."



Sunarto, S.ST., Ners., M.Kes., lahir di Ponorogo, 17 Desember 1975. Beralamat RT02 RW 02 Karangasem, Laweyan, Surakarta. Riwayat pendidikan terakhir adalah Magister Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Lulus tahun 2012. Saat ini masih melanjutkan pendidikan pada Program Pendidikan Doktoral (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Karir bekerja 1994 s/d 2009 menjadi tenaga Paramedis di Instalasi Bedah Sentral

(IBS) Rumah Sakit Swasta di Surakarta. Sejak 2008-Sekarang Berkarir sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta (Polkesta) sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen dengan Jabatan Lektor. Mata kuliah yang diampu oleh penulis diantaranya adalah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana, Keperawatan Ortopedi, Farmakologi Dasar bagi Paramedis, Manajemen *Patient Safety*, Keperawatan Medikal Bedah dan Promosi Kesehatan. Beberapa karya Ilmiah dan HKI dapat dilihat melalui google scholar atau lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sunarto_sst@yahoo.com. Motto: "Sharing is the way to success"

Sinopsis

Buku "**Promosi Kesehatan di Komunitas: Pendekatan, Peran, dan Strategi**" hadir untuk memberikan panduan lengkap tentang bagaimana promosi kesehatan dapat dilakukan secara efektif di tingkat komunitas. Buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat, dengan melibatkan peran serta tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, yang memiliki peran strategis dalam memimpin perubahan.

Dimulai dengan pembahasan tentang **pendekatan pendidikan kesehatan untuk masyarakat berisiko**, buku ini menyoroti pentingnya memberikan informasi yang relevan kepada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan, sehingga mereka dapat mengadopsi pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, **peran perawat komunitas** dalam membimbing masyarakat untuk mengubah perilaku hidup sehat dibahas dengan memberikan contoh praktik terbaik serta cara-cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini membahas **pengembangan materi edukasi visual** sebagai salah satu metode efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Dengan memanfaatkan gambar, infografis, dan media visual lainnya, informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, buku ini juga mengangkat **strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat**, dengan memanfaatkan berbagai metode dan platform yang dapat menginspirasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan. **Promosi kesehatan mental** juga menjadi sorotan penting dalam buku ini, dengan fokus pada peran perawat dalam mengurangi stigma terkait gangguan mental, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu dengan masalah kesehatan mental.

Buku ini juga memperkenalkan **layanan kesehatan mobile**, yang memungkinkan akses kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani. Selain itu, **kampanye kesehatan melalui kegiatan sosial** di masyarakat menjadi cara efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan secara langsung dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perubahan yang lebih sehat.

Terakhir, buku ini juga mengulas **peran relawan** dalam mendukung promosi kesehatan di komunitas. Relawan memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan program kesehatan dan membantu mendorong perubahan perilaku sehat di masyarakat.

Buku ini merupakan sumber yang berharga bagi perawat, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya promosi

kesehatan di komunitas. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara berbagai pihak, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Buku "Promosi Kesehatan di Komunitas: Pendekatan, Peran, dan Strategi" hadir untuk memberikan panduan lengkap tentang bagaimana promosi kesehatan dapat dilakukan secara efektif di tingkat komunitas. Buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat, dengan melibatkan peran serta tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, yang memiliki peran strategis dalam memimpin perubahan.

Dimulai dengan pembahasan tentang pendekatan pendidikan kesehatan untuk masyarakat berisiko, buku ini menyoroti pentingnya memberikan informasi yang relevan kepada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan, sehingga mereka dapat mengadopsi pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, peran perawat komunitas dalam membimbing masyarakat untuk mengubah perilaku hidup sehat dibahas dengan memberikan contoh praktik terbaik serta cara-cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini membahas pengembangan materi edukasi visual sebagai salah satu metode efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Dengan memanfaatkan gambar, infografis, dan media visual lainnya, informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, buku ini juga mengangkat strategi kreatif dalam kampanye hidup sehat, dengan memanfaatkan berbagai metode dan platform yang dapat menginspirasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan mental juga menjadi sorotan penting dalam buku ini, dengan fokus pada peran perawat dalam mengurangi stigma terkait gangguan mental, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu dengan masalah kesehatan mental.

Buku ini juga memperkenalkan layanan kesehatan mobile, yang memungkinkan akses kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani. Selain itu, kampanye kesehatan melalui kegiatan sosial di masyarakat menjadi cara efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan secara langsung dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perubahan yang lebih sehat.

Terakhir, buku ini juga mengulas peran relawan dalam mendukung promosi kesehatan di komunitas. Relawan memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan program kesehatan dan membantu mendorong perubahan perilaku sehat di masyarakat.

Buku ini merupakan sumber yang berharga bagi perawat, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya promosi kesehatan di komunitas. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara berbagai pihak, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-01-5



9

786347

219015